

Anlagenkonvolut

zum Wortprotokoll der 7. Sitzung
des Ausschusses für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
am 6. Oktober 2025

Dem Ausschuss wurden die vorliegenden Dokumente in nicht barrierefreier Form
zugeleitet.

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Ausschussdrucksache 21(13)9a-neu
vom 29. September 2025

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefach-
assistenzausbildung“

BT-Drucksache 21/1493

Isabel Kalberlah

Hans-Weinberger-Akademie der AWO e. V.

Name: Isabel Kalberlah
Hans-Weinberger-Akademie
der AWO e.V.
Zeichen: IK
Telefon: 0911 74097-32
E-Mail: I.Kalberlah@hwa-online.de

Datum: 29. September 2025

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenten-ausbildung (Pflegefachassistenteneinführungsgesetz – PflAssEinfG)

Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 06. Oktober 2025 zur Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung.

I. Allgemein:

Ziel, Struktur und Aufbau:

Begrüßenswert ist die Struktur und der Aufbau des PflAssEinfG in der Vergemeinschaftung der Regelung für die pflegerischen Berufe auf Bundesebene.

Trotz eines hohen Bedarfs an qualifiziertem Personal unterhalb der Pflegefachausbildung sprechen wir uns als HWA für die Einführung der bundeseinheitlichen 18-monatigen Pflegefachassistentenausbildung aus. Das Kompetenzprofil der Pflegefachassistentenausbildung ergibt im Qualifikationsmix der professionellen Pflege eine stimmige Ergänzung, zudem eröffnet sie weiteren Zielgruppen Bildungswege, die bislang noch keinen flächendeckenden Zugang zu einer beruflichen Ausbildung hatten. Die Pflegefachassistentenausbildung trägt so zu mehr Versorgungssicherheit bei und führt zu mehr Bildungschancen, Sinnstiftung und Aufstiegsmöglichkeiten, was wir als HWA sehr begrüßen.

Hans-Weinberger-Akademie
der Arbeiterwohlfahrt e. V.
Landsberger Str. 398 • 81241 München
Tel. +49 89 863009-0
Fax +49 89 863009-18

Vertretungsberechtigter Vorstand:
Mona Frommelt (Vorsitz),
Dr. Claus Heislbeitz

Stadtsparkasse München
Konto Nr.: 23 156 060
BLZ: 701 500 00
IBAN: DE78 7015 0000 0023 1560 60
BIC: SSKMDEMMXXX
Steuer-Nr.: 143/216/60399
UST-IdNr.: DE169257519
Amtsgericht München, VR 10196



Die Geschäftsführung und die Verwaltung der Hans-Weinberger-Akademie der AWO e.V. sind zertifiziert nach ISO 9001.



Die Hans-Weinberger-Akademie der AWO e.V. ist mit ihren Standorten nach AZAV zertifiziert.

WWW.HWA-ONLINE.DE

Dauer der Ausbildung und Kompetenzprofil:

Gleichzeitig besteht die Einschätzung, dass die neue Pflegefachassistentenausbildung mit dem hinterlegten Kompetenzprofil nicht anschlussfähig ist an die Voraussetzungen der heterogenen Zielgruppen, die Zugang zur Ausbildung erlangen können. Daher ist auch eine Verlängerung der Ausbildungsdauer von 18 auf 24 Monate aus pädagogisch-didaktischer als auch aus qualitativer Perspektive begrüßenswert.

Weiterhin ist sicherzustellen, dass weder die Schüler*innen noch die Absolvent*innen der Pflegefachassistentenausbildung in ihrem Berufsalltag überfordert werden. Die Vorbehaltsaufgaben der generalistischen Pflegefachperson nach §4 PflBG ermöglichen es der Pflegefachperson, Assistenzpersonen in der Pflege nach ihren informellen und formellen Kompetenzen so einzusetzen, dass sie den Pflegeprozess, von der Pflegefachperson geführt, unterstützen können. Um dies zu ermöglichen, bedürfen Teile des Kompetenzprofils der Pflegefachassistentenpersonen nach dem vorliegenden Entwurf, mit denen der Pflegefachpersonen einer konkreten Differenzierung. Die nachhaltige Etablierung der beruflichen Pflege auf dem Assistenzniveau hat eine hohe gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Es erscheint daher geboten, eine größtmögliche Trennschärfe der jeweiligen Kompetenzprofile herbeizuführen, ohne jedoch in kleinteilige Aufgaben- und Tätigkeitskataloge zu verfallen. In der Ausbildung von Assistenzpersonen der Pflege muss weiterhin eine angemessene sozialpädagogische und sprachliche Unterstützung vorgesehen werden, damit Ausbildungsabbrüche verhindert werden können. Sprache ist eine zentrale Grundlage pflegerischer Qualität – ausbildungsbegleitendem Sprachunterricht kommt daher angesichts eines hohen und weiterhin steigenden Anteils an Schüler*innen mit Migrationshintergrund eine sehr hohe Bedeutung zu und ist in den Pauschalen zusätzlich einzurechnen.

Harmonisierung der Ausbildungsgänge an den Pflegeschulen:

Eine 18-monatige Ausbildung korreliert keineswegs mit den Schulzyklen eines regulären Schuljahres sämtlicher Schultypen. Nach 18 Monaten wäre zunächst keine direkte Anschlussmöglichkeit an Folgeausbildungen gegeben. Je nach aktueller landesrechtlicher Regelung würde mindestens ein Monat Leerlauf für die Pflegeschule in Bezug auf die Lehrpersonalplanung bzw. Wartezeit für die Absolvent*innen die Konsequenz sein – insofern die betreffende Pflegeschule überhaupt einen zweiten Ausbildungsgang anbieten kann. Ansonsten wäre sogar eine Zeit von sechs Monaten zu überbrücken. Insbesondere für die Lehrpersonalplanung bringt dies eine Überdeckung an Lehrkapazitäten mit sich, die für die oben genannten Zeiträume nicht refinanziert ist.

Ein Ziel ist daher die Harmonisierung der Start- und Endzeitpunkte, sowie der Ausbildungsinhalte, der 18-monatigen Pflegefachassistentenausbildung, mit denen der 36-monatigen Pflegefachausbildung. Damit das Ende der Ausbildung zur Pflegefachassistentenz mit dem Beginn der Ausbildung zur Pflegefachperson anschlussfähig und auch inhaltlich aufeinander aufbauen kann, sind entsprechende Gestaltungsfreiheiten der Pflegeschulen notwendig, um keine unnötigen Lücken und Wartezeiten entstehen zu lassen. Die Bundesländer sollten hier die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, und die Pflegeschulen dazu befähigen, die Start- und Endpunkte der Ausbildungen im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung für den Ausbildungsverlauf (in definierten Korridoren) selbst zu bestimmen. Das gleiche gilt im umgekehrten Sinn für den Start der verkürzten Pflegefachassistentenausbildung durch Anrechnung von Vorerfahrung.

Auch hier sind Gestaltungsspielräume der Pflegeschulen notwendig, um Wartezeiten und Lücken zu vermeiden, neben der Flexibilisierung der Start- und Endzeiten, auch beispielsweise die Möglichkeit, entsprechende Personen in laufende Kurse aufzunehmen oder auch separate Kurse für Verkürzer*innen einrichten zu können.

Dynamisierung der Mindestanforderungen an die Pflegeschulen:

Auch die analog zur Pflegefachausbildung gehaltenen Mindestanforderungen an die Qualifikation des Lehrpersonals stellt die Pflegeschulen vor große Herausforderungen. Ein kompetenzorientierter Personaleinsatz kann nur begrenzt dabei helfen, die entsprechenden Qualifikationsvoraussetzungen für den theoretischen Unterricht als auch die Praxisbegleitung zu erfüllen, denn eine zusätzliche, wenn auch kürzere Ausbildung, erfordert mehr Personal, und kann nicht durch das bereits vorhandene Stammpersonal der Pflegefachausbildung kompensiert werden. Ebenso wird es nicht möglich sein, dass Pflegeschulen, die bereits eine Assistenz- bzw. Helferausbildung nach Landesrecht anbieten, ihr bestehendes Personal weiterqualifizieren können: Die Studienplätze in den einschlägigen Bachelor- und Masterstudiengängen sind begrenzt und müssen zudem bereits den Qualifikationszuwachs für die Pflegefachausbildung bewältigen. Insofern wäre es wünschenswert, wenn die Länder hier abweichende Regelungen unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten zulassen und zusätzlich die Anzahl der Studienplätze im Bereich der Medizin- und Pflegepädagogik (auch berufsbegleitend) deutlich erhöhen. Ziel sollte ein empirisch begründeter und damit nachhaltiger Qualifikationszuwachs sein, der sich an den tatsächlichen Möglichkeiten des Arbeitsmarktes orientiert

Übergangsvorschriften:

Ebenso begrüßen wir die Übergangsvorschriften für die Beendigung der geltenden landesrechtlichen Fassungen der bereits bestehenden Pflegehilfs- und Pflegeassistentenausbildungen in den Ländern zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des PflAssEinfG. Die Übergangsvorschriften für die Qualifizierung von Lehrpersonen nach §8, Abs. 1 und 2 sind mit der in Abs. 3 dargelegten Dauer bis 2035 zu begrüßen.

DQR-Zuordnungen

Weiterhin braucht es dringend konsistente und angemessene DQR-Zuordnungen. Den DQR-Rahmen für die Pflege gilt es dringend zu überarbeiten, was wohl bereits in einer Arbeitsgruppe in Angriff genommen wird.

Die Ausbildung von Pflegefachassistentenpersonen sollte unserer Auffassung nach auf Stufe vier, die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachperson auf Stufe fünf und der primärqualifizierende Bachelor auf Stufe sechs angesiedelt werden. Zudem muss eine entsprechende Zuordnung von geregelten Weiterbildungen erfolgen, ebenfalls für die Assistentenpersonen der Pflege – auch um hier einer generalistischen Ausrichtung gerecht zu werden.

Die Durchlässigkeit der beruflichen Bildung zur akademischen Bildung muss auch im Rahmen der Weiterbildung unbedingt erhalten bleiben. Die Vorbehaltsaufgaben müssen dabei fest auf der Ebene der beruflich qualifizierten Pflegeabsolvent*innen verankert sein.

II. Änderungsbedarfe:

- **§1 „Führen der Berufsbezeichnung“:** Als HWA sprechen wir uns für die 18-monatige bundeseinheitliche Pflegefachassistentenausbildung aus.
Hierbei ist Sorge zu tragen, dass sich die assistierende Funktion des Berufsbildes auch in der Namensgebung wiederfindet. Die Assistenzbezeichnung beschreibt besser das damit einhergehende Tätigkeitsprofil (s. unsere Erläuterungen unter I. Allgemein). Die Berufsbezeichnung zur *Pflegefachassistentin*, wie sie teilweise auch schon auf der Landesebene kursiert und sich nur unscharf von der dreijährigen *Pflegefachausbildung* absetzt, ist daher zu ersetzen mit folgendem Wortlaut: *„Wer die Berufsbezeichnung „Pflegefachassistentin“, „Pflegefachassistent“ oder „Pflegefachassistentperson“ führen will, bedarf der Erlaubnis.“*.
- **§ 4, Abs. 1 „Ausbildungsziel“:** Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen *„komplexen und nicht komplexen Pflegesituationen“* und den mit ihnen verbundenen fachlichen Anforderungen müssen diese Kompetenzgrenzen über die Hoheit der vorbehaltenen Aufgaben entschieden werden. Das bedeutet, dass hier immer der Einzelfall zu betrachten ist und über die Vorbehaltsaufgaben zu steuern und zu entscheiden ist, da sich diese Fallkonstellationen von „komplex/nicht komplex“ in der Praxis einerseits nicht voneinander unterscheiden lassen und andererseits mit „zunehmender Komplexität von Herausforderungen in der Versorgung [...] zusehends wissenschaftsfundiertes und evidentes Wissen in die direkte Versorgungspraxis Einzug halten muss“ (Weidner et al. 2024, S. 20). Beruflich qualifizierte Assistenzkräfte von der Verantwortungsübernahme für „komplexe Pflegesituationen – die jederzeit entstehen können und entsprechend unmittelbare pflegerische Handlungen auf verschiedenen Kompetenzebenen erfordern – auszuschließen, würde zudem eine Abwertung dieser langjährig praktizierten Verantwortungsübernahme bedeuten.
- **§5 „Dauer und Struktur der Ausbildung“: Abs. 3, letzter Satz:** *„[...] kann ein geringer Anteil eines jeden Einsatzes der praktischen Ausbildung durch praktische Lerneinheiten an der Pflegeschule ersetzt werden.“*:
 - Um den unterschiedlichen Bedarfen der notwendigen Kompetenzentwicklung innerhalb der praktischen Ausbildung im Umfeld der Pflegeschule gerecht zu werden, ist hier die Anrechnung des prozentualen Verhältnisses auf die gesamte Dauer der praktischen Ausbildung anzuwenden.
 - Zudem bedarf es einer **Konkretisierung**:
 - Definition von „gering“ anhand des prozentualen Verhältnisses der Stunden der praktischen Ausbildung: davon max. 10%
 - Qualifizierung der Lehrenden, als auch Praxisanleitenden im simulationsbasierten Lehren und Lernen
 - Refinanzierung: Einbettung dieser Möglichkeit in die Pauschalen für die Pflegeschulen
 - Zudem ist bei den vorgegebenen Pflichteinsätzen zu beachten, die ohnehin regional angespannten Situationen in der dreijährigen Ausbildung der Pflegefachpersonen nicht noch mehr zu verschärfen, indem weitere Auszubildende der Pflegefachassistentin in die gleichen Einsatzorte einströmen. Daher sprechen wir uns – im Verhältnis zur gesamten Praxiszeit – für max. 1/3 Pflichteinsatzzeiten in zwei der drei großen Einsatzbereiche aus und einen 3. Einsatzort lediglich optional zu absolvieren, wenn die regionalen Gegebenheiten dies ermöglichen.

- **§11 „Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen und Berufserfahrung“:**
 - **Abs. 1:** Eine **Verkürzung** ist grundsätzlich in ihrer zeitlichen Anrechnung von 1/3 bzw. um sechs Monate zu begrüßen. Gleichwohl muss in Nr. 1 und 3. eine Konkretisierung der Anrechnungskriterien erfolgen. Die Aufwände für ein Kompetenzfeststellungsverfahren (Nr. 3) unter Länderhoheit ist zudem in der Pauschale für die Pflegeschulen mit einzukalkulieren.
 - **Abs. 2:** Ein **Vorbereitungskurs** in der Pflegeschule im Umfang von 320 Stunden und ohne eine Theorie-Praxis-Verzahnung stellt eine Missachtung der Bedeutung der beruflichen Pflege dar. Vielmehr ist für die Personen nach §11, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 die Möglichkeit zur Teilnahme an einer sog. „**Externenprüfung**“ zu gewähren. Wir setzen uns daher dafür ein, die Möglichkeit der „Externenprüfung“ in den Referentenentwurf aufzunehmen. Diese Option ist zwingend notwendig, um den durch die gesetzlichen Regelungen des § 113 C SGB XI und des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes zukünftigen Bedarf an ausgebildeten Pflegeassistentenpersonal in der stationären Langzeit- und Akutpflege zu decken. Optional soll es den Personen möglich sein, einen wie auch immer gearteten Vorbereitungskurs zu besuchen.
- **§14, Abs. 2, Nr. 12: Ausbildungsvertrag: Form des Ausbildungsnachweises:** In §9 PflFAssEinfG wird unter Abs. 2 festgelegt, dass die Pflegeschule den „*schriftlich oder elektronisch zu führenden Ausbildungsnachweis, ob die praktische Ausbildung gemäß dem Ausbildungsplan durchgeführt wird*“ zu überprüfen hat. Daher liegt es im Ermessen der jeweiligen Pflegeschule die Form des Ausbildungsnachweises festzulegen. §14, Abs. 2, Nr. 12 ist ersatzlos zu streichen.
- **§16, Abs. 1, Nr. 3: Die Praxisanleitung** im Umfang von mindestens 10% begrüßen wir sehr. Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass diese Praxisanleitung **nicht** den Anforderungen nach PflAPrV §4, Abs. 3 unterliegt. Um die Anschlussfähigkeit an die Fachkraftebene herzustellen, ist daher die Anleitung durch eine erfahrene Pflegefachperson zu gewährleisten. Entsprechend ist hier zu ergänzen: „*Die erfahrene Pflegefachperson steht dabei in der Verantwortung eine kontinuierliche Begleitung durch Praxisanleitung im Kompetenzerwerb in der praktischen Pflegefachassistentenausbildung zu gewährleisten.*“.
- **§§25, 26, 27: Gleichwertigkeit und Anerkennung von Ausbildungen, Eignungsprüfung, Anpassungslehrgang und Kenntnisprüfung:** An dieser Stelle ist fragwürdig, inwiefern es Zielgruppen im außereuropäischen Ausland gibt, auf die diese Paragraphen überhaupt anzuwenden sind. Gleichzeitig wird mit den Verkürzungs- und Anrechnungsmöglichkeiten nach §11 PflFAssEinfG ein hinreichender Zugang zu einer fachlich qualifizierenden Ausbildung gegeben. Weitere Kenntnisprüfungen und Anpassungslehrgänge mit einer gleichwertigen Dauer, wie die vorgeschlagene 18-monatige Pflegefachassistentenausbildung erhöhen lediglich die schulorganisatorischen Aufwände. §27 kann daher ersatzlos gestrichen werden.
- **§47: Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Finanzierung; Verordnungsermächtigungen:** Für die Sicherstellung einer wirtschaftlich deckenden Refinanzierung, sollen Nachprüfungen und Ausbildungsverlängerungen in die Kalkulationen einfließen.

Ich freue mich über die Berücksichtigung der Anregungen in der endgültigen Fassung des PflAssEinfG und stehe Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Isabel Kalberlah

Hans-Weinberger-Akademie der AWO e.V.
-Leitung Referat Schulen-

Literatur:

Weidner, Frank, Andreas Büscher, Bianca Jendrzej, Bernhard Krautz und Erika Sirsch (2024): Vorbehaltsaufgaben für Pflegefachpersonen – Pflegefachliche Begründungszusammenhänge. S. 9- 26 in: Think Tank Vorbehaltsaufgaben (TT VA) und Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (DGP): Vorbehaltsaufgaben der Pflege – Pflegewissenschaftliche und pflegerechtliche Grundlegung und Einordnung. Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (Hg.), Duisburg. Online: www.dg-pflegewissenschaft.de/wp-content/uploads/2024/03/Vorbehaltsaufgaben-_BroschuereDGP-1.pdf (21.07.24).

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Ausschussdrucksache 21(13)9b
vom 26. September 2025

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefach-
assistentenausbildung“

BT-Drucksache 21/1493

Dr. Elisabeth Fix

Deutscher Caritasverband e. V.



STELLUNGNAHME

zum Gesetzentwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegeassistentenausbildung (PflAssEinfG) (BT-Drs. 21/1493)

A. Einleitung und Zusammenfassung

Der Deutsche Caritasverband und seine Fachverbände Verband der katholischen Altenhilfe (VKAD) und Katholischer Krankenhausverband Deutschland haben sich seit vielen Jahren für eine bundeseinheitliche Pflegeassistentenausbildung eingesetzt, die das Berufsbild attraktiver macht und zur Ausbildung zur Pflegefachperson anschlussfähig ist. Im Prozess der Einführung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur Personalbemessung nach § 113c SGB XI hat Prof. Rothgang für die vollstationären Langzeitpflege festgestellt, dass neben mehr Pflegefachpersonen künftig bis zu 100.000 Pflegeassistentenkräfte des Niveaus QN 3 benötigt werden, um einen guten Personalmix mit einer kompetenzorientierten Aufgabenverteilung in einem modular gestuften und durchlässigen Ausbildungssystem zu gewährleisten.

Der Gesetzentwurf sieht alternativ die Regelung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung mit einer Dauer von 18 Monaten vor. Wir sprechen uns klar für das Kompetenzprofil einer Pflegefachassistentenausbildung aus. Denn die bisherigen Helferausbildungen entsprechen inhaltlich nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Pflegesituationen werden zunehmend komplexer und umfassen akute, chronische, intensivpflichtige und psychiatrische Bedarfe, die die traditionellen Sektorengrenzen überschreiten. Eine Ausbildung, die sich ausschließlich entweder auf die geriatrische Langzeitpflege oder die Akutpflege konzentriert, ist daher nicht mehr zeitgemäß. Daher benötigt die Pflegefachassistenz ein eigenständiges Berufsprofil, das sich an der generalistischen Pflegeausbildung orientiert. Es ist erforderlich, die Assistenz Ausbildung modular gestuft, durchlässig sowie auf- und durchstiegsorientiert zu gestalten. So sollen sich Pflegeassistentenkräfte zu Pflegefachpersonen weiterqualifizieren können, indem bestimmte Kompetenzen auf die Ausbildung angerechnet werden; andererseits sollen auch Abbrechende der Pflegefachkraftausbildung leichter einen Abschluss als Pflegeassistentenkräfte erwerben können.

Nachbesserungsbedarfe sehen DCV, VKAD und Katholische Krankenhausverband Deutschland zu folgenden Punkten:

1. **Ausbildungsziel:** Bei den Regelungen zum Ausbildungsziel in § 4 ist darauf zu achten, dass die Pflegeprozesssteuerung stets Aufgabe der Pflegefachperson nach Pflegeberufegesetz (PflBG) bleibt. Die interprofessionelle Kommunikation soll daher den Pflegefachpersonen vorbehalten bleiben. Insbesondere bei den Formulierungen zu rehabilitativen und palliativen Aufgaben in § 4 Absatz 3 Nummer 1h und 1j sollte klargestellt werden, dass hier nur eine Unterstützung durch Pflegefachassistenzpersonen erfolgen kann. Wir erachten es als unrealistisch, dass Pflegeassistenzpersonen im Rahmen einer 18-monatigen Ausbildung palliative und rehabilitative Aufgaben selbstständig durchführen können.
2. **Rehabilitationseinrichtungen als Träger der praktischen Ausbildung:** Unsere langjährige Forderung, dass Rehabilitationsträger auch Träger der praktischen Ausbildung sein können, wurde nicht berücksichtigt. Insbesondere bei Rehabilitationskliniken mit den Fachbereichen Neurologie und Geriatrie sehen wir die Gleichwertigkeit zur Ausbildung in Krankenhäusern gegeben und fordern weiterhin deren Berücksichtigung.
3. **Pflegepädagogen-Schlüssel:** Der Personalschlüssel von hauptberuflichen Lehrkräften zu Ausbildungsplätzen in Höhe von 1:20 (§ 8 Abs. 2) ist fachlich per se angemessen; gleichzeitig kämpfen die Pflegeschulen seit Jahren gegen einen erheblichen Mangel an ausreichend qualifizierten Pflegepädagog_innen. Daher begrüßen wir, dass die Länder bis 2035 abweichende Regelungen treffen können. Darüber hinaus empfehlen wir eine Evaluation im Jahr 2031, um zu prüfen, inwieweit Bachelorabsolvent:innen die Möglichkeit haben, zeitnah ein Masterstudium aufzunehmen. Angesichts des Lehrpersonalbedarfs und hoher Abbrecherquoten in Hilfskraftausbildungen plädieren wir für eine verlässliche Kursfinanzierung über 18 Monate; mindestens sollte eine Regelung analog zum PflBG greifen, sodass Ausbildungsabbrüche nach dem Stichtag nicht zu Rückforderungen oder Kürzungen der Ausgleichzahlungen innerhalb desselben Schuljahres führen.
4. **Träger der praktischen Ausbildung:** Für eine flächendeckende, hochwertige Ausbildung ist eine bundesweit einheitlich geregelte Finanzierung von Koordinierungsstellen für Praxiseinsätze erforderlich. Derzeit hängt deren Finanzierung häufig von freiwilligen Landesförderungen ab, was zu Engpässen bei Einsatzstellen und dem Wegfall zentraler Strukturen führt. Um Planungssicherheit zu schaffen, muss eine verbindliche Finanzierung etabliert werden. Drei Pflichteinsätze – Akutversorgung, Langzeitpflege,

ambulante Pflege – werden als wünschenswert angesehen, um die generalistische Breite der Ausbildung abzubilden. Gleichzeitig sollte untersucht werden, inwieweit die Krankenhausreform zum Wegfall bestehender Praxiseinsatzorte führt. Diese Ergebnisse sollten in die Evaluation der neuen Ausbildung nach § 54 einfließen. Pragmatismus ist entscheidend: Geeignete Reha-Einrichtungen könnten als zusätzliche Einsatzorte zugelassen werden, Skill-Labs stärker genutzt und Schulsozialarbeit refinanziert werden, um die Auszubildenden optimal zu begleiten.

5. **Anrechnung von Ausbildungen:** Die Möglichkeit, eine andere abgeschlossene Ausbildung, Teile einer Ausbildung sowie Berufserfahrungen bis zu einem Drittel auf die Dauer der Pflegeassistentenausbildung anrechnen zu können, wird ausdrücklich begrüßt. Die vorgesehenen Anrechnungs- und Verkürzungsmöglichkeiten nach den §§ 10 und 11 werden angesichts des erheblichen Mangels an QN3-Pflegeassistentenkräften ausdrücklich begrüßt, auch wenn sie mit einer Verkürzung wertvoller Lernzeit einhergehen.
6. **Fehlzeiten bei Mutterschutz:** Im Falle von Mutterschutz sollte es möglich sein, angesichts der nur 18-monatigen Ausbildung, Fehlzeiten auch über die vorgesehenen 14 Wochen hinaus, um die entsprechende tatsächliche Dauer des Mutterschutzes zu verlängern.
7. **Höhe der Ausbildungsvergütung:** Für die Höhe einer Ausbildungsvergütung einer Pflegeassistentenperson kalkuliert der Gesetzentwurf einen Abstand von minus 16,5 Prozent gegenüber der Höhe der Ausbildungsvergütung für eine Pflegefachperson. Der tatsächliche Abstand in den AVR der Caritas beträgt jedoch schon heute nur rd. 5,5 Prozent. Für die Auszubildenden dürfen sich aufgrund der Neuregelungen keine Verschlechterungen ergeben. Daher ist klarzustellen, dass tarifliche Ausbildungsvergütungen stets als wirtschaftlich angemessen anerkannt werden müssen.
8. **Finanzierung:** Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, die Höhe der zu zahlenden Eigenanteile für Pflegebedürftige (in stationären Pflegeeinrichtungen) durch die Herausnahme der Ausbildungskosten zu begrenzen. Derzeit führen allein die Ausbildungskosten der Fachkraftausbildung zu einer Erhöhung der Eigenanteile von 150-200 Euro. Wir plädieren dafür, die Ausbildungskosten für die Assistenz Ausbildung und Pflegefachkraftausbildung nach PflBG grundsätzlich aus Steuermitteln sowie durch eine Erhöhung der Länderanteile an den Ausbildungskosten zu refinanzieren.
9. **Anerkennung ausländischer Qualifikationen:** Um den Anerkennungsprozess von im Ausland erworbenen Qualifikationen zu erhöhen, empfehlen wir die Einführung

verbindlicher Bearbeitungsfristen für die Prüfung und Entscheidung von drei Monaten und ein einheitliches Bewertungsmuster für die Gleichwertigkeitsprüfung von Abschlüssen aus Drittstaaten. Zudem ist eine digitale Plattform erforderlich, die die unterschiedlichen ausländische Niveaus für Pflegeberufe darstellt und die erforderlichen Auflagen aufzeigt. Wir empfehlen den Ausbau der zentralen Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe, die perspektivisch die Verantwortung für die vereinheitlichen Gleichwertigkeitsprüfungen übernehmen können soll. Sollte ein Anpassungslehrgang (§ 27 Absatz 2) erforderlich sein, muss er, anders als im Gesetzentwurf vorgesehen, grundsätzlich kürzer als die reguläre Ausbildung zur Pflegeassistenz sein. Darüber hinaus empfehlen wir grundsätzlich den Aufbau von staatlichen Unterstützungsstrukturen („Lotsen“) für die Begleitung von ausländischen Fach- und Arbeitskräften, die bürokratischen Anforderungen und die Komplexität der unterschiedlichen Zuständigkeiten und Regelung ist so hoch, dass Einrichtungen dies nicht leisten können.

10. Verankerung der Schulsozialarbeit und Sprachförderung bei den zu refinanzierenden Personalkosten der Pflegeschulen: Wir unterstützen mit großem Nachdruck die Forderung des Bundesrats, die Kosten der Schulsozialarbeit in der Personalkostenfinanzierung der Pflegeschulen zu verankern. Nach unseren langjährigen Erfahrungen benötigen Auszubildende sehr häufig sozialpädagogische Unterstützung, wenn sie keinen oder nur einen geringen Bildungsabschluss aufweisen, mangelnde Sprachkenntnisse haben oder vor anderen Herausforderungen stehen, die ohne Schulsozialarbeit zum Abbruch der Ausbildung führen würde.

11. Umlagebetrag für die Tagespflege: In der Praxis ist in mehreren Bundesländern ein Problem bei der Berechnung des Umlagebetrags für die Tagespflege aufgetreten. Eine Berechnung in gleicher Höhe wie für die vollstationäre Pflege ist sachlich und fachlich nicht gerechtfertigt. Daher bitten wir, im Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens, die Umlagekosten für die Tagespflege bundeseinheitlich mit einem Faktor von 0,5 zu berechnen.

Wir begrüßen die bundesweite Vereinheitlichung der Pflegeassistentenausbildung. Dennoch bleiben viele Aspekte der Ausbildungsinhalte unklar. Es ist daher dringend zu empfehlen, dass die Verordnungsentwürfe (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Finanzierungsverordnung) zeitnah vorgelegt werden und den Fachverbänden ausreichend Zeit zur Stellungnahme eingeräumt wird. Wir weisen darauf hin, dass einheitliche Regelungen auch in Bezug auf die Ausbildung zur Heilerziehungspflegeassistenz dringend erforderlich sind, um das kompetenzorientierte Qualifikationsprofil, das die KMK 2021 vorgelegt hat, endlich verbindlich in allen

Bundesländern umzusetzen und damit die bis heute deutlichen Unterschiede in den Unterrichtsinhalten und Umfang und Dauer der Ausbildung zu beseitigen. Nur auf diese Weise ist Transparenz über das Berufsprofil und damit die Einsatzmöglichkeit für diese wichtige Berufsgruppe in allen Bundesländern zu gewährleisten.

B. Zu den Einzelheiten des Gesetzentwurfs

Vorbemerkung

Sofern keine Kommentierung zu einzelnen §§ erfolgt, halten wir die Regelungen für sachgerecht. Die in Klammern befindlichen Alternativregelungen für die Pflegehilfeausbildung sind ersatzlos zu streichen; in den nachfolgenden Änderungsvorschlägen beziehen wir uns ausnahmslos auf die bundesweit einheitliche 18-monatige Pflegefachassistentenausbildung.

Artikel 1: Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegeassistentenausbildung

§ 2 Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis

Grundsätzlich stimmen wir den geregelten Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung zu. Hier wurde eine ähnliche Formulierung wie beim PflBG gewählt. In der Praxis hat sich bei der Umsetzung des PflBG gezeigt, dass bei der Formulierungswahl von Nummer 4 "erforderliche Kenntnisse der deutschen Sprache" Missverständnisse entstehen können. Daher sollte das Sprachniveau B2, wie im Begründungstext beschrieben, auch hier ausdrücklich erwähnt werden.

Änderungsbedarf:

§ 2 Nummer 2: "über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse **gemäß dem Sprachniveau B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen** verfügt."

§ 4 Ausbildungsziel

Sowohl das Kompetenzprofil des neuen Berufs in Absatz 1 als auch die pflegerischen Maßnahmen in Absatz 2, die mit den erworbenen Kompetenzen ausgeführt werden können, beschreiben das anzustrebende Ausbildungsziel gut. Allerdings sollte statt des veralteten Begriffs der „Sozialpflege“ der moderne Begriff der „Teilhabeorientierung“ in Absatz 2 verwendet werden.

Absatz 3 beschreibt, wozu die Ausbildung im Einzelnen befähigt. Positiv zu bewerten ist, dass die Aufzählung der Befähigungen nicht abschließend ist und dass zwischen Aufgaben unterschieden wird, die Pflegefachassistentenpersonen in nicht komplexen Pflegesituationen selbstständig und damit eigenverantwortlich ausführen und solchen in komplexen Pflegesituationen, an denen sie durch eigenständige Durchführung mitwirken.

Hier sehen wir im Einzelnen noch Nachbesserungsbedarfe: So sind die Kompetenzen der Pflegefachassistentenpersonen und Pflegefachpersonen noch nicht durchgängig hinreichend klar und trennscharf. Es ist daher entscheidend, dass die Fachkommission nach § 53 PflBG unbestimmte Begrifflichkeiten wie nicht komplexe und komplexe Pflegemaßnahmen präzisiert, um eine klare Abgrenzung der Aufgaben und deren Zuordnung zwischen den Ausbildungsstufen zu gewährleisten.

Die Pflegeprozessverantwortung und die Evaluation des Pflegeprozesses muss weiterhin klar Pflegefachpersonen vorbehalten sein, gegen eine Unterstützung der Pflegefachassistentenpersonen spricht nichts, es sollte jedoch präzisiert werden, wie die Unterstützung erfolgt. Auch erachten wir es im Rahmen einer 18-monatigen Assistenz Ausbildung für unrealistisch, dass Pflegefachassistentenpersonen eigenständig rehabilitative Pflegemaßnahmen durchführen oder selbstständig in palliativen Pflegesituationen oder am Lebensende begleiten können sollen (§ 4 Absatz 3 Nummer 1h und Nummer 1j).

Positiv zu bewerten ist, dass Pflegefachassistentenpersonen nach § 4 Absatz 3 Nummer 2 künftig geeignete Maßnahmen im Wege der ärztlichen Delegation und aufgrund der Weiterdelegation durch die Pflegefachperson eigenständig ausüben können sollen. Eine direkte Delegation von geeigneten Maßnahmen von der Ärztin oder dem Arzt auf die Pflegefachassistentenperson sollte ausgeschlossen bleiben. Dies ist entsprechend zu ändern. Der Begriff der „geeigneten Maßnahmen“ sollte näher definiert werden durch „geeignete medizinisch-diagnostische oder pflegerisch-therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Feststellung und Erhebung des individuellen Pflegebedarfs“.

Die interprofessionelle Kommunikation mit anderen Gesundheitsfachberufen sollte überwiegend den Pflegefachpersonen vorbehalten bleiben.

Änderungsbedarfe:

In Absatz 2 Satz 1 sind die Wörter „sozialpflegerische Maßnahmen“ durch „Maßnahmen zur Förderung der sozialen Teilhabe“ zu ersetzen.

Absatz 3 Nummer 1a ist wie folgt klarstellend zu präzisieren: „Unterstützung bei der Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs und der Planung der Pflege **durch eine aussagekräftige Dokumentation und weitere praxisorientierte Instrumente**“.

In Absatz 3 ist Nummer 1j) wie folgt zu fassen: „**Unterstützung bei der** Begleitung von Menschen in palliativen Pflegesituationen und in der letzten Lebensphase“

In Absatz 3 ist Nummer 1h) wie folgt zu fassen: „**Unterstützung bei der** Durchführung rehabilitativer Pflegemaßnahmen“.

In Absatz 3 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen:

„ärztlich angeordnete, zur Übertragung geeignete **medizinisch-diagnostische sowie pflegerisch-therapeutische** Maßnahmen **sowie Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs** nach Übertragung durch die Ärztin oder den Arzt ~~oder~~ **und nach** Weiterübertragung durch die Pflegefachperson eigenständig durchzuführen.“

In Absatz 3 ist Nummer 3 wie folgt zu fassen:

„intraprofessionell ~~und interprofessionell~~ zu kommunizieren und effektiv im Pflegeteam ~~und mit anderen Berufsgruppen~~ zusammenzuarbeiten.“

§ 5 Dauer und Struktur der Ausbildung

Wir begrüßen ausdrücklich die Entscheidung, eine 18-monatige Pflegefachassistentenausbildung einzuführen. Die bisherigen Helferausbildungen sind inhaltlich nicht mehr zeitgemäß und bieten keine ausreichende Anschlussfähigkeit zur generalistischen Ausbildung zur Pflegefachperson.

Mit der 18-monatigen Ausbildung werden zukünftige Pflegefachassistentenkräfte in die Lage versetzt, eigenständig bestimmte Aufgaben in nicht-komplexen Pflegesituationen zu übernehmen. Dies ist von zentraler Bedeutung, um den Pflegefachpersonen den notwendigen Freiraum zu geben, sich auf ihre Kernkompetenzen wie die Steuerung des Pflegeprozesses zu konzentrieren. Eine klare Rollenverteilung zwischen den Pflegefachassistentenkräften und den Pflegefachpersonen erhöht nicht nur die Effizienz, sondern auch die Qualität der Pflege und sorgt dafür, dass Fachkompetenz dort eingesetzt wird, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Die Durchlässigkeit von der Pflegefachassistenten in die Pflegefachkraftausbildung ist mit dem aktuellen Entwurf nicht gewährleistet. Zwar ist bei positiver Prognose durch die Pflegeschule der Zugang ohne Hauptschulabschluss in die Assistentenausbildung möglich, was ausdrücklich begrüßt wird. Allerdings ist der Hauptschulabschluss nach wie vor Grundvoraussetzung für die Fachkraftausbildung. Während dies fachlich und im Einklang mit internationalen Standards der

generalistischen Pflegeausbildung nach PflBG gerechtfertigt ist, fehlen passende Ausbildungskonzepte für den nachträglichen/gleichzeitigen Erwerb des Hauptschulabschlusses.

Darüber hinaus ist die Voraussetzung für die Erteilung einer Ausbildungsduldung nach § 60c oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG für eine Assistenz- oder Helferausbildung derzeit, dass bereits bei Beginn der Assistenz- oder Helferausbildung eine Ausbildungsplatzzusage für eine mindestens zweijährige Fachkraftausbildung in einem Mangelberuf vorliegt. Diese Regelung ist, wie die Ausschüsse des Bundesrats zu Recht anmerken, in der Praxis schwer umsetzbar. Es entspricht, auch nach den Erfahrungen der freien Wohlfahrtspflege, nicht der gängigen Ausbildungspraxis, bereits vor Beginn oder in einem frühen Stadium der Pflegeassistentenausbildung eine Zusage zu einer Ausbildung nach dem PflBG zu erteilen.

Auch die Aussage, dass Pflegefachassistentenkräfte gebraucht werden und es nicht unbedingt zielführend ist, diesen Personenkreis in jedem Falle anschließend nach PflBG ausbilden zu müssen, findet unsere volle Zustimmung. Der Gesetzgeber hat den Bedarf an Assistenzkräften in der Vergangenheit ebenso als hoch angesehen und deswegen die Möglichkeit geschaffen, dass geduldete ausländische Personen mit staatlich anerkannter Ausbildung in einer Pflegehilfstätigkeit eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19d Abs. 1 Nr. 1 Bst. a) AufenthG erhalten können. Im Widerspruch dazu wurde aber daran festgehalten, dass eine Ausbildungsduldung nach § 60c oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG nur für eine Assistenz- oder Helferausbildung erteilt werden darf, wenn eine Zusage für eine Fachkraftausbildung vorliegt.

In der Praxis erhalten Person, die eine Pflegeassistentenausbildung mit Ausbildungsduldung gemacht haben und die Fachkraftausbildung dann nicht antreten oder abbrechen, keine Aufenthaltserlaubnis nach § 19d AufenthG, obwohl sie eine Arbeitsplatzzusage haben und in den Einrichtungen dringend benötigt werden (Für den relativ neuen § 16g AufenthG liegen noch keine Erfahrungswerte vor). § 19d AufenthG würde dies zwar durchaus zulassen, aber die Ausländerbehörden verweisen darauf, dass sonst die Regelungen nach § 60c und § 16g AufenthG umgangen werden könnten.

Vor diesem Hintergrund plädieren wir dafür:

- In § 16g und § 60a AufenthG wird jeweils in Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) der folgende Halbsatz gestrichen: „an die eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf, für den die Bundesagentur für Arbeit einen Engpass festgestellt hat, anschlussfähig ist und dazu eine Ausbildungsplatzzusage vorliegt,“. § 19d Abs. 1 AufenthG sollte entsprechend

dahingehend geändert werden, dass diese Aufenthaltserlaubnis für jede qualifizierte Hilfstätigkeit/Assistenz erteilt werden kann und nicht wie bisher nur für Pflegehilfstätigkeiten.

- Wenn die Verknüpfung mit einer anschließenden Fachkraftausbildung nicht wie von uns vorgeschlagen generell gestrichen wird, sollte das wenigstens für die neu geschaffene bundeseinheitliche Pflegefachassistenzausbildung gelten. Zu diesem Zweck könnte in § 16g und § 60a AufenthG jeweils in Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 ein neuer Buchstaben c) ergänzt werden: „eine staatlich anerkannte Ausbildung in einer Pflegehilfstätigkeit aufgenommen hat“.
- Es sollte zumindest in den Anwendungshinweisen des Bundesministeriums des Innern zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz klargestellt werden, dass eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19d Abs. 1 AufenthG auch dann erteilt werden soll, wenn die staatlich anerkannte Ausbildung in einer Pflegehilfstätigkeit mit einer Ausbildungsduldung oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG erworben wurde.

Die Option zur Teilzeit-Ausbildung (bis höchstens 36 Monate) gem. § 5 Abs. 1, die zudem auf Länderebene mit dem Erwerb allgemeinbildender Kenntnisse und Fähigkeiten verknüpft werden kann, wird ausdrücklich begrüßt. Damit können die Bundesländer auch Ausbildungskonzepte mit besonderer Sprachförderung zulassen und mit Landesmitteln fördern.

Darüber hinaus ist eine Teilzeitausbildung, die es ermöglicht, den Hauptschulabschluss und den Abschluss zum Pflegeassistenten zu erwerben, ist mit Blick auf die Durchlässigkeit der Pflegeausbildung unerlässlich, aber weder geregelt und finanziert. Wir fordern daher, Kooperation zwischen Pflegeschulen, Trägern der praktischen Ausbildung und allgemeinbildenden Schulen auf Länderebene sicherzustellen und zu finanzieren. Wir begrüßen grundsätzlich die Möglichkeit, einen geringen Teil der praktischen Ausbildung durch praktische Lerneinheiten an der Pflegeschule oder beim Träger der praktischen Ausbildung zu ersetzen (§ 5 Abs. 3). Diese Flexibilisierung bietet die Chance, ausgewählte Lerninhalte gezielt zu vermitteln und zu vertiefen. Aus unserer Sicht ist es jedoch notwendig, den Begriff „geringer Anteil“ eindeutig zu definieren, um eine einheitliche Auslegung und verlässliche Planungsgrundlagen für Träger und Schulen zu gewährleisten. Wir empfehlen daher, diesen Anteil klar auf maximal 10 % der jeweiligen geforderten Stunden der Praxisanleitung zu begrenzen. Diese Begrenzung sieht nun die Begründung zu dem diese Regelung ergänzenden § 6 Absatz 3 Satz 5 PflBG vor, wie aus der Begründung hervorgeht (max. 200 Stunden der insgesamt 2500 Stunden). Laut derselben Begründung soll ebenfalls ermöglicht werden, bestimmte Anleitungssituationen auch

in Skill-Labs in der Pflegeschule absolvieren zu können. Dafür hatten wir uns ausdrücklich eingesetzt.

Wird ein geringer Teil der praktischen Ausbildung durch praktische Lerneinheiten an der Pflegeschule ersetzt, entsteht ein zusätzlicher Aufwand an Personal, Raum und Ausstattung, der nicht über die reguläre Pauschale abgedeckt ist. Dieser Mehraufwand sollte deshalb in der Berechnung der Ausbildungspauschale für Pflegeschulen berücksichtigt werden, um die Umsetzung praxistauglich zu gestalten.

Gleichzeitig möchten wir hervorheben, dass die Pflichteinsätze das Fundament der praktischen Ausbildung darstellen. Besonders der Einsatz beim Träger der praktischen Ausbildung sollte gestärkt werden. Eine hohe Qualität und Kontinuität in diesen Einsätzen sind entscheidend für die Akzeptanz bei Auszubildenden und Trägern.

Wir unterstützen zudem die Forderung des Bundesrats nach einer Öffnungsklausel, die es den Ländern ermöglicht, bei einer Teilzeitausbildung auch den Erwerb eines allgemeinbildenden Schulabschlusses vorsehen zu können.

Änderungsbedarf (Klarstellung im Gesetzestext, nicht nur in der Begründung):

§ 5 Absatz 3 folgt nach Satz 4:

Dieser Anteil ist auf höchstens 10 Prozent der für den jeweiligen Einsatz vorgesehenen praktischen Ausbildungszeit zu begrenzen.

Die mit der Durchführung der Lerneinheiten nach Satz 4 verbundenen zusätzlichen finanziellen Aufwände der Pflegeschulen sind in den Pauschalen zu den Ausbildungskosten für Pflegeschulen zu berücksichtigen

§ 6 Durchführung der praktischen Ausbildung i.V. mit Artikel 4 (Rehabilitation)

Wir bewerten die Regelungen des § 6, die dem PflBG nachgebildet sind, als sachgerecht. Angesichts der Kürze der Ausbildung spricht sie sich dafür aus, dass Einsätze, die keine Pflichteinsätze sind, auch in anderen geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden können, wie im Bereich Pädiatrie, Psychiatrie, Hospiz oder Reha.

Gemäß der Anlage 7, Tabelle in Abschnitt VI, Nummer 2 in der dritten Spalte (Art. 4, Nr. 9) ist es möglich den weiteren Einsatz, um die Stunden zur freien Verteilung zu verlängern, damit insbesondere im Rahmen der Pflegefachpersonenausbildung bis zu 160 Stunden z.B. im Hospiz oder Rehabilitation stattfinden können. In der Praxis hat sich bestätigt, dass hier insbesondere beim Einsatz in Hospiz und Reha ein Bedarf besteht. Darüber hinaus besteht Bedarf, die Stunden für den "weiteren Einsatz" in der Eingliederungshilfe leisten zu können. Es ist von

essenzieller Bedeutung, dass Pflegekräfte für die besonderen Bedarfe von Menschen mit Behinderung sensibilisiert werden und bereits in der Berufsausbildung hier praktische Erfahrung sammeln können. Bislang war die Voraussetzung für den Einsatz der Stunden zur freien Verteilung an den Versorgungsbereich des Vertiefungseinsatzes geknüpft. Diese Verbindung wird aufgelöst, denn insbesondere im Bereich der Rehabilitation hat dies in den Ländern zu unterschiedlicher Handhabung geführt.

Angesichts der auf 18 Monate begrenzten Ausbildungsdauer der Pflegefachassistentenausbildung ist uns die Sicherung einer hohen Ausbildungsqualität sowie eine fundierte Kompetenzentwicklung in der Praxis ein bedeutendes Anliegen. Es ist daher im Rahmen der Pflegefachassistentenausbildung zielführender, die praktische Ausbildung auf die drei verbindlichen Pflichteinsätze auszurichten und im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu betonen, dass Art. 4, Nr. 9 insbesondere im Hinblick auf den gezeigten Einsatzbedarf von Auszubildenden zur Pflegefachperson nach PflBG in der Rehabilitation und im Hospiz entwickelt wurde. Wir empfehlen daher hinsichtlich der Stunden zur freien Verteilung für die Auszubildenden nach dem Pflegefachassistentengesetz nach einer klaren Abgrenzung zur Regelung für die Auszubildenden nach PflBG.

Wir setzen uns schon seit vielen Jahren dafür ein, dass Rehabilitationseinrichtungen, sofern sie zur Ausbildung im Pflichteinsatz der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtungen geeignet sind, auch Träger der praktischen Ausbildung sein können. Dies ist dann der Fall, wenn die pflegerische Versorgung im Rahmen des Rehabilitationsprozesses alle ausbildungsrelevanten Punkte beinhaltet und die Einrichtung in ausreichendem Umfang zur Ausbildung qualifiziertes Pflegefachpersonal vorhält. Auch der Bundesrat fordert die Ermöglichung der Ausbildung in Rehabilitationseinrichtungen, auch um die Ausbildungskapazitäten zu erweitern.

Die Geeignetheit von Einrichtungen wird nach § 6 Abs. 3 durch die jeweiligen landesrechtlichen Regelungen nachgewiesen. Geeignet sind aus unserer Sicht Rehabilitationseinrichtungen mit dem Schwerpunkt Geriatrie und Neurologie, da dort pflegebedürftige Menschen versorgt werden müssen. Diese Prüfung kann auch bei Rehabilitationseinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen durchgeführt werden, wodurch die Qualität der Ausbildung gewährleistet wird und diese als Träger der praktischen Ausbildung im Rahmen der Pflegefachkraft- und Pflegefachassistentenausbildung fungieren können.

Zudem kann der Pflegeprozess in einer Rehabilitationseinrichtung in seiner gesamten Tiefe und Komplexität vermittelt werden. Auszubildende erleben die Pflege von der Aufnahme bis zur Entlassung, können individuelle Pflegeziele setzen und deren Umsetzung begleiten. Dies fördert ein umfassendes Verständnis für pflegerische Zusammenhänge und stärkt die

Handlungskompetenz der künftigen Pflegefachpersonen. Ein weiterer Vorteil ist die interprofessionelle Zusammenarbeit. Pflegefachpersonen arbeiten in Rehabilitationseinrichtungen eng mit Therapeut_innen, Ärzt_innen und Sozialarbeiter_innen zusammen. Diese Teamarbeit ist ein Kernbestandteil des ganzheitlichen Pflegeprozesses. Gerade in den Schwerpunkten Geriatrie und Neurologie werden zudem spezielle Kompetenzen in der pflegerischen Versorgung von älteren, pflegebedürftigen multimorbiden geriatrischen und/oder neurologisch erkrankten Menschen erworben – Fähigkeiten, die angesichts des demografischen Wandels immer wichtiger werden.

Diese Regelung würde zudem flächendeckend ermöglichen, zusätzliche Ausbildungskapazitäten sowie eine wohnortnahe Ausbildung zu realisieren. Die Zulassung von Reha-Kliniken als Träger praktischer Ausbildung könnte somit zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen, sowie die Ausbildungslandschaft dezentral erweitern und die Versorgungssicherheit im rehabilitativen und pflegerischen Bereich stabilisieren. Dazu sind Anpassungen in § 6 Absatz 1 dieses Gesetzentwurfs sowie in § 7 PflBG erforderlich. Aufgrund von Hinweisen aus der Praxis weisen wir darauf hin, dass es bereits heute zu Engpässen in der derzeitigen Altenpflegehelferausbildung bei den ambulanten Pflichtensätzen kommt.

Es ist klarzustellen, dass die Praxisanleitung in der Rehabilitationsklinik eine entsprechende berufspädagogische Zusatzqualifikation erworben haben muss.

Änderungsbedarfe:

§ 6 Absatz 1 Nummer 1 sollte ergänzt werden:

1. zur Versorgung nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen Krankenhäusern **oder nach §§ 111 SGB V geeigneten medizinischen Rehabilitationseinrichtungen**

In § 6 Absatz 3 sollte hinter Satz 1 eingefügt werden:

Bei der Feststellung der Geeignetheit von Rehabilitationseinrichtungen muss die Gleichwertigkeit der Ausbildung in zugelassenen Krankenhäusern gegeben sein.

Dieselben Änderungen sollten in § 7 Absatz 1 PflBG vorgenommen werden.

§ 7 Träger der praktischen Ausbildung

Für eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Ausbildung in der Pflegeassistenz und der Pflegefachkraftausbildung ist eine bundesweit einheitlich geregelte Finanzierung von Koordinierungsstellen für Praxiseinsätze notwendig. Derzeit hängt deren Finanzierung häufig von freiwilligen Landesförderungen ab – mit der Folge von Engpässen bei Praxiseinsatzstellen und

drohendem Wegfall zentraler Strukturen. Um Planungssicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten, braucht es eine verbindliche Finanzierung.

Die Caritas betont, dass der Schwerpunkt der praktischen Ausbildung stärker beim Träger der praktischen Ausbildung verankert werden sollte, da dies die Bindung an den Träger fördert und zugleich der potenziellen Konkurrenz um Praxiseinsatzplätze Rechnung trägt, die durch die Krankenhausreform und damit dem Wegfall an Einsatzplätzen in der Akutversorgung voraussichtlich zunehmen wird. Grundsätzlich werden drei Pflichteinsätze – Akutversorgung, Langzeitpflege, ambulante Pflege – als wünschenswert angesehen, da sie die generalistische Breite der Ausbildung abbilden. Gleichzeitig muss die aktuelle Situation in den Ländern berücksichtigt werden: Es sollte analysiert werden, inwieweit die Krankenhausreform dazu führen könnte, dass bestehende Praxiseinsatzorte wegfallen, etwa durch eine Evaluation des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. (DiP). Die Ergebnisse dieser Analyse sind in die Evaluation der neuen Ausbildung nach § 54 einzubeziehen. Pragmatismus ist entscheidend: So könnten geeignete Reha-Einrichtungen als zusätzliche Praxiseinsatzorte zugelassen werden, Skill-Labs verstärkt genutzt und die Schulsozialarbeit refinanziert werden, um die Auszubildenden optimal zu begleiten.

Änderungsbedarf:

Die Evaluation nach § 54 sollte berücksichtigen, inwieweit die Krankenhausreform die Verfügbarkeit von Praxiseinsatzplätzen für Auszubildende in der Akutversorgung beeinflusst. Die Ergebnisse sollen genutzt werden, um Engpässe frühzeitig zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Praxiseinsätze abzuleiten.

§ 8 Mindestanforderungen an Pflegeschulen

Aufgrund des demografischen Wandels werden in den kommenden Jahren zahlreiche Lehrpersonen aus den Pflegeschulen ausscheiden, während gleichzeitig geeignete Lehrkräfte mit Masterabschluss fehlen. Daher halten wir es für sachgerecht, wenn die Länder nach Absatz 3 bis zum 31.12.2035 abweichende Regelungen für die Anforderungen an die Qualifikation der Lehrkräfte treffen können. In der Kommentierung des Gesetzesentwurfes wird jedoch die Befristung dieser Regelung bis zum 31.12.2036 genannt. Hier sollte eine Anpassung der Befristung der Regelung erfolgen.

Wir empfehlen deshalb eine Evaluation im Jahr 2031, um zu prüfen, inwieweit Bachelorabsolvent:innen die Möglichkeit haben, zeitnah ein Masterstudium aufzunehmen. Langfristig ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hauptberuflichen Lehrkräften auf Masterniveau und Ausbildungsplätzen zwingend erforderlich.

Der im Entwurf beschriebene Schlüssel von 1:20 ist fachlich begründbar, insbesondere aufgrund der benannten Herausforderungen, die u.a. unterschiedliche Sprachniveaus, Lern- und Förderungsniveaus umfassen. Gegenwärtig und auch in absehbarer Zeit steht jedoch nicht genügend qualifiziertes Lehrpersonal zur Verfügung, um diesen Schlüssel flächendeckend umzusetzen. Eine temporäre Anpassung des Verhältnisses von hauptberuflichen Lehrkräften zu Ausbildungsplätzen nach § 8 Absatz 2 Satz 1 ist kaum vermeidbar.

Angesichts des erhöhten Personalbedarfs sowie der erfahrungsgemäß höheren Abbrecherquoten in den Hilfskraftausbildungen, die insbesondere kleinere Pflegeschulen vor große wirtschaftliche Herausforderungen stellen, empfehlen wir eine verlässliche Kursfinanzierung über die gesamte Ausbildungsdauer von 18 Monaten. Mindestens sollte jedoch eine Regelung analog zur Ausbildungs- und Finanzierungsverordnung nach dem PflBG greifen: Ausbildungsabbrüche von Schülerinnen und Schülern nach dem Stichtag zu Beginn eines Schuljahres dürfen nicht dazu führen, dass Zahlungen gekürzt werden. Konkret bedeutet dies: Wenn ein Schüler während des Schuljahres die Pflegefachassistentenausbildung abbricht, wird die bereits gezahlte Ausgleichszuweisung nicht angepasst. Die Schule behält die auf Basis der ursprünglich gemeldeten Schülerzahl berechnete Ausgleichszahlung; Rückforderungen oder Kürzungen für abgebrochene Schüler innerhalb desselben Schuljahres erfolgen nicht. Diese Regelung gewährleistet Planungssicherheit für die Schulen und stellt sicher, dass die Finanzierung der Ausbildung unabhängig von kurzfristigen Schwankungen gesichert ist.

Wir betonen erneut die hohe Bedeutung zusätzlicher ausbildungsbegleitender Strukturen und empfehlen deren Aufnahme als Tatbestand in Anlage 1 der PflAFinV, da viele Auszubildende in der Assistenz Ausbildung einen Migrations- oder Fluchthintergrund haben und ohne gezielte Unterstützung ein hohes Risiko für einen Abbruch der Qualifizierung besteht.

Positiv zu bewerten ist die Neuregelung des Gesetzentwurfs, dass bei der Ausstattung der Räumlichkeiten und Einrichtungen sowie der Lehr- und Lernmittel den Belangen von Menschen mit Behinderung Rechnung getragen werden muss. Dabei ist nicht nur der räumlichen Barrierefreiheit Rechnung zu tragen, sondern auch der Ausgestaltung der Lernmittel in leichter Sprache.

Änderungsbedarf:

Wir empfehlen zur Erfüllung der Mindestanforderungen nach § 8 eine Kursfinanzierung über die gesamte Ausbildungsdauer von 18 Monaten. Mindestens sollte jedoch eine Regelung nach dem Vorbild der Ausbildungs- und Finanzierungsverordnung des PflBG greifen, sodass Ausbildungsabbrüche nach dem Stichtag zu Beginn eines Schuljahres innerhalb desselben Schuljahres nicht zu Rückforderungen oder Kürzungen der Ausgleichszahlungen führen.

Wir empfehlen, die Schulsozialarbeit sowie Sprachförderung oder vergleichbare sozialpädagogische Unterstützungsangebote an Pflegeschulen als eigenständigen Tatbestand in Anlage I der Pflegeberufausbildungs- und Finanzierungsverordnung, Abschnitt A.1.4, sowie in eine Finanzierungsverordnung zur Pflegefachassistentenausbildung nach § 47 aufzunehmen.

§ 9 Gesamtverantwortung der Pflegeschule

Wir begrüßen, dass die Regelungen zur Gesamtverantwortung der Pflegeschule weitgehend den Vorschriften nach § 10 PflBG entsprechen und als sachgemäß bewertet werden. Jedoch kann die Abstimmung der 18-monatigen Pflegefachassistenten-Ausbildung mit der 36-monatigen Pflegefachausbildung eine Herausforderung darstellen, insbesondere bezüglich der Start- und Endpunkte sowie der Ausbildungsinhalte.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden und die Durchlässigkeit zwischen der 18-monatigen Pflegefachassistentenausbildung und der 36-monatigen Pflegefachausbildung zu sichern, sollten Pflegeschulen mehr Flexibilität bei der Festlegung von Startpunkten und Ausbildungsinhalten erhalten.

Wir fordern darüber hinaus, dass einzügige Pflegeschulen gezielt in die Lage versetzt werden, Anpassungslehrgänge anzubieten, um die „6-Monatslücke“ zwischen Ende und Startpunkt eines neuen Pflegefachassistenten-Kurses bedarfsgerecht zu schließen. Trotz eines klar erkennbaren Bedarfs fehlen in vielen Regionen entsprechende Angebote. Einzügige Schulen könnten hier eine bedeutende Rolle übernehmen, indem sie regionale Bedarfe erheben und passgenaue Lehrgänge entwickeln. Zur Entlastung der Schulen und Beschleunigung der Umsetzung regen wir an, vorhandene Muster-Curricula aus den Landesbehörden zu nutzen. Sie reduzieren den organisatorischen Aufwand erheblich. Da jedoch nicht alle Bundesländer entsprechende Muster bereitstellen, sprechen wir uns dafür aus, ein einheitliches Muster-Curriculum auf Bundesebene zu entwickeln. Dieses sollte durch die Fachkommission nach § 53 PflBG erarbeitet und veröffentlicht werden.

Die Finanzierung solcher Lehrgänge erfolgt in der Regel über die AZAV-Zertifizierung und die Förderung durch die Agentur für Arbeit. Wir fordern, dass der bürokratische Aufwand für die AZAV-Zertifizierung deutlich reduziert wird. In diesem Zusammenhang sollten die Empfehlungen des AZAV-Beirats nach § 182 SGB III in der Praxis stärker berücksichtigt werden: Fachkundige Stellen sollten bei Träger- und Maßnahmenzulassungen unabhängige Anerkennungen – etwa durch Länder oder Kammern – vollständig berücksichtigen. Ziel ist es, den Aufwand für Pflegeschulen zu verringern und unnötige Doppelprüfungen zu vermeiden.

Änderungsbedarf:

Nach § 9 Absatz 2 wird ein neues Absatz 3 eingefügt:

„(3) Die Pflegeschule hat das Recht, Beginn und curricularen Inhalt der Ausbildung nach dem PflAssG an die Ausbildung nach dem PflBG anzupassen, um einen barrierefreien Übergang zu ermöglichen.“

§ 10 Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung

Wir unterstützen, dass der Hauptschulabschluss Voraussetzung für den Zugang zur Pflegefachassistentenausbildung sein soll. Zu begrüßen ist auch, dass auch eine abgeschlossene Berufsausbildung anstelle eines Hauptschulabschlusses zur Pflegeassistentenausbildung berechtigen soll. Absatz 2 sieht vor, dass bei fehlendem Hauptschulabschluss oder einer abgeschlossenen Berufsbildung alternativ eine Prognose der Pflegeschule über den Zugang zur Assistentenausbildung entscheiden soll. Nach unserer Auffassung sollte nicht die Pflegeschule allein diese Verantwortung übernehmen müssen; die Entscheidung sollte stets gemeinsam mit dem Träger der praktischen Ausbildung getroffen werden. Die Prognose der Schule sollte auf einem bundeseinheitlichen Assessment basieren, daher plädieren wir für die Entwicklung eines einheitlichen Verfahrens (siehe dazu Stellungnahme zu Artikel 1 § 45).

Aktuell fehlt es im Pflegebildungssystem an Durchlässigkeit, da der Zugang zur Pflegefachausbildung ohne Schulabschluss nicht möglich ist. Wir halten es daher für sinnvoll, Modellprogramme in den Ländern zu fördern, die es ermöglichen, den Abschluss zur Pflegefachassistentenperson und einen Hauptschulabschluss in Teilzeit gleichzeitig zu erwerben. Dies schafft die nötige Anschlussfähigkeit zur Ausbildung nach dem PflBG. Eine Förderung solcher Programme sollte entsprechend der Maßgaben zur „Assistierten Berufsausbildung, Berufsausbildungsbeihilfe und Mobilitätzuschuss“ des § 57 SGB III erfolgen und in den Ausbildungspauschalen für die Träger berücksichtigt werden.

Änderungsbedarf:

In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „Prognose der Pflegeschule“ die Wörter „und des Trägers der praktischen Ausbildung“ ergänzt.

§ 11 Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen und Berufserfahrung

Wir begrüßen die Möglichkeit, auf Antrag eine abgeschlossene Ausbildung, Teile einer Ausbildung sowie Berufserfahrung im Umfang ihrer Gleichwertigkeit bis zu einem Drittel der Dauer einer Ausbildung zur Pflegeassistenten anzurechnen. Dies fördert die Durchlässigkeit im Bildungssystem und verhindert das wiederholte Lernen bereits erworbener Kompetenzen, was

den Grundforderungen des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) entspricht. Besonders für Personen, die ihre Pflegefachausbildung abgebrochen haben, eröffnen sich dadurch neue Perspektiven zur Anerkennung bereits erworbener Kompetenzen und zum Erwerb eines anerkannten Ausbildungsabschlusses im Bereich Pflege.

Angesichts des dringenden Bedarfs an Pflegefachassistenten halten wir die Regelungen zur Anrechnung und Verkürzung der Pflegefachassistentenausbildung für angemessen, auch wenn sie die Zeit für die Kompetenzentwicklung begrenzen. Zusätzlich begrüßen wir die Möglichkeit, dass bei erfolgreichem Bestehen der Zwischenprüfung zur Pflegefachperson nach § 6 Absatz 5 des PflBG, die Dauer der praktischen Pflegefachassistenten-Ausbildung sowie der theoretische und praktische Unterricht durch Anrechnung vollständig verkürzt werden können. Wir unterstützen ferner, dass die Fachkommission nach § 53 auf Basis der Empfehlungen des BIBB mit der Erarbeitung des 320 Stundenkurses zur Vorbereitung der staatlichen Abschlussprüfung beauftragt wird. Wir bewerten die Anerkennung von Berufserfahrung auf praktische Ausbildungsinhalte grundsätzlich sinnvoll. Dabei sollte jedoch eine Grenze von 24 Monaten Berufserfahrung in Vollzeit als Voraussetzung für die Verkürzung der Ausbildung festgelegt werden.

Änderungsbedarf:

In § 11 Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort „18“ durch „24“ ersetzt.

§ 12 Anrechnung von Fehlzeiten

Die mit 14 Wochen bemessenen Fehlzeiten aufgrund mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbots erachten wir bei einer Ausbildungsdauer von 18 Monaten für zu knapp bemessen. Es sollte daher geregelt werden, dass sich die Ausbildungsdauer automatisch um die jeweilige Fehlzeit verlängert.

§ 13 Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeassistentenberufs

Es ist uns unklar, welches Ziel mit den Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeassistentenberufs erreicht werden soll. Das Ziel wäre daher zu präzisieren, bevor die Regelung bewertet werden kann.

Das Ziel der Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegefachassistentenberufs bleibt unklar und sollte präzisiert werden, um die Regelung abschließend zu bewerten. Wichtig ist jedoch, dass diese Vorhaben nicht auf schulische und praktische Ausbildung beschränkt werden sollten. Erfolgreiche Ansätze im Umgang mit der Beseitigung von Ausbildungshemmnissen aus den Bundesländern, wie die Pflegehelferausbildung mit intensiver Deutschförderung in Baden-Württemberg, zeigen, dass innovative Konzepte die Abbruchquote deutlich reduzieren

und die Ausbildungsqualität steigern können. Diese bewährten Modelle müssen gesichert und weiterverfolgt werden. Ein erfolgreich erprobtes Modell sollte zudem nach Ablauf der Erprobungszeit unbefristet fortgeführt werden können. Das fordert auch der Bundesrat.

Änderungsbedarf:

In Absatz 1 Satz 1 sind nach dem Wort „Ausbildung“ die Wörter „sowie zur Beseitigung individueller Ausbildungshindernisse“ einzufügen

§ 14 Ausbildungsvertrag

Nach Absatz 4 sind auf den Ausbildungsvertrag die für Arbeitsverträge geltenden Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze anzuwenden. Allerdings sollen nach § 49 PflAssG/PflHilfG E die Regelungen des BIBB bis auf die Aufgabenzuweisung zum BIBB wie bei § 63 PflBG keine Anwendung finden. Damit ist aber noch nicht entschieden, ob Streitigkeiten über den Ausbildungsvertrag den Weg zu den Arbeitsgerichten oder aber zu den Verwaltungsgerichten finden. Es wird vorgeschlagen klarzustellen, dass der Weg zum Arbeitsgericht gegeben ist.

Änderungsbedarf:

§ 14 Absatz 4 wird um folgenden Satz ergänzt:

“Bei Streitigkeiten aus dem Ausbildungsvertrag gilt die auszubildende Person als zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 ArbGG”.

§ 17 Ausbildungsvergütung

Wir begrüßen ausdrücklich, dass aufgrund der bundeseinheitlichen Regelung der Pflegeassistenzausbildung auch eine bundeseinheitliche Regelung zur Gewährung einer Ausbildungsvergütung getroffen wird; bislang wurde eine Ausbildungsvergütung nur bei in etwa der Hälfte der 27 unterschiedlichen landesrechtlich geregelten Ausbildungen gezahlt und dies auch in unterschiedlicher Höhe.

Der Gesetzentwurf geht von einer Höhe der Ausbildungsvergütung von minus 16,5 Prozent gegenüber den Ausbildungsvergütungen von Pflegefachpersonen aus und begründet dies mit der entsprechenden Vergütungsdifferenz. Der Gesetzentwurf scheint sich dabei an den tariflichen Bedingungen des TV(A)öD zu orientieren, welcher keine Regelung für die Pflegehelferausbildung kennt und damit auch keinen Vergütungsansatz. In der AVR der Caritas existieren jedoch aus der Vergangenheit fortgeführte Vergütungsregelungen für Ausbildungsvergütungen der Helferausbildungen. Diese sehen eine nur rund 5,56% niedrigere Vergütung vor als für das entsprechende erste Ausbildungsjahr der Pflegefachpersonen. Sollte sich das Modell der 16,5-prozentig geringeren Ausbildungsvergütung als Maßstab etablieren und seinen

Niederschlag in der Refinanzierung finden, wäre die Neuregelung ein erheblicher Rückschritt für die Auszubildenden. Das wäre nicht hinnehmbar. Es muss der Grundsatz gelten, dass eine tarifliche Ausbildungsvergütung als wirtschaftlich zu betrachten und demnach über die Fonds zu refinanzieren ist. Der Gesetzgeber muss daher eine Regelung analog zu § 82c Absatz 1 SGB XI schaffen.

Änderungsbedarf:

In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

“Bei tarifgebundenen oder an kirchliche Arbeitsrechtsregelungen gebundenen Trägern kann eine Bezahlung der Ausbildungsvergütung bis zur Höhe der aus dieser Bindung resultierenden Vorgaben nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden”

§ 18 Probezeit

Die auf 4 Monate bemessene Dauer der Probezeit erachten wir ausdrücklich als sachgerecht.

§ 24 Finanzierung in Verbindung mit § 47

Wir begrüßen nachdrücklich, dass die Finanzierung der Pflegefachassistentenausbildung dem PflBG nachgebildet ist und über den Ausbildungsfonds erfolgt. Sehr zu begrüßen ist, dass der Wertschöpfungsanteil komplett entfällt. Wir fordern in diesem Zusammenhang erneut, dass der Wertschöpfungsanteil auch für die Pflegefachkraftausbildung künftig entfallen solle. Wie die Begründung ausführt, ist während der Ausbildung eine effektive Mitarbeit im Betrieb nicht möglich.

§ 27 Absatz 1 PflBG, der auch für die Pflegefachassistentenausbildung gilt, führt unter den Investitionskosten auch die für den jeweiligen Betrieb notwendigen Gebäudekosten auf. Unklar ist, ob die Mietkosten der Pflegeschule den Gebäudekosten zuzuordnen sind und somit in die Finanzierungszuständigkeit der Länder fallen oder ob sie zu den Betriebskosten zählen und damit durch die Umlage finanziert werden. Es ist zu regeln, dass die Investitionskosten von Schulen in freier Trägerschaft einschließlich der Mietkosten vollumfänglich zu refinanzieren sind. Dies sollte im Gesetz unzweifelhaft klargestellt werden.

Durch die Kostenbeteiligung der Pflegeversicherung an der Finanzierung der Ausbildungskosten mit einem Anteil von 3,6 Prozent Direktzahlungen, hier kalkuliert mit 14,6 Mio. Euro, wird der Kostenanteil der von den Pflegendürftigen für die Ausbildung aufzubringenden Kosten zwar gesenkt, indem diese Kosten von der Solidargemeinschaft der Versicherten getragen werden. Wir setzen uns jedoch dafür ein, die Kosten für die Ausbildung, die bereits für die Fachkraftausbildung mit monatlich ca. 150- 200 Euro sehr hoch sind, zu reduzieren, indem diese Kosten

zum einen aus Steuermitteln, zum anderen durch eine Erhöhung des Kostenanteils der Länder getragen werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der deutlichen Kostenentlastung der Länder, die bisher die Kosten für die Pflegehelferausbildung tragen mussten, ist dies umso mehr gerechtfertigt.

Es ist dringend notwendig, die Regelungen im PflBG und der PflAFinV anzupassen, um die Umlage der Ausbildungskosten auf die Pflegeeinrichtungen und letztlich auf die Eigenanteile der Pflegebedürftigen zu beenden. Die Ausbildung der zukünftigen Pflegekräfte ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die durch Steuermittel finanziert werden sollte. Die Abschaffung des Umlageverfahrens würde nicht nur die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen senken, sondern auch das Bürokratieaufkommen in den Einrichtungen erheblich reduzieren.

Angesichts der sprachlichen Defizite vieler Auszubildender, insbesondere mit Migrations- oder Fluchthintergrund, sind zusätzlich verlässliche Teilzeitangebote zur Absolvierung der Ausbildung mit integriertem Deutschunterricht sowie die verbindliche Refinanzierung ausbildungsunterstützender Begleitung an Pflegeschulen erforderlich. Das hierfür qualifizierte Personal wird jedoch häufig nicht über den Ausbildungsfonds anerkannt, wodurch es an diesen dringend benötigten Angeboten mangelt. Wir unterstreichen daher die hohe Bedeutung dieser ausbildungsbegleitenden Strukturen und empfehlen, ihre Förderung als festen Tatbestand in Anlage 1 der PflAFinV zu verankern.

Änderungsbedarf:

Die Zielsetzung des § 24 Absatz 1 Nummer 1 sollte dahingehend präzisiert werden, dass eine qualitätsgesicherte Ausbildung auch die Finanzierung von Schulsozialarbeit und Sprachunterricht einschließt.

Streichung von § 27 Abs. 2 PflBG (Wertschöpfungsanteil)

§ 25 Gleichwertigkeit und Anerkennung von Ausbildungen

Um den bürokratischen Aufwand und die Kosten für Antragstellende zu reduzieren, schlagen wir vor, dass bei einem Defizitbescheid zur Gleichwertigkeit einer internationalen Ausbildung zur Pflegefachperson automatisch auch die Gleichwertigkeit zur Pflegefachassistenz geprüft wird. So entfällt die erneute Einreichung von Unterlagen wie Übersetzungen und beglaubigte Kopien. Zudem empfehlen wir verbindliche Bearbeitungsfristen von maximal drei Monaten für Anerkennungsverfahren, da diese derzeit oft langwierig und intransparent sind.

Da die Ausbildung zur Pflegeassistenz bundesweit einheitlich geregelt ist, plädieren wir für ein einheitliches Bewertungsmuster (Assessment) für die Gleichwertigkeitsprüfung von Abschlüssen aus Drittstaaten. Zudem bedarf es einer digitalen Plattform, die unterschiedliche

ausländische Ausbildungsniveaus für Pflegeberufe darstellt und aufzeigt, welche Auflagen mit welchen internationalen Abschlüssen erfüllt werden müssen. Dies würde Verfahren vereinheitlichen, Bürokratie abbauen und Transparenz erhöhen.

Wir plädieren dafür, auch zwölfmonatige ausländische Abschlüsse von Pflegehelfer/-Assistenzberufen aus Drittstaaten (mit höchstens zwölfmonatigen zielgerichteten Anpassungsmaßnahmen) als gleichwertig anzuerkennen. Eine zentrale Institution sollte mit der Prüfung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen und der Erarbeitung einer oben angeführten Plattform zu Qualifikationsniveaus unterschiedlicher Abschlüsse beauftragt werden. Dafür bietet sich ein Ausbau der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) an. Zudem plädieren wir für eine bundesweit einheitliche Positivliste von Pflegeausbildungen aus Drittstaaten, die grundsätzlich als gleichwertig zur deutschen generalistischen Pflegeausbildung anzusehen sind. Diese Liste sollte zentral, z. B. durch die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG), geführt, regelmäßig aktualisiert und um Informationen ergänzt werden. Flankierend braucht es zentrale Beratungseinrichtungen („Lotsen“), die insbesondere kleinere und mittlere Einrichtungen bei der Anwerbung, Anerkennung und Integration ausländischer Fach- und Arbeitskräfte unterstützen.

§ 26 Eignungsprüfung oder Anpassungslehrgang

Wir begrüßen die Zielsetzungen der §§ 26 und 27, die auf die Durchführung der Gleichwertigkeitsprüfung für ausländische Berufsqualifikationen im Pflegebereich abzielen. Besonders wichtig ist die Reduzierung des bürokratischen und zeitlichen Aufwands, um den Prozess für Antragstellende zu erleichtern.

Wir halten jedoch die Regelung im Satz 2, die einen Anpassungslehrgang in der gleichen Dauer wie die reguläre Ausbildung zur Pflegefachassistenz vorsieht, für wenig zielführend. Eine kürzere und gezielt auf die Defizite ausgerichtete Anpassungsmaßnahme wäre effektiver, um spezifische Lücken zu schließen, ohne die Antragstellenden unnötig zu belasten. Nach Absatz 2 hat der Antragstellende grundsätzlich die Wahl zwischen Eignungsprüfung oder Anpassungslehrgang, was aus unserer Sicht immerhin eine Verbesserung darstellt.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten für Qualifizierungen ausgeweitet werden sollten. Derzeit bieten die Bundesagentur für Arbeit, das Bundesministerium für Bildung und Forschung durch den Anerkennungszuschuss sowie die Bundesländer spezielle Förderprogramme an. Eine gehaltsabhängige anteilige Förderung könnte die finanzielle Belastung reduzieren und den Zugang zu Ausgleichsmaßnahmen erleichtern.

§ 28 Feststellungsbescheid

Wir begrüßen die Regelung in § 28, die es ermöglicht, die Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation der antragstellenden Person bereits vor der Erfüllung aller übrigen Voraussetzungen nach § 2 zu prüfen. Die Möglichkeit, einen isolierten Feststellungsbescheid zu beantragen, der sich speziell auf die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation bezieht halten wir für sachgerecht.

Wir empfehlen jedoch eine klare Regelung, ab wann der Antrag auf Gleichwertigkeit gestellt werden kann. Eine frühzeitige Möglichkeit zur Antragstellung ist essenziell, um den Antragstellenden die bestmögliche Vorbereitung auf den Berufsstart zu ermöglichen.

§ 45 Beratung; Aufbau unterstützender Angebote und Forschung

§ 45 des Pflegefachassistentengesetzes (PflFAssG) regelt die Aufgaben des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Im ursprünglichen Gesetzentwurf war vorgesehen, dass das BIBB umfassende Aufgaben übernimmt, insbesondere die Ausarbeitung von Empfehlungen für die Prognoseentscheidung nach § 10 Absatz 2 PflFAssG und das Kompetenzfeststellungsverfahren nach § 11 Absatz 1 Nummer 3 PflFAssG. Dafür setzen wir uns weiterhin ebenso wie der Bundesrat ein. Wir begrüßen, dass das BIBB im Gesetzentwurf nun ausdrücklich auch die Aufgabe der Forschung zum Pflegeassistenten- und Pflegefachberuf erhalten hat, insbesondere auch zur Unterstützung der Arbeit der Fachkommission.

Änderungsbedarfe:

(2) Das Bundesinstitut für Berufsbildung entwickelt Empfehlungen für die Prognoseentscheidung der Pflegeschule nach § 10 Absatz 2.

(3) Das Bundesinstitut für Berufsbildung entwickelt unter Beteiligung der Fachkommission Empfehlungen zum Kompetenzfeststellungsverfahren nach § 11 Absatz 1 Nummer 3.“

§ 46 Statistik; Verordnungsermächtigung

Diese Regelung ist sachgerecht, um umfassende und verlässliche Daten über den Stand und die Entwicklung der Pflegeassistentenausbildung zu sammeln.

Anmerkungen und Empfehlungen:

1. **Erhebung vorhandener Daten:** Es ist positiv, dass keine zusätzlichen Daten erhoben werden müssen, sondern dass ausschließlich die bereits vorhandenen Daten verwendet werden, die den zuständigen Stellen gemäß § 26 Absatz 4 des PflBG und § 24 des Pflegeassistentengesetzes zur Verfügung stehen. Dies minimiert den administrativen Aufwand und vermeidet die Erhebung redundanter Daten. Zudem gilt es die Synthese

der bestehenden Instrumente auf Länderebene voranzutreiben, um die Anzahl der Datenerhebungen zu minimieren.

2. **Transparenz:** Zur Förderung von Transparenz sollte die erhobene Datenlage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ein Pflegeausbildungs-Dashboard könnte als Plattform dienen, um die gesammelten Daten übersichtlich und verständlich darzustellen. Dies würde nicht nur die Transparenz erhöhen, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Qualität und Entwicklung der Pflegeausbildung stärken.

Insgesamt begrüßen wir die Regelung als einen Schritt zur Verbesserung der Datenbasis für die Pflegeassistentenausbildung und zur Unterstützung einer fundierten und transparenten Bildungspolitik im Pflegebereich.

§ 47 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Finanzierung; Verordnungsermächtigungen

Es bleiben viele Aspekte der Ausbildungsinhalte noch unklar. Es fehlen Details zu den Inhalten, Theorie- und Praxiseinheiten sowie den Einsätzen in verschiedenen Settings. Eine fundierte Kommentierung ist daher momentan nur eingeschränkt möglich. Eine klare Übersicht wird erst durch die Entwürfe zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung möglich sein, die die konkrete Umsetzung der Ausbildung und die Praxisrelevanz der angestrebten Kompetenzen detailliert darstellen werden. Es ist daher dringend zu empfehlen, diese Verordnungsentwürfe zeitnah vorzulegen und den Fachverbänden ausreichend Zeit zur Stellungnahme einzuräumen. In jedem Fall sollte die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Vorgaben machen, die den besonderen Bedarfen von jungen Menschen mit Behinderung, die eine Ausbildung zur Pflegeassistentin absolvieren wollen, Rechnung trägt. In den Regelungen des BBiG (§§ 64ff.) sowie in der PflAPrV sollten Regelungen für eine flexibel zu gestaltende Ausbildung mit Blick z.B. auf verlängerte Prüfungszeiten, Hilfsmittelzulassung, Einsatz von Dolmetschenden z.B. bei Hörbehinderungen sowie leichte oder einfache Sprache in der Ausbildung oder bei der Prüfung vorgesehen werden.

§ 50 Fortgeltung der Berufsbezeichnung

Wir begrüßen die Klarstellung in den Bestandschutzregelungen nach § 50. Diese Anpassung gewährleistet, dass der Bestandschutz für alle anerkannten Assistenz- und Helferausbildungen landesweit durchgängig erhalten bleibt. Es wird sichergestellt, dass die Regelungen nicht nur für Ausbildungen gelten, die den von der Sozialministerkonferenz 2012 und der Gesundheitsministerkonferenz 2013 festgelegten Mindestanforderungen entsprechen. Diese

Klarstellung ist sachgerecht und notwendig, um den Personalmix in der Pflege sicherzustellen.

§ 53 Übergangsvorschrift für Anerkennungsverfahren ausländischer Assistenzabschlüsse

Wir begrüßen grundsätzlich die in § 53 vorgesehene Übergangsvorschrift zur Anerkennung ausländischer Assistenzabschlüsse. Sie schafft Rechtssicherheit und gewährleistet, dass das Potenzial internationaler Pflegekräfte auch nach Einführung der neuen Pflegefachassistentenausbildung zum 1. Januar 2027 weiterhin nutzbar bleibt. Dadurch können ausländische Abschlüsse bis zum 31. Dezember 2028 auf Grundlage der bisherigen landesrechtlichen Regelungen anerkannt werden, sofern sie den von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und der Gesundheitsministerkonferenz 2013 beschlossenen Mindeststandards entsprechen.

Kritisch sehen wir jedoch, dass sich die Regelung weiterhin auf landesrechtliche Vorgaben stützt. Dies birgt die Gefahr einer zementierten föderalen Uneinheitlichkeit in der Anerkennungspraxis. Ein bundeseinheitlicher Rahmen zur Bewertung ausländischer Abschlüsse wäre im Sinne einer verlässlichen und transparenten Verfahrenserleichterung dringend geboten.

Um unnötige Härten zu vermeiden, bedarf es daher einer frühzeitigen, mehrsprachigen und gut zugänglichen Informationskampagne, die sowohl ausländische Pflegekräfte als auch Träger gezielt über Ablauf und Fristen zur Anerkennung informiert.

Insgesamt stellt § 53 eine sinnvolle Übergangslösung dar – sollte jedoch zwingend von flankierenden Maßnahmen begleitet werden.

Artikel 2: Pflegeberufegesetz

Wir begrüßen ausdrücklich die Anpassung des § 9 Absatz 3 Satz 2 PflBG, mit der die Übergangsregelung für den Einsatz von Lehrkräften nach dem PflBG bis 2035 verlängert wird. Dies schafft dringend benötigte Klarheit und Planungssicherheit für die Pflegeschulen.

Die Angleichung der Frist ist sachgerecht und verhindert zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Sie nimmt berechtigte Rückmeldungen aus der Praxis auf, wonach Unklarheit darüber bestand, ob die Übergangsregelung im Gesetzentwurf ausschließlich für die Pflegefachassistentenausbildung gelten sollte. Diese Präzisierung ist daher konsequent und wird ausdrücklich begrüßt.

Artikel 5: Änderung der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung

Weiterer Änderungsbedarf zu § 12 Aufteilung des Finanzierungsbedarfs auf die Pflegeeinrichtungen, hier: bundeseinheitliche Regelung zum Finanzierungsbedarf in der Tagespflege

In der Praxis ist in mehreren Bundesländern ein Problem bei der Berechnung des Umlagebetrags für die Tagespflege aufgetreten. So wird die fondsverwaltende Stelle in NRW aufgrund der Begründung zum Pflegestudiumstärkungsgesetz (Seite 158 der Drucksache 20/8901) nicht mehr bereit, wie bisher, eine Differenzierung zwischen einem Berechnungstag in der Tagespflege und einem Berechnungstag in einer vollstationären Einrichtung vornehmen. Begründet wird dies mit "wettbewerbsneutralen Ausbildungszuschlägen für die stationäre Pflege".

Ein vollstationärer Belegungstag unterscheidet sich jedoch deutlich von einem Belegungstag in der Tagespflege: Er umfasst eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung (24/7), während ein teilstationärer Belegungstag zeitlich begrenzt ist. Dieser längere Betreuungszeitraum erfordert einen höheren Einsatz an Pflegefachkräften und rechtfertigt somit eine höhere Kostenstruktur.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird eine Gewichtung der Berechnungstage in teilstationären Pflegeeinrichtungen mit einem Faktor von 0,5 umgesetzt. Diese Gewichtung basiert auf folgender Überlegung: Einerseits ist der Bedarf an Pflegefachkräften in der vollstationären Pflege zeitlich gesehen dreimal so umfangreich wie in der Tagespflege, was für einen Faktor von 0,33 spräche. Da jedoch andererseits in der vollstationären Pflege 9 bis 10 Stunden Nachtwachenzeit mit deutlich geringerer Personalisierung und Fachkräfteeinsatz anfallen, ist ein Gewichtungsfaktor von 0,5 angemessen. Für einen solchen Faktor setzt sich auch der Bundesrat ein.

Eine bundeseinheitlich geregelte Differenzierung bei der Gewichtung der Berechnungstage ist notwendig, um die tatsächlichen Unterschiede im Personalbedarf und Betreuungsaufwand abzubilden. § 12 Abs. 2 PflAFinV ist um eine Regelung zu ergänzen, die das Umlageverfahren auf der Landesebene kennt und die sich dort bewährt hat.

Änderungsbedarf:

§ 12 Absatz 2 PflAFinV ist wie folgt zu ergänzen:

„Liegt die durchschnittliche Auslastung im ersten Halbjahr des laufenden Kalenderjahres nachweislich bei vollstationären Plätzen unter 90 v. H. oder bei teilstationären Plätzen unter 60 v.

H. der Plätze, so wird auf Antrag der Einrichtung anstelle der Plätze die tatsächlich ausgelastete Platzzahl der Einrichtung der Ermittlung des Ausgleichsbetrags zugrunde gelegt.“

Entfristung der Möglichkeit zur Differenzierung der Pauschalen nach § 4 Absatz 2 PflAFinV

Wir begrüßen ausdrücklich die Möglichkeit zur Differenzierung der Pauschalen gemäß § 4 Absatz 2 der Pflegeausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV). Aus unserer Sicht sollte diese Regelung über das Jahr 2028 hinaus entfristet und dauerhaft erhalten bleiben.

Insbesondere kleinere Pflegeschulen im ländlichen Raum sowie ambulante Ausbildungseinrichtungen sehen sich mit besonderen strukturellen und organisatorischen Herausforderungen konfrontiert. Diese Einrichtungen verfügen häufig nicht über die personellen oder infrastrukturellen Ressourcen größerer Träger und können daher nur eingeschränkt von Synergieeffekten profitieren. Die differenzierte Pauschalierung hat sich in diesen Kontexten als ein wichtiges Instrument zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung bewährt.

Änderungsbedarf:

§ 4 Absatz 2 ist wie folgt zu ändern:

Eine Differenzierung der Pauschalen für einen Kostentatbestand ist ~~nur bis zum Festsetzungsjahr 2028~~ zulässig, und nur dann, wenn die Differenzierung nach sachgerechten, allgemeinen, objektiven und für alle Träger der praktischen Ausbildung oder für alle Pflegeschulen gleichen Kriterien erfolgt. Unzulässig ist insbesondere eine Differenzierung nach Versorgungsbereichen oder Trägerstrukturen ohne einen sachlichen Grund.

Artikel 6: Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Wir begrüßen mit Nachdruck, dass die neue Pflegeassistentenausbildung als eine quasi-duale Berufsausbildung in die Fördermaßnahmen „Assistierte Berufsausbildung, Berufsausbildungsbeihilfe und Mobilitätzuschuss“ des § 57 SGB III einbezogen wird. Damit kann eine Förderung der neuen Ausbildung nach dem BAföG erfolgen. Von dieser Neuregelung gehen somit erhebliche Anreize für die neue Berufsausbildung als Pflegeassistent/in einher, denn von dieser Fördermöglichkeit werden insbesondere Personen mit geringer Schulbildung profitieren. Durch Einfügung der Pflegeassistentenausbildung in § 54a SGB III wird zudem eine Förderung von Einstiegsqualifikationen ermöglicht, was gleichermaßen sehr zu begrüßen ist.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein wichtiger Schritt zur Vereinheitlichung der Pflegeassistentenausbildung. Um jedoch die Attraktivität der Ausbildung zu steigern und praktische

Herausforderungen zu bewältigen, sind die genannten Nachbesserungen unerlässlich. Wir appellieren an den Gesetzgeber, diese Anregungen aus der Praxis aufzunehmen.

Berlin/Freiburg, 26. September 2025

Deutscher Caritasverband
Dr. Susanne Pauser
Vorständin für Personal und Digitales

Kontakt

Dr. Elisabeth Fix, Leitung Kontaktstelle Politik, Deutscher Caritasverband
Tel. 030 284447-46, elisabeth.fix@caritas.de

Sascha Andree, Referent Personal und Ausbildung, VKAD
Tel. 030 284447-856, sascha.andree@caritas.de

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin, Kath. Krankenhausverband Deutschland,
Tel. 030 2408368-10, bernadette.ruemmelin@caritas.de

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Ausschussdrucksache 21(13)9c
vom 26. September 2025

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefach-
assistenzausbildung“

BT-Drucksache 21/1493

Dominik Feldmeier
Deutscher Landkreistag



Deutscher Landkreistag, Postfach 11 02 52, 10832 Berlin

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Frau Vorsitzende Saskia Esken, MdB
11011 Berlin

per E-Mail: bildungundfamilie@bundestag.de

Ulrich-von-Hassell-Haus
Lennéstraße 11
10785 Berlin

Tel.: 030 590097-342
Fax: 030 590097-412

E-Mail: Dominik.Feldmeier
@Landkreistag.de

AZ: IV-431-08/0

Datum: 26.9.2025

Öffentliche Anhörung am 6.10.2025 zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung“ (BT-Drs. 21/1493)

Sehr geehrte Frau Esken,

haben Sie besten Dank für die Einladung zur Sachverständigen-Anhörung am 6.10.2025 zum Regierungsentwurf eines Pflegefachassistentengesetzes. Der Deutsche Landkreistag, der in der Anhörung durch Herrn Referenten Dominik Feldmeier vertreten wird, nimmt wie folgt schriftlich Stellung.

Zusammenfassung

- Der Deutsche Landkreistag begrüßt die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung, mit der ein klares und einheitliches Berufsbild geschaffen wird.
- Die 18-monatige Dauer wird überwiegend befürwortet. Zugleich ist die Möglichkeit, in die generalistische Pflegeausbildung überzugehen, unabdingbar. Hier muss für Absolventen der 18-monatigen Ausbildung eine gute Durchlässigkeit ermöglicht werden, da die generalistische Ausbildung häufig nur zum vollen Ausbildungsjahr beginnt.
- Dass als Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung der Hauptschulabschluss vorgesehen ist, wird als zielgruppengerecht befürwortet.
- Zu kritisieren ist, dass wichtige Parameter fehlen und erst in der noch ausstehenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung definiert werden sollen. Demzufolge fehlen Angaben zu den angesetzten Stunden für den Unterricht und die praktische Ausbildung sowie für die verschiedenen Pflichteinsätze.

Im Einzelnen

Die Landkreise sind vorliegend in unterschiedlichen Funktionen betroffen, insbesondere als Träger von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, als Träger von Berufsbildenden Schulen und Pflegeschulen, als Träger der Sozialhilfe und als Heimaufsicht.

Ein bundesweit einheitlich geregeltes Berufsbild einer Pflegefachassistenz und die Umsetzung eines dazugehörigen einheitlich geregelten Finanzierungsverfahrens sind angesichts der derzeit 27 unterschiedlichen Pflegehilfe- bzw. Pflegeassistentenausbildungsgängen in den Ländern und des großen Pflegemangels dringend notwendig.

Richtig ist des Weiteren, den Beruf als Heilberuf auszugestalten und den Pflegefachassistentenkräften Aufgaben zu übertragen, die derzeit zum Teil von Pflegefachkräften wahrgenommen werden. Dies ist für die Umsetzung in der Praxis eine maßgebliche Stellschraube.

Zu Art. 1 des Entwurfs, Gesetz über den Pflegefachassistentenberuf (PflFAssG)

- Zu § 2 Nr. 4 PflFAssG-E, Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis: Erforderliche Sprachkenntnisse

Der Gesetzentwurf fordert, dass die betroffenen Personen über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Es fragt sich, welches Sprachniveau dies konkret sein soll. Die Gesetzesbegründung verweist auf das Sprachniveau B2 GER, an dem sich die Sprachkenntnisse „orientieren sollen“. Für die Praxis stellt sich die Frage, ob bei Nichtvorliegen dieses Sprachniveaus im Einzel- und Ausnahmefall gleichwohl die Erlaubnis erteilt werden kann. Hier bedarf es einer flexiblen Handhabung.

- Zu § 5 PflFAssG-E, Dauer und Struktur der Ausbildung

Die Vorgabe in Abs. 1, dass die Ausbildung 18 Monate dauert, wird von uns überwiegend befürwortet.

Allerdings müssen für die Verlängerung der Ausbildung zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden, die schon im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung nicht überall zur Verfügung stehen. Der große Mangel an Lehrkräften hat weiter zugenommen. Es muss vermieden werden, dass die Ausbildungskapazitäten gedeckelt werden.

Zugleich ist die Möglichkeit, in die generalistische Pflegeausbildung überzugehen, unabdingbar. Hier muss für Absolventen der 18-monatigen Ausbildung eine gute Durchlässigkeit ermöglicht werden, da die generalistische Ausbildung häufig nur zum vollen Ausbildungsjahr beginnt.

Abs. 3 sieht eine Praxisanleitung von mindestens zehn Prozent der auf den jeweiligen Einsatz entfallenden praktischen Ausbildungszeit vor. Aus der Gesetzesbegründung geht hervor, dass die Praxisanleitung durch Beschäftigte in den Einrichtungen, die die Funktion der Praxisanleitung übernehmen, erfolgen soll. Es ist allerdings nicht näher definiert, ob dies durch persönlich und fachlich geeignete Pflegefachpersonen oder durch eine Pflegefachperson, die über eine berufspädagogische Zusatzqualifikation (Praxisanleiter) nach § 4 Abs. 3 PflAPrV verfügt, erfüllt werden soll. Bei Letzterem geben wir zu bedenken, dass eine Person mit dieser berufspädagogischen Zusatzqualifikation immer „über“ einer Pflegefachperson steht. In diesem Falle dürfte die Verantwortung der Ausbildung nicht in den Händen einer Pflegefachperson liegen, sondern müsste in die Rolle der Praxisanleiter gelegt werden. In den landesrechtlichen generalistischen Helferausbildungen ist der Anteil der Praxisanleitung explizit den Pflegefachkräften übertragen worden, um die wenigen Praxisanleiter zu entlasten und so dafür zu sorgen,

dass die Ausbildung nicht Gefahr läuft, aufgrund des Ausfalls oder des Mangels von Praxisanleiter abgebrochen werden müssen. Vor diesem Hintergrund sollte eine Konkretisierung vorgenommen werden und die Praxisanleitung durch Pflegefachpersonen übernommen werden dürfen.

Nach Abs. 3 S. 5 kann ein geringer Anteil eines jeden Einsatzes der praktischen Ausbildung durch praktische Lerneinheiten an der Pflegeschule ersetzt werden, wenn die zuständige Behörde dies genehmigt. Es sollte klargestellt werden, ob die Antragstellung durch die Schule, den Ausbildungsbetrieb oder den Auszubildenden erfolgen muss.

- Zu § 6 PflFAssG-E, Durchführung der praktischen Ausbildung

Die vorgesehene Verteilung der praktischen Pflichteinsätze nach den Anforderungen der generalistischen Ausbildung wird als problematisch angesehen. Insbesondere in ländlichen Räumen kostet es bereits heute größte Anstrengungen, die Pflichteinsätze in ambulanten Diensten sowie in Krankenhäusern sicherzustellen. Zusätzliche Einsätze für Pflegefachassistenz-Auszubildende mit den erforderlichen Praxisanleitungen wären vermutlich kaum umsetzbar. Daher wäre es hilfreich, wenn die Pflichteinsätze in der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtungen auch in stationären Rehabilitationseinrichtungen erfolgen könnten. Damit würden die Pflichteinsätze in der allgemeinen Akutpflege nicht zu einem Nadelöhr für die Ausbildung werden.

- Zu § 8 PflFAssG-E, Mindestanforderungen an Pflegeschulen

Die Qualifikationsanforderungen an die Lehrkräfte erscheinen insgesamt recht hoch. Es sollte sichergestellt werden, dass auch langjährig in verantwortlicher Position tätige Personen bei einem Mangel an akademisch ausgebildeten Pädagogen eingesetzt werden können. Die in Abs. 3 vorgesehene Übergangsregelung bis 31.12.2035 aufgrund landesrechtlicher Regelungen erscheint dabei nicht ausreichend. Eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf Bachelor-Niveau sollte auch für den theoretischen Unterricht genügen.

- Zu § 10 PflFAssG-E, Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung

Wir begrüßen den in Abs. 1 als Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung vorgesehenen Hauptschulabschluss als zielgruppengerecht.

Auch die in Abs. 2 vorgesehene Möglichkeit einer positiven und sachlich begründeten Prognose der Pflegeschule, die einen Zugang zur Ausbildung auch ohne Hauptschulabschluss ermöglicht, ist richtig. Allerdings fragt sich, anhand welcher Kriterien eine solche Prognose praktisch erstellt werden kann bzw. soll. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer etwaigen Justiziabilität wäre es wünschenswert, wenn auf diese Problematik in den Beschlussempfehlungen des Ausschusses aufmerksam gemacht wird.

Der Verweis auf § 2 Nr.4 des Entwurfs in Abs. 3 würde bedeuten, dass bereits zum Ausbildungsbeginn ein Sprachniveau von B2 vorliegen müsste. Dies ist für viele Auszubildende, die direkt aus dem Ausland rekrutiert werden, nur schwer leistbar und stellt alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen. Eine steigende Abbruchquote bei diesem Personenkreis muss vermieden werden. In der Gesetzesbegründung wird zwar ausgeführt, dass das Sprachniveau für die Ausbildung auf einem niedrigeren Niveau anzusetzen sei als die für die Ausübung des Berufs nach § 2 Nr. 4 geforderten Kenntnisse. Dies entspricht aber nicht dem vorgesehenen Gesetzestext, der ohne eine solche Öffnung auf § 2 Nr. 4 des Entwurfs verweist. Die Formulierung „entsprechende Anwendung“ erscheint hierfür nicht ausreichend.

- Zu § 47 PflFAssG-E, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Finanzierung, Verordnungs-ermächtigungen

Zu kritisieren ist des Weiteren, dass wichtige Parameter für eine fundierte Entscheidung im Regierungsentwurf fehlen, die erst in der ausstehenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung definiert werden sollen. Im Entwurf fehlen demzufolge Angaben zu den angesetzten Stunden für den theoretisch-praktischen Unterricht und die praktische Ausbildung sowie den Mindeststunden für die verschiedenen Pflichteinsätze in der allgemeinen Akutpflege, in der allgemeinen Langzeitpflege in stationären Einrichtungen und in der allgemeinen ambulanten Akut- und Langzeitpflege.

Bei der zukünftigen Festlegung der theoretisch-praktischen Unterrichtsstunden und Pflichteinsatzstunden, die nicht beim praktischen Träger der Ausbildung stattfinden, sind dringend die ausbildungslimitierenden Engstellen zu berücksichtigen, wie z.B. fehlende Lehrkräfte, fehlende Praxisanleiter und nicht ausreichende Einsatzstellen für die praktische Ausbildung, insbesondere in der Akutpflege.

Zu Art. 6 des Entwurfs, Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Die in § 54a SGB III-E vorgesehene Aufnahme der Pflegefachassistentenausbildung ist zu befürworten, da sie den Zugang zur Einstiegsqualifizierung ermöglicht. Gleiches gilt für die Ergänzung in § 57 SGB III-E, so dass die Ausbildung auch durch eine Berufsausbildungsbeihilfe gefördert werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung



Feldmeier

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Ausschussdrucksache 21(13)9d
vom 29. September 2025

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefach-
assistenzausbildung“

BT-Drucksache 21/1493

Melanie Wehrheim

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di



Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Stellungnahme

der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di

zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung (BT-Drs. 21/1493)

anlässlich der öffentlichen Anhörung des
Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
am 6. Oktober 2025

Berlin, 29. September 2025

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bundesverwaltung – Fachbereich Gesundheit,
Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft
Bereich Berufspolitik/Jugend
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Gesamteinschätzung

Patient*innen und pflegebedürftige Menschen erwarten zu Recht eine qualitativ hochwertige Versorgung, die sich an ihren individuellen Bedürfnissen ausrichtet. Dafür braucht es ausreichend und vor allem auch gut qualifiziertes Personal, das in allen Versorgungsbereichen dringend benötigt wird. Um dem Fachkräftemangel wirksam zu begegnen, müssen in erster Linie die zentralen Ursachen gezielt gelöst werden. Immer mehr qualifizierte Pflegekräfte verlassen ihren Beruf oder reduzieren ihre Arbeitszeit, weil sie die Arbeit unter den derzeitigen Bedingungen nicht mehr aushalten. Es braucht weitere wirkungsvolle Maßnahmen, die den Teufelskreis aus schlechten Arbeitsbedingungen, Personalnot und zu wenig Zeit für eine gute Pflege durchbrechen. Die bundesweite Studie »Ich pflege wieder, wenn...« hat das enorme Potenzial an Pflegefachpersonen aufgezeigt, die unter bestimmten Bedingungen bereit sind, in ihren Beruf zurückzukehren bzw. ihre Arbeitszeit aufzustocken.

Mit dem Pflegefachassistenzgesetz soll ein eigenständiges und einheitliches Berufsprofil für die Pflegeassistenz als Heilberuf geschaffen werden. Dies ist sinnvoll, um den derzeitigen „Flickenteppich“ an landesrechtlichen Regelungen abzulösen. Die großen und weiter steigenden Anforderungen in der pflegerischen Versorgung erfordern jedoch eine hohe Fachlichkeit. Grundsätzlich spricht sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) daher gegen Ausbildungsberufe unterhalb des Niveaus einer dreijährigen Fachausbildung aus. Wenn eine bundeseinheitliche Pflegefachassistentenausbildung etabliert werden soll, muss diese gut gestaltet sein.

Der Gesetzentwurf ist hinsichtlich der Ausbildungsdauer nachzubessern. Wer dabei unterstützt, Menschen zu pflegen, übernimmt eine verantwortungsvolle und fordernde Aufgabe. Eine Ausbildung von zwei Jahren ist das Mindeste. Eine 18-monatige Ausbildung, wie bisher vorgesehen, reicht dafür nicht. Es braucht eine fachlich fundierte Ausbildung mit anschließenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Kürzere als zweijährige Ausbildungen gibt es im Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und unter den Gesundheitsfachberufen (Heilberufen) bisher nicht.

Für eine zumindest 24-monatige Ausbildung spricht auch, dass die Pflegefachassistentenausbildung generalistisch ausgerichtet sein und zur Pflege und Betreuung aller Altersstufen qualifizieren soll. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf die ambulante und stationäre Langzeitpflege gelegt werden. Fach- und Hilfstätigkeiten sind sinnvoll voneinander abzugrenzen. Für eine patient*innen- bzw. bewohner*innenorientierte Pflege ist eine Bezugspflege zu ermöglichen. Dies setzt eine enge, teamorientierte Zusammenarbeit von Pflegefach- und Pflegeassistenzpersonen voraus. Keinesfalls darf es in der weiteren Umsetzung zu einer Abwertung pflegerischer Tätigkeit

kommen. Betroffen davon wären vor allem Frauen, da ihr Anteil unter den Pflegekräften weiterhin überwiegt.

Die Weiterqualifikation zur Pflegefachperson muss systematisch gefördert werden. Wichtig ist, dass hierfür die Schnittstelle zur Arbeitsmarkt- und Berufsförderung im Prozess mitgedacht wird und entsprechende gesetzliche Anpassungen vorgenommen werden. Eine hohe Durchlässigkeit zwischen den Pflegeberufen ist unbedingt zu gewährleisten. Eine abgeschlossene Pflegefachassistenz Ausbildung ist im vollen Umfang ihrer Dauer auf die Fachausbildung anzurechnen. Zudem sind die Ausbildungen so zu gestalten, dass der Einstieg in die Fachausbildung nahtlos möglich ist. Um für die Absolvent*innen weitere berufliche Perspektiven zu eröffnen, muss in Zusammenhang mit der Pflegeassistenz Ausbildung die Möglichkeit bestehen, einen allgemeinbildenden (mittleren) Schulabschluss zu erwerben, sofern dieser noch nicht gegeben ist.

Für eine qualitativ hochwertige Ausbildung sind die Standards im Pflegefachassistenzgesetz weiter zu erhöhen. Schutzrechte für die Auszubildenden ließen sich am besten durch eine Regelung nach BBiG gewährleisten, da hiermit auch Mindeststandards an die Qualität der betrieblichen Ausbildung verbunden sind. Zumindest muss das Ausbildungsverhältnis konsequent arbeitsrechtlich im Betrieb verankert sein, damit Auszubildende über ihre Interessenvertretungen Einfluss auf ihre Ausbildungsbedingungen nehmen können. Ausdrücklich begrüßt ver.di, dass der Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung und die Schulgeldfreiheit verankert werden sollen.

Auszubildende sind zu unterstützen und individuell zu fördern. Notwendig dafür ist insbesondere ein Mindestumfang geplanter und strukturierter Praxisanleitung von 30 Prozent, zudem ist die situative Anleitung in alltäglichen Lernsituationen durch ständige Anwesenheit qualifizierten Fachpersonals sicherzustellen. Wird der Mindestumfang nicht eingehalten, braucht es Konsequenzen – die Ausbildungsbetriebe müssen in diesem Fall sanktioniert werden. In diesem Sinne ist auch das Pflegeberufegesetz nachzubessern. Damit wäre zugleich ein wichtiger Beitrag geleistet, um die Attraktivität der Pflegeausbildung zu verbessern.

Zur Finanzierung der Ausbildung ist es grundsätzlich folgerichtig, dass der praktische Teil der Pflegefachassistenz Ausbildung in das bestehende Finanzierungssystem der beruflichen Pflegeausbildung integriert wird. Der schulische Anteil der Ausbildungskosten sollte jedoch durch die Länder getragen werden. Die Kostenverteilung zur Finanzierung der praktischen Ausbildungskosten ist zu überprüfen, da der weitaus größte Teil der Absolvent*innen einer Pflegefachassistenz Ausbildung in die stationäre und ambulante Langzeitpflege einmünden dürfte. Dringend erforder-

lich ist eine Lösung, damit pflegebedürftige Menschen in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen künftig nicht mehr über Eigenanteile Ausbildungskosten tragen müssen. Positiv ist, dass über das Umlageverfahren Nachteile im Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen vermieden werden sollen und die Kosten der Ausbildungsvergütung ohne Anrechnung eines Wertschöpfungsanteils finanziert werden. Dies muss entsprechend auch für die berufliche Ausbildung nach Pflegeberufegesetz geregelt werden. Die Ausbildung muss im Vordergrund stehen.

Das Ziel einer sachgerechten Zuordnung der Berufsabschlüsse in der Pflege zum Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) muss parallel zur Regelung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung weiterverfolgt werden. Um die internationale Vergleichbarkeit der Abschlüsse sicherzustellen, müssen die Berufsabschlüsse nach Pflegeberufegesetz dem DQR-Niveau 5, die Fachweiterbildungen dem Niveau 6 zugeordnet werden. Eine bundesweit einheitliche Pflegeassistentenausbildung, die zur eigenständigen beruflichen Handlungsfähigkeit befähigt, muss dem Niveau 4 entsprechen.

Zu den Regelungen im Einzelnen

Zu Artikel 1 – Gesetz über den Pflegefachassistentenberuf (Pflegefachassistentengesetz – PflFAssG)

Zu § 1 – Führen der Berufsbezeichnung

ver.di spricht sich – sofern eine lediglich 18-monatige Ausbildungsdauer beibehalten wird – für die Berufsbezeichnung „Pflegeassistentin“, „Pflegeassistent“ oder „Pflegeassistentenperson“ aus. Mit der Bezeichnung Pflegefachassistentenperson entsteht der Eindruck, dass die neue Pflegeassistentenausbildung sich nahe an der Fachausbildung bewegt, was angesichts der Kürze der Ausbildungsdauer und der vorgesehenen Kompetenzen jedoch nicht gegeben ist.

Zu § 4 – Ausbildungsziel

Pflegerische Tätigkeit ist in ihrem Kern Beziehungsarbeit und setzt einen direkten Umgang mit den zu Pflegenden und die dafür notwendige Fachlichkeit voraus. Eine qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung ist am individuellen Bedarf der zu pflegenden Person orientiert und bezieht sich auf den gesamten Pflegeprozess. Es gehört untrennbar zusammen, Bedarfe und Ressourcen zu erkennen sowie die Pflege zu planen und durchzuführen. Eine bedarfsgerechte patient*innen- bzw. bewohner*innenorientierte Pflege, die diesen Ansprüchen Rechnung trägt, funktioniert nur ganzheitlich. In der Praxis ist daher eine Bezugspflege sicherzustellen, in der Pflegefachpersonen während ihrer Schicht die gesamte Pflegeverantwortung für eine bestimmte Gruppe von Patient*innen bzw. Bewohner*innen haben. Von diesen Anforderungen sind die Qualifikationen für eine Pflegefachassistentenausbildung abzuleiten. Eine Funktionspflege, bei der die Pflegearbeit in zahlreiche einzelne Verrichtungen aufgeteilt wird, die dann jeweils von unterschiedlich qualifiziertem Personal übernommen werden, gilt es unbedingt zu vermeiden. Der Kernbereich pflegerischer Tätigkeit ist auch künftig in der dreijährigen Ausbildung nach Pflegeberufegesetz zu vermitteln, da es ansonsten zu einer Abwertung der gesamten Pflegearbeit kommt. Es gilt, ein sinnvolles Miteinander von unterschiedlich qualifizierten Pflege(fach)personen zu gestalten.

Zu Absatz 1

ver.di spricht sich für eine generalistisch ausgerichtete Pflegeassistentenausbildung aus, wobei ein Schwerpunkt der Ausbildung auf die ambulante und stationäre Langzeitpflege gelegt werden sollte. Eine generalistische Ausbildung bietet den Absolvent*innen mehr berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und – bei entsprechender Ausgestaltung der Ausbildung – einen nahtlosen Einstieg in die Fachausbildung nach Pflegeberufegesetz.

Die derzeitige Situation in den Versorgungsbereichen unterscheidet sich deutlich. Im Krankenhaus hat sich der hohe Fachkraftanteil bewährt, patient*innennahe Tätigkeiten sollten daher auch künftig von Pflegefachpersonen ausgeführt werden. In der stationären Langzeitpflege und ambulanten Pflege spielen Pflegehelfer*innen und Pflegeassistent*innen schon jetzt eine bedeutende Rolle. Ziel muss aufgrund der gestiegenen Anforderungen sein, den Anteil an Pflegefachpersonen zu erhöhen. Als Kriterium zur Abgrenzung des Einsatzes von Pflegefachpersonen und Pflegeassistent*innen sollte der Grad der Selbständigkeit der pflegebedürftigen Menschen sein: Je weniger diese in der Lage sind, Aktivitäten des täglichen Lebens selbständig auszuführen, desto stärker ist der Einsatz von Pflegefachpersonen gefragt. Ziel muss eine aktivierende Pflege sein.

Die in § 4 Absatz 1 angelegten Unterscheidungskriterien „komplexe“ und „nicht komplexe Pflegesituationen“ sind dagegen nicht geeignet, um in der Praxis Tätigkeitsfelder in der Pflege hinreichend abgrenzen zu können. Um Pflegesituationen in diese Kategorien einteilen zu können, braucht es weitere Forschung und eine stärkere Operationalisierung der jeweiligen Komplexitätsgrade. Zu bedenken ist allerdings, dass in aller Regel Pflegesituationen in der Akutversorgung und in der Langzeitpflege fast immer komplex sind, indem sie beispielsweise mit Einschränkungen in der Selbstversorgung, Multimorbidität, sozialer Isolierung und psychosozialen Belastungen verbunden sind. Zudem können sich in der Praxis Pflegesituationen schnell ändern. Pflegefachassistent*innen müssen daher auch in komplexen Pflegesituationen selbständig und sicher handeln können. Das gilt insbesondere in der ambulanten Pflege, wo Pflegepersonen weitgehend auf sich gestellt beruflich handlungsfähig sein müssen.

Positiv ist, dass in Absatz 1 die digitalen und diversitätssensiblen Kompetenzen ausdrücklich aufgenommen sind und auf die Bedeutung lebenslangen Lernens hingewiesen wird.

Zu Absatz 3

Grundsätzlich sollten Aufgaben, die bisher von Pflegefachpersonen wahrgenommen wurden, auch künftig von Pflegefachpersonen ausgeübt werden. Es gibt aus fachlicher Sicht keinen Grund, hieran etwas zu ändern. Dies gilt insbesondere für Aufgaben aus dem Bereich der medizinischen Behandlungspflege. Zudem dürfte sich die Arbeit der Pflegefachpersonen weiter in administrativen Bereichen verdichten und eine Bezugspflege stärker in Frage gestellt werden, wenn künftig insbesondere patient*innennahe Tätigkeiten wie die Unterstützung bei der Körperpflege oder ihre Übernahme, die Durchführung von Prophylaxen usw. verstärkt von Pflegeassistenten übernommen werden.

Zu Nummer 1

Wie oben ausgeführt, sieht ver.di eine Unterscheidung zwischen Aufgaben, die Pflegeassistenten in nicht komplexen Pflegesituationen selbständig durchführen, sowie Aufgaben, an denen sie in komplexen Pflegesituationen mitwirken, als nicht geeignet an. Alternativ bietet es sich an, den Grad der Selbständigkeit der zu pflegenden Personen als Unterscheidungskriterium heranzuziehen.

Zu Buchstabe a

Die Erhebung des Pflegebedarfs ist in der Ausbildung in Gänze zu erlernen – unabhängig von der späteren Ausübung. Ein pflegerischer Heilberuf muss in die Lage versetzt werden, den Pflegebedarf selbständig zu erheben und auf Veränderungen zu reagieren. Da das Ausbildungsziel jedoch die vorbehaltenen Aufgaben nach Pflegeberufegesetz berührt, ist in der späteren beruflichen Praxis die notwendige enge, teamorientierte Zusammenarbeit zwischen Pflegefachperson und Pflegefachassistenten zu stärken. Um dies bereits im Ausbildungsziel zum Ausdruck zu bringen, sollte die Formulierung „in enger Zusammenarbeit mit Pflegefachpersonen“ ergänzt werden.

Zu Buchstabe b

In der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ist zu konkretisieren, was unter „körpernahen Pflegemaßnahmen“ verstanden wird. Da die Durchführung der Pflege im Rahmen des Pflegeprozesses, insbesondere der körpernahen Pflegemaßnahmen, zum Kompetenzprofil der Ausbildung in der Pflegefachassistenten gehören soll, gehört dazu auch die diesbezügliche Planung der Pflege.

Zu Buchstabe d

Die Bezeichnung „Dokumentation“ ist vollkommen ausreichend, das Wort „aussagekräftige“ daher zu streichen.

Zu Buchstabe e

Über die „qualitätssichernden“ Durchführungsstandards hinaus sollten auch die „fachlichen“ Standards ergänzt werden.

Zu Buchstabe j

Bei den palliativen Lebenssituationen handelt es sich um ein zunehmend wichtiges Handlungsfeld. Jedoch sollte sich das Ausbildungsziel generell auf die Begleitung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen beziehen und neben der Palliativversorgung unter anderem auch demenzielle Erkrankungen umfassen. Die Formulierung „Begleitung“ ist ungenau, dieser wird eher in der Laienpflege verwendet. Der Begriff ist daher zu definieren; eine Konkretisierung in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ist unbedingt erforderlich.

Zu Buchstabe k

Die Formulierung „Durchführung von Maßnahmen in Krisen und Katastrophensituationen“ ist weitreichend und sollte wie folgt konkretisiert werden: „Durchführung von Maßnahmen im Rahmen ihrer erlernten Kompetenzen in Krisen und Katastrophensituationen“. Bei „Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des Arztes ...“ handelt es sich nicht um ein Ausbildungsziel, sondern um eine Begrenzung der Berufsausübung, die nicht in einem Berufszulassungsgesetz zu regeln ist. Erforderliche lebensrettende Maßnahmen müssen unabhängig vom Eintreffen ärztlichen Personals gelernt und beherrscht werden.

Zu Nummer 2

Grundsätzlich sollten ärztliche Tätigkeiten nicht zu dem Aufgabenbereich der Pflegefachassistenz gehören, auch nicht im Delegationsverfahren. Letztlich bleibt die Ärztin bzw. der Arzt verantwortlich und muss sich auch im Falle der – rechtlich problematischen - Weiterdelegation durch eine Pflegefachperson von der Qualifikation der*des Delegationsempfänger*in überzeugen. Dies wird in der Praxis nicht umsetzbar sein. Die Formulierung „geeignete Maßnahmen“ ist zudem zu unspezifisch und weitreichend. Soweit es sich um ärztlich angeordnete pflegerische Maßnahmen handeln soll, sollte dies auch so benannt werden.

Zu Nummer 3

Die Kommunikation und Zusammenarbeit im Pfllegeteam und mit anderen Berufsgruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der späteren beruflichen Tätigkeit und auch im Sinne des interdisziplinär angelegten patient*innenzentrierten Ansatzes wichtig. Das Wort „effektiv“ vor „im Pfllegeteam“ sollte jedoch gestrichen werden.

Zu Absatz 4

Das Ausbildungsziel, ein „professionelles Pfllegeverständnis“ zu entwickeln, steht in Widerspruch zu den vorgenannten Ausbildungszielen., die eher auf Mitwirkung und Unterstützung anderer bei der Pfllegearbeit orientieren.

Zu § 5 – Dauer und Struktur der Ausbildung

Zu Absatz 1

Die gestiegenen Anforderungen an die pflegerische Versorgung erfordern eine hohe Fachlichkeit. Grundsätzlich spricht sich ver.di deshalb für den Standard einer dreijährigen Fachausbildung im Gesundheitswesen aus. Es gibt unter Versorgungsgesichtspunkten keine überzeugenden Argumente, die dafür sprechen, das Niveau einer dreijährigen Ausbildung zu unterschreiten. Angesichts der verantwortungsvollen Aufgabe ist eine fachlich fundierte Ausbildung, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet, notwendig. Eine Ausbildung von zwei Jahren ist das Mindeste. 18 Monate reichen für einen Heilberuf nicht. Der Anspruch, generalistisch für alle Altersgruppen und in allen Pfllegesettings eigenständig in der Pfllegfachassistenz handeln zu können, ist in 18 Monaten nicht erfüllbar. Bereits in der dreijährigen Ausbildung sind diesbezügliche Defizite erkennbar.

Die Weiterqualifikation zur Pfllegfachperson muss systematisch gefördert werden. Wichtig dafür ist, dass die Schnittstelle zur Arbeitsmarkt- und Berufsförderung bei einer 24-monatigen Pfllegfachassistentenausbildung mitgedacht wird. Nach der Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (2025) besteht im Bereich der Pfllegfachkräfte ein deutlicher Engpass, der aufgrund des niedrigen Substituierbarkeitspotentials der Pfllegeberufe fortbestehen dürfte (vgl. Arbeitsmarktsituation im Pfllegebereich, S. 21 ff.). Nötig sind daher durchlässige Qualifizierungswege, mit denen sich Pfllegeassistent*innen nahtlos zur Pfllegfachperson ausbilden können. Hierauf sind die

Förderbedingungen nach SGB III auszurichten. Es braucht eine begrenzte Öffnung der Weiterbildungsförderung gem. § 81 Abs. 2 SGB III, die grundsätzlich für den Erwerb des darauf aufbauenden Fachkraftabschlusses zugänglich ist. Unzureichend bliebe, wenn die Förderung gem. § 81 Abs. 2 SGB III lediglich für die Förderung einer 24-monatigen Pflegeassistentenausbildung offenstehen würde. Eine solche gesetzliche Anpassung würde dem großen Fachkräftebedarf in den Pflegeberufen Rechnung tragen und zugleich die bestehende Förderpraxis absichern, die einen Schwerpunkt bei der Förderung der vollständigen Fachkraftausbildung legt. Um die Förderung von einer Assistentenausbildung bis hin zur Fachkraftausbildung nahtlos zu ermöglichen, darf auch die zweijährige Ausschlussfrist gem. § 82 Abs. 1 Nr. 3 SGB III nicht greifen, da diese ansonsten eine unnötige Hürde bildet.

Positiv ist, dass die Ausbildung auch in Teilzeit absolviert werden kann und der Anteil der praktischen Ausbildung überwiegt. Zu bedenken gilt, dass die Begrenzung der Teilzeitform auf 36 Monate im Einzelfall zu eng sein kann. Bereits heute arbeitet ein hoher Anteil des Pflegeassistentenpersonals besonders in der ambulanten Pflege in Teilzeitarbeitsverhältnissen. Deshalb sollte zumindest die Ausbildungsdauer auf Verlangen der Auszubildenden auch über die Höchstdauer der Ausbildungszeit bis zur nächstmöglichen Abschlussprüfung verlängert werden können (vgl. § 7a Abs. 3 BBiG).

Zu Absatz 3

ver.di begrüßt, dass die praktische Ausbildung in den Einrichtungen auf der Grundlage eines vom Träger der praktischen Ausbildung zu erstellenden Ausbildungsplanes durchgeführt werden soll. Ein Ausbildungsplan ist für eine zeitlich und sachlich gegliederte Ausbildung unerlässlich; dieser ist daher für die gesamte Dauer der Ausbildung festzulegen und auszuhändigen. Darüber hinaus sind die Anforderungen an den Ausbildungsplan zu benennen. Mindestens alle Einsatzgebiete und -zeiten müssen in der vorgesehenen Reihenfolge und Dauer aus dem Ausbildungsplan hervorgehen. Ein Musterausbildungsplan sollte dem Gesetz als Anlage angefügt werden.

Ebenso begrüßt ver.di, dass ein bundeseinheitlicher Mindestumfang der Praxisanleitung verankert wird. Die Vorgabe von mindestens 10 Prozent greift deutlich zu kurz. Aufgrund der großen Bedeutung von Praxisanleitung für eine gute Ausbildung, wie auch die Ergebnisse des ver.di-Ausbildungsreports Pflegeberufe 2021 zeigen, müssen mindestens 30 Prozent der tatsächlichen Ausbildungszeit sichergestellt werden. Zudem ist im Gesetz klarzustellen, dass der Mindestum-

fang an Praxisanleitung geplant und strukturiert sowie als Einzelanleitung erfolgen muss. Eventuelle Gruppenanleitungen, die in bestimmten Lernsituationen auch sinnvoll sein können, ergänzen den Mindestumfang. Zusätzlich ist die situative Anleitung im alltäglichen Ablauf durch ständige Anwesenheit qualifizierten Fachpersonals zu gewährleisten. Praxisanleiter*innen müssen für die Erfüllung ihrer Aufgaben von ihrer Arbeit freigestellt werden bzw. ist ihnen die für die Anleitung erforderliche Zeit zur Verfügung zu stellen. Nähere Vorgaben zur Praxisanleitung sowie zur Qualifikation von Praxisanleiter*innen sind zu regeln.

Für die Verzahnung von Theorie und Praxis spielt die Praxisbegleitung eine wichtige Rolle, ihre Ausgestaltung und ihr Umfang sollten in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung konkretisiert werden. Die Praxisbegleitung dient dazu, Auszubildende fachlich und pädagogisch zu betreuen und zu fördern sowie die theoretische und praktische Ausbildung miteinander zu verzahnen. Es gehört explizit nicht zu den Aufgaben der Praxisbegleitung, die Auszubildenden in der Praxis zu beurteilen.

Darüber hinaus lehnt ver.di ab, dass ein geringer Anteil der praktischen Ausbildung durch praktische Lerneinheiten an der Pflegeschule oder beim Träger der praktischen Ausbildung ersetzt werden kann. Das gilt insbesondere bei einer Ausbildung unter drei Jahren. Daher ist Absatz 3 Satz 5 ersatzlos zu streichen.

Zu § 6 – Durchführung der praktischen Ausbildung

Zu Absatz 2

ver.di befürwortet die Vorgabe, dass der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung stattfindet, um hierüber die betriebliche Anbindung sicherzustellen. Die Ausbildung ist allerdings – wie oben beschrieben – mit 18 Monaten zu kurz, um Berufsfähigkeit zu gewährleisten.

Zu Absatz 3

Für einheitliche Standards in der Pflegeausbildung braucht es konkretere, bundeseinheitliche Vorgaben zur Geeignetheit von Einrichtungen. Insbesondere muss die praktische Ausbildung unter ständiger Anwesenheit einer angemessenen Zahl qualifizierten Fachpersonals erfolgen. Als „angemessen“ gilt mindestens, dass die Zahl der Auszubildenden nie höher sein darf als die Zahl der anwesenden Pflegefachpersonen. Für die Anerkennung der Einrichtung für die praktische

Ausbildung ist ein Verhältnis von zwei Vollzeitäquivalenten einer Pflegefachperson pro eine*n Auszubildende*n vorzugeben.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist zu überprüfen; Verstöße der Träger sind zu sanktionieren. Die Regelung, dass die zuständige Landesbehörde im Fall von Rechtsverstößen einer Einrichtung die Durchführung der Ausbildung untersagen kann, ist zielführend. Zugleich sollten Sanktionsmöglichkeiten über die Untersagung der Ausbildung hinaus erweitert werden.

Zu Absatz 4

Eine Ombudsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen der*dem Auszubildenden und dem Träger der praktischen Ausbildung sollte entsprechend der paritätisch besetzten Schlichtungsausschüsse ausgestaltet werden, die auf schriftlichen Antrag der Auszubildenden tätig werden und einem arbeitsgerichtlichen Verfahren vorgelagert sind. Die betriebliche Mitbestimmung bleibt unberührt. Aufgrund der besonderen Stellung der Pflegeschulen sollten auch Streitigkeiten zwischen Auszubildenden und Schulen einbezogen werden.

Zu § 7 – Träger der praktischen Ausbildung

ver.di hält es für unverzichtbar, dass die Betriebe nach dem Vorbild des dualen Systems in ihrer Ausbildungsverantwortung gestärkt werden. Grundsätzlich spricht sich ver.di dafür aus, dass ausschließlich die Einrichtungen gemäß § 6 Absatz 1 als Träger der Ausbildung verankert werden, die die Ausbildung verantwortlich gestalten.

Zu Absatz 1

ver.di begrüßt, dass der Träger der praktischen Ausbildung die Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung einschließlich ihrer Organisation trägt und mit der*dem Auszubildenden einen Ausbildungsvertrag schließt.

Zu Absatz 4

ver.di lehnt entschieden ab, dass die in Absatz 3 genannten Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung auf eine Pflegeschule übertragen werden können. Es muss sichergestellt sein,

dass der Träger der praktischen Ausbildung als Vertragspartner der Auszubildenden den beherrschenden Einfluss auf die Gestaltung der Ausbildung hat, also die Ausbildung verantwortlich gestaltet. Es ist umfassend zu sichern, dass betriebliche Interessenvertretungen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Ausbildungsqualität beitragen können.

Wichtig ist, dass gemäß Absatz 4 Satz 2 die Eigenschaft als Vertragspartner des Ausbildungsvertrages ausdrücklich nicht auf die Schule übertragen, sondern diese allenfalls bevollmächtigt werden kann.

Zu Absatz 5

ver.di begrüßt die Regelung in Absatz 5 ausdrücklich.

Zu § 8 – Mindestanforderungen an Pflegeschulen

Zu Absatz 1

ver.di begrüßt, dass die hauptberufliche Leitung der Schule durch eine pädagogisch qualifizierte Person mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Niveau erfolgen soll.

Die für berufsbildende Schulen geltenden Standards sollten auch für die Pflegeschulen gelten. Diese orientieren sich entsprechend der Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe II (berufliche Fächer) oder für die beruflichen Schulen der Kultusministerkonferenz (KMK). Die entsprechende berufliche Fachrichtung ist an den für die Lehrerbildung zuständigen wissenschaftlichen Hochschulen zu entwickeln und zu etablieren. Eine universitäre wissenschaftliche Ausbildung der Lehrkräfte auf Masterniveau leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und zum Ausbau der jeweiligen berufsbezogenen Fachwissenschaften. Eine Differenzierung der benötigten Anforderungen für Lehrkräfte nach der Form des Unterrichts lehnt ver.di ab. Für die vorhandenen Lehrkräfte muss umfassend Bestandsschutz zugesichert werden.

Zu Absatz 2

Damit die Qualität der theoretischen Ausbildung sichergestellt ist, fordert ver.di ein verbindliches Verhältnis von hauptberuflichen Lehrkräften zu Auszubildenden von 1:15. Des Weiteren ist

Satz 2 ersatzlos zu streichen. Eine geringere Anzahl von hauptberuflichen Lehrkräften sollte auch nicht vorübergehend zulässig sein. Sofern die Regelung beibehalten wird, ist die zeitliche Dauer zu konkretisieren und klarzustellen, dass sich „vorübergehend“ auf einen zeitlich sehr eng begrenzten Zeitraum bezieht.

Zu § 9 – Gesamtverantwortung der Pflegeschule

ver.di spricht sich grundsätzlich für eine Stärkung der betrieblichen Verantwortung aus, die beim Träger der praktischen Ausbildung liegt. Es ist sachgerecht, dass die Verantwortung der Pflegeschule auf die Koordination des Unterrichts mit der praktischen Ausbildung begrenzt ist. Der auch bereits in anderen Berufsgesetzen verwendete Begriff „Gesamtverantwortung“ ist insoweit missverständlich. Es geht hier lediglich um die Verantwortung für die Koordination.

Der Ausbildungsplan für die praktische Ausbildung und der Lehrplan der Schule sind aufeinander abzustimmen. Hierzu bedarf es eines wechselseitigen Abstimmungsprozesses. Eine Überprüfung durch die Pflegeschule ist nicht folgerichtig. Pflegeschule und Träger der praktischen Ausbildung sollten vielmehr im gegenseitigen Einvernehmen das schulinterne Curriculum und den Ausbildungsplan aufeinander abstimmen.

Zu § 10 – Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung

Zu Absatz 2

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass auch Personen ohne Schulabschluss der Zugang zur Ausbildung ermöglicht werden soll. Zugleich sind die Auszubildenden individuell zu unterstützen, damit sie die Ausbildung erfolgreich abschließen können. Der hohe Anteil an Schulabgänger*innen ohne Schulabschluss lässt es geboten erscheinen, keine zusätzlichen Hürden beim Zugang in die Ausbildung zu schaffen. Dabei liegt es nicht im Aufgabenbereich und der Kompetenz der Schule, eine positive und sachlich begründete Prognose zu erstellen, ob die Abschlussprüfung bestanden werden kann oder nicht. Diese Aufgabe sollte dem ausbildenden Betrieb übertragen werden. Gegebenenfalls kann eine solche Prognose auf Grundlage von Praktikumszeugnissen erstellt werden. Die Ausbildung ist von Betrieb und Schule so zu gestalten, dass sie erfolgreich abgelegt werden kann.

ver.di sieht es im Sinne der Durchlässigkeit zur Ausbildung nach Pflegeberufegesetz und für erweiterte berufliche Entwicklungsmöglichkeiten als unverzichtbar an, dass im Zusammenhang mit

der bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung der Erwerb eines allgemeinbildenden Schulabschlusses (mittlere Reife) ermöglicht wird. Deshalb sollte im Pflegefachassistentengesetz zumindest darauf verwiesen werden, dass die Länder den Erwerb eines allgemeinbildenden Schulabschlusses parallel regeln können. Der bisherige Hinweis in der Begründung zum Gesetzentwurf, dass die Länder für Auszubildende nach dem Pflegefachassistentengesetz ohne Schulabschluss parallel die Möglichkeit zum Erwerb eines Hauptschulabschlusses vorsehen können, um eine Durchlässigkeit zur Fachkraftausbildung zu ermöglichen, greift zu kurz.

Zu § 11 – Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen und Berufserfahrung

Zu Absatz 1

Die Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen sind durchlässig auszugestalten, um den Auszubildenden die individuelle persönliche und fachliche Weiterentwicklung zu ermöglichen. Im Detail sind die Regelungen jedoch nachzubessern.

Zu Nummer 1

ver.di begrüßt die Vorschrift. Weitergehend ist jedoch ein Rechtsanspruch auf Anrechnung zu verankern. Als erfolgreich absolviert gelten Ausbildungsteile, die mindestens mit „ausreichend“ bewertet wurden.

Zu Nummer 2

Gut ist, dass neben der Anrechnung erfolgreich abgeschlossener Ausbildungen bzw. erfolgreich abgeschlossener Teile einer Ausbildung auch solche Kompetenzen berücksichtigt werden sollen, die non-formal oder informell durch Berufserfahrung oder Ausübung von anrechenbaren Tätigkeiten erlangt worden sind. Ausschlaggebend für die Anrechenbarkeit müssen allerdings die tatsächlich erlangten Kompetenzen während der praktischen Tätigkeit in der Pflege und nicht deren Dauer sein. Der Zeitraum, in dem die anrechenbare Tätigkeit zurückliegt, sollte auf fünf Jahre erweitert werden. Praktische Berufserfahrungen verfallen nicht so schnell wie bspw. kurzzeitig angelerntes Unterrichtswissen.

Zu Nummer 3

Das Nähere zu den Kompetenzfeststellungsverfahren sollte möglichst einheitlich geregelt werden.

Zu Absatz 2

Die geplanten Regelungen sind nachzubessern. In Satz 2 ist die Voraussetzung des Vorliegens einer „sachlich begründeten positiven Prognose der Pflegeschule“ zu streichen. Es liegt nicht im Aufgabenbereich einer Pflegeschule hinsichtlich eines erfolgreichen Abschlusses der Pflegefachassistentenausbildung prognostisch zu befinden. Zugleich fehlt es hier an einheitlichen Kriterien, anhand derer die Prognose erfolgen soll.

Zu Nummer 1

Positiv bewerten wir, dass die zuständige Behörde auf Antrag die Stunden der praktischen Pflegefachassistentenausbildung durch Anrechnung um den vollen Umfang verkürzen kann, wenn eine Ausbildung nach Pflegeberufegesetz nach der Hälfte der Ausbildungsdauer abgebrochen wurde. Die Vorgabe, dass der Abbruch der Ausbildung nicht länger als 36 Monate zurückliegen darf, ist entbehrlich. Maßgeblich ist das Bestehen der Abschlussprüfung zur Pflegefachassistentenz. Sofern an dieser Vorgabe festgehalten wird, sollten statt 36 Monate mindestens 60 Monate (5 Jahre) vorgesehen werden. Eine zu kurze Frist unterstellt unbegründet, dass in der (Teil-)Ausbildung erworbene Kompetenzen schnell wieder verlernt werden.

Grundsätzlich muss im Fokus stehen, dass die Auszubildenden nach Pflegeberufegesetz unterstützt werden, die Fachausbildung erfolgreich abschließen zu können. Es ist unbedingt sicherzustellen, dass die Auszubildenden nicht dazu gedrängt werden, ihre Ausbildung abubrechen.

Zu Nummer 2

Für die Anrechenbarkeit müssen die erlangten Kompetenzen während der praktischen Tätigkeit in der Pflege ausschlaggebend sein – und nicht deren Dauer. Die Gleichstellung von unregelmäßiger praktischer Tätigkeit im Umfang von 36 Monaten und einer geordneten praktischen Ausbildung entwertet die Berufsausbildung und reduziert sie auf praktische Erfahrungen. Wichtig ist, dass der theoretische und praktische Unterricht („Vorbereitungskurs“) im Umfang von 320 Stunden stärker praktisch orientiert wird durch ausgewählte Praxisphasen in der Versorgung unter gezielter Anleitung.

Zu Absatz 3

Die vorgesehene Verkürzungsregelung ist grundsätzlich sinnvoll, darf allerdings nicht dazu führen, dass sich die Zahl vorzeitiger Ausbildungsabbrüche weiter erhöhen wird. Ziel muss bleiben,

dass die Auszubildenden unterstützt werden, die dreijährige berufliche Pflegeausbildung erfolgreich abzuschließen. Soweit sich nach dem Ergebnis der Zwischenprüfung nach Pflegeberufegesetz abzeichnet, dass die Erreichung des Ausbildungsziels gefährdet ist, sind die Auszubildenden durch geeignete Fördermaßnahmen im Rahmen der wöchentlichen Ausbildungszeit zu unterstützen. Dazu sind der Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschule in der Pflicht. Die Maßnahmen dürfen zu keiner zusätzlichen Belastung der Auszubildenden führen. § 7 PflAPrV ist in diesem Sinne nachzuschärfen. Zugleich ist sicherzustellen, dass die Zwischenprüfung nach Pflegeberufegesetz auch künftig ausschließlich eine pädagogische Funktion hat; sie dient der Ermittlung des Ausbildungsstandes und ist bei Bedarf mit Fördermaßnahmen zu verbinden.

Zu § 12 – Anrechnung von Fehlzeiten

ver.di spricht sich nachdrücklich dafür aus, die starre Fehlzeitenregelung in den Gesundheits(fach)berufen abzuschaffen bzw. gar nicht erst einzuführen. In der hochschulischen Pflegeausbildung ist sie wie bei der Hebammenausbildung ganz entfallen. Auch die über 320 auf Grundlage des BBiG geregelte Ausbildungsberufe kommen i.d.R. ohne eine solche starre Fehlzeitenregelung aus. Entscheidend ist nicht die Anwesenheit gemessen in Stunden, sondern das Bestehen der abschließenden Prüfung. Dadurch wird die Berufsfähigkeit nachgewiesen. Eine Zulassung zur Abschlussprüfung sollte in der Regel erfolgen, wenn die Ausbildung absolviert wurde. Nur in Ausnahmefällen sehr langer Fehlzeiten ist eine Einzelfallentscheidung etwa zur Ausbildungsverlängerung sinnvoll und notwendig. Eine Entscheidung im Einzelfall ist unter Würdigung der jeweiligen Umstände und des Standes der Kompetenzentwicklung sachgerechter als pauschale Regelungen, die in Stundenzahlen gemessen werden.

Zu Absatz 1

Unbeschadet dieser Grundsatzposition führt die Unterscheidung von Fehlzeiten in Theorie und Praxis zu vermeidbaren Ungerechtigkeiten. Während anrechenbare Fehlzeiten von zweimal 9,9 Prozent Fehlstunden zur Prüfungszulassung führen, können 11 Prozent Fehlzeit in einem Bereich bspw. in der Praxis bei vollständigem Absolvieren des Unterrichts eine Zulassung verhindern.

Weitere Fehlzeiten können durch die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verpflichtungen oder tariflicher Freistellungsmöglichkeiten (Hochzeit, Beerdigung, Erkrankung von Kindern, Umzug), die weder Krankheit noch Urlaub sind, entstehen. Gravierend ist, dass auch gesetzliche Freistel-

lungsansprüche unberücksichtigt bleiben. Dies gilt insbesondere für Freistellungs- und Entgeltfortzahlungsansprüche wegen Erkrankung eines Kindes und für die Freistellung zur Pflege Angehöriger von bis zu zehn Ausbildungstagen. Zu den Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes gehören auch Auszubildende. Wird die Fehlzeitenregelung beibehalten, sind diese Freistellungsmöglichkeiten ebenso wie die Teilnahme z. B. an gewerkschaftlichen Aktionen (Warnstreiks) auf die Ausbildung anzurechnen.

Zu Absatz 2

ver.di begrüßt, dass die zuständige Behörde auch über Absatz 1 hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigen kann, wenn eine besondere Härte vorliegt und das Ausbildungsziel nicht gefährdet wird. Was unter „besonderer Härte“ zu verstehen ist, sollte in der Begründung beispielhaft dargestellt werden, da der Umgang damit erfahrungsgemäß sehr unterschiedlich stattfindet. In Satz 2 ist klarzustellen, dass es sich um eine Ausbildungsverlängerung auf Verlangen des/der Auszubildenden nach § 19 Abs. 2 handelt, die nicht vom Träger der praktischen Ausbildung oder der Pflegeschule einseitig verfügt werden kann.

Zu Absatz 3

Die Regelung in Absatz 3 begrüßt ver.di ausdrücklich. Klargestellt wird damit, dass die gesetzlich geregelten Freistellungsansprüche nach dem Betriebsverfassungsgesetz, dem Bundespersonalvertretungsgesetz oder den Landespersonalvertretungsgesetzen nicht als Fehlzeiten im Sinne des § 12 gelten. Es ist klarzustellen, dass auf Grund der hier engen Verknüpfung von schulischer und betrieblicher Ausbildung die Freistellungsansprüche auch in Zeiten theoretischen und praktischen Unterrichts gelten.

Zu § 14 – Ausbildungsvertrag

Zu Absatz 1

ver.di begrüßt, dass ein Ausbildungsvertrag zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung und der*dem Auszubildenden zu schließen ist.

Zu Absatz 2

Analog zu den Bestimmungen zur Vertragsgestaltung nach § 11 Abs. 1 BBiG sind die dortige Nummer 1 „Name und Anschrift des/der Auszubildenden“ und Nummer 8 „Vergütung oder Ausgleich von Überstunden“ zu ergänzen.

Zu Absatz 6

Es ist unnötig, dass der Ausbildungsvertrag im Falle des § 7 Absatz 2 Nummer 2 zu seiner Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der Pflegeschule bedarf. Absatz 6 ist daher ersatzlos zu streichen.

Es sollte genügen, wenn der Träger der praktischen Ausbildung die von ihm eingestellten Auszubildenden bei der mit ihm vertraglich verbundenen Schule anmeldet. Ein gesondertes Auswahlverfahren bei der Schule ist überflüssig und führt im Konfliktfall zu unnötigen Ausbildungsplatzverlusten. Die Verantwortung der Schule bezieht sich auf die Durchführung des theoretischen und praktischen Unterrichts und sinnvollerweise nur auf die Koordination von theoretischem und praktischem Unterricht mit der praktischen Ausbildung, eine „Gesamtverantwortung“ für die Ausbildung kann ihr nicht zugewiesen werden, sie liegt vielmehr beim Vertragspartner der Auszubildenden.

Zu § 15 – Pflichten der Auszubildenden

Die Pflichten der oder des Auszubildenden sind in der vorgesehenen Form mit Ausnahme von Nummer 3 angemessen. Es ist nicht zweckmäßig, die Verantwortung und den zeitlichen Aufwand für den Ausbildungsnachweis allein auf die Auszubildenden zu übertragen. Die Dokumentationspflicht für die praktische Ausbildung liegt beim Träger der praktischen Ausbildung und ist durch diesen auch nachzuweisen. Soweit Auszubildende zur Führung der Ausbildungsnachweise verpflichtet werden, ist ihnen die dafür notwendige Zeit während der Ausbildungszeit einzuräumen und dies entsprechend zu regeln.

Zu § 16 – Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung

Zu Absatz 1

Grundsätzlich begrüßt ver.di die vorgesehenen Regelungen.

Zu Nummer 1

Die Vorgabe eines Ausbildungsplans trägt zur Verbesserung der Ausbildungsqualität bei.

Zu Nummer 3

Positiv ist, dass die Sicherstellung des vorgegebenen Mindestumfangs der Praxisanleitung als Pflicht des Trägers der praktischen Ausbildung verankert wird. Es kann nicht sinnvoll sein, dass Auszubildende sich selbst um die Organisation der notwendigen Praxisanleitung kümmern müssen, wie dies gelegentlich praktiziert wird. Um die Verantwortung des Trägers der praktischen Ausbildung zu unterstreichen, ist ergänzend die Vorgabe zu verankern, dass auch die Dokumentationspflicht der praktischen Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung liegt.

Zu Nummer 4

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass die Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfügung zu stellen sind. Dies muss allerdings für die gesamte Ausbildung gelten und auch die Ausbildungsnachweise (Formulare oder digitale Möglichkeit) umfassen.

Zu Nummer 5

Positiv ist ebenfalls die Vorgabe, dass die Auszubildenden für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen der Schule und für die Teilnahme an Prüfungen freizustellen sind und bei der Gestaltung der praktischen Ausbildung auf die erforderlichen Lern- und Vorbereitungszeiten Rücksicht zu nehmen ist. Lern- und Vorbereitungszeiten sind generell als Ausbildungszeit zu werten. Das sollte nicht nur für die praktische Ausbildung gelten.

Zu Absatz 2

ver.di begrüßt die Regelung als eine wichtige Schutzregelung für Auszubildende.

Zu § 17 – Ausbildungsvergütung

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass der gesetzliche Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung für die gesamte Dauer der Ausbildung verankert wird und die*der Auszubildende den zur Berufsausbildung Beschäftigten im Sinne sozialversicherungsrechtlicher Bestimmungen gleichsteht.

Zu § 18 – Probezeit

Eine Probezeit von vier Monaten ist bei einer Ausbildungsdauer von 18 Monaten zu lang. Das BBiG sieht bei in der Regel dreijährigen Ausbildungen eine zu vereinbarende Probezeit von einem bis vier Monaten vor. Bei einer derart kurzen Ausbildung sollte ein Monat genügen. Zumindest ist in Satz 2 vor „vier“ das Wort „höchstens“ zu ergänzen.

Zu § 19 – Ende des Ausbildungsverhältnisses

ver.di spricht sich dafür aus, dass das Ausbildungsverhältnis mit dem Zeitpunkt der staatlichen Prüfung endet. Auszubildende sollten nach erfolgreich abgelegter staatlicher Abschlussprüfung nicht noch an ein auslaufendes Vertragsverhältnis gebunden werden. Bei dem in den Versorgungsbereichen bestehenden großen Personalbedarf wird so eine schnellere Einmündung in den Arbeitsmarkt ermöglicht. § 19 Absatz 1 sollte wie folgt formuliert werden: „Das Ausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit. Besteht die*der Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungszeit die Abschlussprüfung, so endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss“.

Darüber hinaus begrüßt ver.di ausdrücklich die Regelung in § 19 Absatz 2. Der Rechtsanspruch auf Ausbildungsverlängerung muss auch gegenüber der Pflegeschule gelten. Dies ist im Pflegeberufegesetz entsprechend zu regeln.

Zu § 20 – Kündigung des Ausbildungsverhältnisses

ver.di spricht sich dafür aus, § 20 Absatz 3 Satz 2 zu streichen. Dadurch wird die betriebliche Verantwortung für das Ausbildungsverhältnis unnötig aufgeweicht.

Zu § 22 – Nichtigkeit von Vereinbarungen

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass Schulgeldzahlungen untersagt werden. Ebenso ist klarzustellen, dass auch das Erheben von Gebühren für Prüfungen ausgeschlossen ist.

Zu § 23 – Ausschluss der Geltung von Vorschriften dieses Abschnitts

Die Qualität der Ausbildung und der Schutz der Auszubildenden sind untrennbar miteinander verbunden. Sie bilden das Fundament für eine qualifizierte berufliche Entwicklung und müssen

deshalb einheitlich, transparent und verbindlich geregelt sein – für alle Menschen, gleich aus welchem beruflichen oder gesellschaftlichen Umfeld sie kommen.

Finanzierungsfragen, wie sie etwa im Zusammenhang mit Ausbildungsverhältnissen bei der Bundeswehr thematisiert werden, dürfen nicht dazu führen, bewährte gesetzliche Regelungen zum Ausbildungsverhältnis zu unterlaufen. Sie müssen im Rahmen der Finanzierungsmechanismen gelöst werden, nicht auf Kosten rechtlicher Standards.

Wir fordern daher, den Gesetzentwurf an dieser Stelle zu überarbeiten und die Geltung ausbildungsrechtlicher Schutzvorschriften für alle Auszubildenden uneingeschränkt sicherzustellen. Diese Einschätzung gilt entsprechend für die vorgesehene Regelung im Pflegeberufegesetz.

Zu § 24 – Finanzierung

Es ist grundsätzlich folgerichtig, dass die Finanzierung des praktischen Teils der Pflegefachassistentenausbildung in das bestehende Finanzierungssystem der beruflichen Pflegeausbildung integriert wird. ver.di spricht sich dafür aus, das bestehende Finanzierungssystem der Ausbildungen in der Pflege dahingehend weiterzuentwickeln, dass der schulische Anteil der Ausbildungskosten durch die Länder zu tragen ist. Mit dieser sachgerechten Zuordnung wird eine weitere Belastung der Sozialversicherungsträger (Krankenkassen und Pflegekassen) vermieden.

Darüber hinaus sollte die Kostenverteilung zur Finanzierung der praktischen Ausbildungskosten durch die Leistungserbringer – refinanziert durch die Kostenträger – überprüft werden. Der weitestgrößte Teil der Absolvent*innen einer Pflegefachassistentenausbildung dürfte in die stationäre und ambulante Langzeitpflege einmünden. Dafür braucht es ein neues Gutachten zur Ausbildungsfinanzierung, das die derzeitigen Kosten der Länderausbildungen und ihre Verteilung erfasst, um eine reelle Prognose für die Pflegefachassistentenausbildung zu erhalten. Die Datenbasis aus dem Jahr 2013 ist nicht mehr aussagekräftig. Sie basierte auf den dreijährigen Ausbildungen nach dem Altenpflegegesetz und dem Krankenpflegegesetz. Zugleich ist sicherzustellen, dass es nicht zu einer Überlastung der Pflegekassen sowie der Bewohner*innen kommt. Hier ist eine Lösung dringend erforderlich, damit pflegebedürftige Menschen in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen künftig nicht mehr über Eigenanteile Ausbildungskosten tragen müssen. Das gilt ausdrücklich auch für die Finanzierung der Pflegefachassistentenausbildung. Bereits in der letzten Wahlperiode war angekündigt, dass die Ausbildungskostenumlage aus den Eigenan-

teilen herausgenommen und durch Steuermittel finanziert wird. Die Sicherung von Pflegekräften, sowohl von Pflegefachpersonen als auch von Pflegeassistenten, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Positiv ist, dass über das Umlageverfahren Nachteile im Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen vermieden werden. Problematisch ist am bestehenden Finanzierungsmodell, dass die Finanzierung grundsätzlich über Pauschalbudgets erfolgt. Pauschalen begünstigen die Gestaltung preiswerter Ausbildungsplätze und benachteiligen eine Ausbildungseinrichtung mit besserer Ausstattung oder infolge Tarifbindung höherer Kosten mit der Konsequenz, dass teurere und damit in der Regel auch qualitativ hochwertigere Ausbildungsstätten benachteiligt und zu Kostensenkungen gezwungen werden („Spirale nach unten“). Erforderlich ist vielmehr die Erstattung der tatsächlichen Ausbildungskosten bei wirtschaftlicher Betriebsführung.

Im Gegensatz zur beruflichen Ausbildung nach Pflegeberufegesetz werden die Kosten der Ausbildungsvergütung ohne Anrechnung eines Wertschöpfungsanteils, wie auch in der hochschulischen Ausbildung nach Pflegeberufegesetz, finanziert. Diese Regelung ist zu begrüßen. Zwingend notwendig ist, dass dies entsprechend für die beruflichen Ausbildungen nach Pflegeberufegesetz geregelt wird. Die Anrechnung auf voll ausgebildete Pflegefachpersonen muss entfallen. Es gibt keinen sachlichen Grund für eine differenzierte Regelung zwischen beruflicher und hochschulischer Ausbildung nach Pflegeberufegesetz sowie einer Pflegefachassistentenausbildung. In allen Fällen muss die Ausbildung im Vordergrund stehen. Im Übrigen obliegt es den Tarifvertragsparteien, die Höhe der Ausbildungsvergütung zu vereinbaren. Die Annahme im Gesetzentwurf einer um 16,5 Prozent niedrigeren Ausbildungsvergütung ist spekulativ. Sie wäre nach den vom BAG in ständiger Rechtsprechung festgelegten Kriterien zur Funktion von Ausbildungsvergütungen auch nicht vertretbar.

Aufgrund bisheriger Erfahrungen in der Praxis sollte in der Finanzierungsverordnung eine Klarstellung erfolgen, dass zu den „Kosten der Praxisanleitung“ auch ein höherer als der gesetzlich vorgeschriebene Mindestumfang zur Praxisanleitung gehören kann, wenn dies durch Länderregelungen festgelegt oder von den Tarifvertragsparteien bzw. im Rahmen von betrieblichen Vereinbarungen vereinbart worden ist.

Zu § 44 – Fachkommission

ver.di begrüßt, dass Rahmenpläne für die Pflegefachassistentenausbildung entwickelt werden sollen. Die vorgesehene empfehlende Wirkung führt jedoch dazu, dass es auch weiterhin keine bundesweit einheitlichen Standards gibt. Um eine möglichst bundesweit einheitliche Ausbildung zu erhalten, ist es erforderlich, einen verbindlichen Ausbildungsrahmenplan zu entwickeln – unter Beteiligung der Sozialpartner und des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) analog zu den Vorgaben im BBiG.

Zu § 45 – Beratung; Aufbau unterstützender Angebote und Forschung

ver.di begrüßt, dass das BIBB die Aufgabe der Beratung und Information zur Pflegefachassistentenausbildung sowie die Aufgabe des Aufbaus unterstützender Angebote und Strukturen zur Organisation der Pflegefachassistentenausbildung übernimmt. Ebenso begrüßt ver.di, dass das BIBB die Aufgabe der Forschung zur Pflegefachassistentenausbildung und zum Pflegeberuf übernimmt. Wichtig ist, dass die Standards zur Berufsbildungsforschung aus dem BBiG ebenfalls auf die Gesundheits(fach)berufe übertragen werden.

Zu § 46 – Statistik; Verordnungsermächtigung

ver.di begrüßt grundsätzlich die Ermächtigung zum Erlass einer Statistikverordnung für die Pflegefachassistentenausbildung. Ergänzend sollten sich die Vorschriften für die Erhebung statistischer Daten am Vorbild des § 88 des BBiG orientieren. Es ist nicht ersichtlich, weshalb gerade in den Pflegeberufen, die durch einen erheblichen Personalbedarf gekennzeichnet sind, geringere Anforderungen an die zu erhebende Statistik gestellt werden. Beispielsweise sind Erhebungen über die Praxisanleiter*innen, ihre Qualifikation und Prüfungsteilnahmen und deren Erfolg vorzusehen. Ein besonderes Augenmerk sollte auf den Zeitpunkt vorzeitiger Vertragsauflösungen, die Kündigenden und deren Gründe (Probezeitkündigungen, Kündigungen der Auszubildenden, Auflösungsverträge) sowie das Nichtbestehen der Abschlussprüfungen gelegt werden.

Zu § 49 – Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes

§ 49 ist zu streichen. Das BBiG enthält Schutzbestimmungen für die Auszubildenden. Es gibt keinen sachlichen Grund, weshalb es nicht ergänzend zum Pflegefachassistentengesetz gelten sollte.

Zu § 50 – Fortgeltung der Berufsbezeichnung

Die Vorschrift zum Fortgelten der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung für Helfer- oder Assistenzbildungen in der Pflege von mindestens einjähriger Dauer ist sachgerecht.

Zu § 51 – Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestandsschutz

ver.di begrüßt die in § 51 vorgesehene Regelungen zum Bestandsschutz von Leitungs- und Lehrkräften an Pflegeschulen sowie die Möglichkeit, in einem Übergangszeitraum die Mindeststandards nach den „Eckpunkten für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ der ASMK 2012 und der GMK 2013 (BANZ AT 17. Februar 2016 B3) zu erfüllen.

Zu § 52 – Übergangsvorschriften für landesrechtliche Ausbildungen

Es handelt sich um erforderliche und sinnvolle Übergangsvorschriften, damit begonnene Ausbildungen zu Ende geführt werden können. Soweit Pflegeassistenten- oder Pflegehelfer*innenausbildungen noch nach anderen landesrechtlichen Vorschriften begonnen wurden, müssen diese ebenfalls nach den bis dahin geltenden Vorschriften abgeschlossen werden können.

Zu § 54 – Evaluierung

Eine Evaluierung des § 10 Absatz 2, § 11 Absatz 2 und Teil 2 Abschnitt 3 muss unabhängig und nach im Gesetz festgelegten Kriterien wissenschaftlich erfolgen.

Zu Artikel 2 – Änderung des Pflegeberufgesetzes

Zu Nummer 1

ver.di lehnt die geplante Regelung ab, dass ein geringer Anteil der praktischen Ausbildung durch praktische Lerneinheiten an der Pflegeschule oder beim Träger der praktischen Ausbildung ersetzt werden kann.

Zu Nummer 2

Es ist notwendig, die seit Langem bestehenden Probleme in der Lehrer*innen-Bildung zu lösen; eine Verlängerung der Übergangsfrist ändert nichts an den Herausforderungen. Dringend geboten ist es, unverzüglich wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um für eine ausreichende Zahl an fachlich und pädagogisch qualifizierten Lehrkräften an den Pflegeschulen zu sorgen. Es braucht in den Ländern gebührenfreie Studienplätze, die den notwendigen Qualitätsstandards entsprechen.

Zu Nummer 3

ver.di begrüßt, dass die Durchlässigkeit der Pflegefachassistentenausbildung in die Pflegefachausbildung nach dem Pflegeberufegesetz gewährleistet werden soll. Eine abgeschlossene Pflegefachassistentenausbildung ist dabei im vollen Umfang ihrer Dauer auf die Fachausbildung anzurechnen. Zudem sind die Ausbildungen so zu gestalten, dass der Einstieg in die Fachausbildung nahtlos möglich ist.

Weiterer Regelungsbedarf mit Blick auf das Pflegeberufegesetz

Junge Menschen für die Pflegeausbildung zu gewinnen und sie dauerhaft im Beruf zu halten, ist für die Fachkräftesicherung entscheidend. Für eine nachhaltige Stärkung der Pflegeausbildung muss das Pflegeberufegesetz wie nachfolgend aufgeführt nachgebessert werden:

- Die Einführung eines Mindestumfangs zur geplanten und strukturierten Praxisanleitung im Pflegeberufegesetz war ein wichtiger Schritt. Doch es besteht dringender Handlungsbedarf, damit die Praxisanleitung quantitativ und qualitativ im erforderlichen Umfang flächendeckend umgesetzt wird. Erforderlich sind Konsequenzen bei Nichteinhaltung des Mindestumfangs, die Ausbildungsbetriebe müssen in diesem Fall sanktioniert werden. Angesichts der großen Bedeutung der Praxisanleitung für eine gelingende Ausbildung ist der Mindestumfang für Praxisanleitung von 10 Prozent auf 30 Prozent zu erhöhen. Daneben ist die situative Anleitung in alltäglichen Lernsituationen durch ständige Anwesenheit qualifizierten Fachpersonals sicherzustellen. Die Praxisanleiter*innen sind für die Erfüllung ihrer Aufgaben inklusive der Vor- und Nachbereitungszeiten von der Pflegearbeit freizustellen.

Aufgrund bisheriger Erfahrungen in der Praxis sollte in der Finanzierungsverordnung eine Klarstellung erfolgen, dass zu den „Kosten der Praxisanleitung“ auch ein höherer als der gesetzlich

vorgeschriebene Mindestumfang zur Praxisanleitung gehören kann, wenn dies durch Länderregelungen festgelegt oder von den Tarifvertragsparteien bzw. im Rahmen von betrieblichen Vereinbarungen vereinbart worden ist.

- Das „angemessene Verhältnis“ von Fachkräften zu Auszubildenden ist in § 7 Abs. 5 PflBG im Sinne der hierzu erfolgten Rechtsprechung festzulegen (vgl. entsprechende Ausführungen zu § 6 Abs. 3).
- Die Ausbildung muss im Vordergrund stehen. Auszubildende dürfen nicht auf Stellen für ausgebildetes Personal angerechnet werden. Entsprechend der hochschulischen Ausbildung nach Pflegeberufegesetz braucht es auch für die berufliche Ausbildung eine Regelung, dass die Kosten der Ausbildungsvergütung ohne Anrechnung eines Wertschöpfungsanteils finanziert werden.
- Im Rahmen der Umsetzung der generalistischen Ausbildung besteht für die Einsätze im ambulanten Bereich dringender Handlungsbedarf. Aus der Praxis wird wiederholt berichtet, dass Auszubildende oftmals allein zu den pflegebedürftigen Menschen fahren müssen. Um dieser Praxis zu begegnen, ist eine Klarstellung im Gesetz angebracht, dass die Ausbildung immer unter Aufsicht und Anleitung einer Pflegefachperson erfolgen muss. Damit wird eine wichtige Voraussetzung geschaffen, dass die Ausbildung im Vordergrund steht.
- In der Ausbildung nach Pflegeberufegesetz scheinen aufgrund der Rückmeldungen aus der Praxis wichtige Querschnittskompetenzen, die für die Berufsausübung generell erforderlich sind, nicht in ausreichendem Umfang vermittelt zu werden. Dies betrifft insbesondere die Kompetenzfelder „Arbeits- und Tarifrecht“. Diese grundlegenden Kompetenzen könnten in Anlehnung an die Standardberufsbildpositionen der dualen Ausbildungsberufe in der Ausbildungspraxis vermittelt werden, ggf. sind sie auf die Besonderheiten der Heilberufe entsprechend anzupassen. Ergänzend sollten auch die Kenntnisse zum Berufs- und Ausbildungsrecht ausgeweitet werden. Damit könnten die Auszubildenden für ihr späteres Berufsleben gestärkt werden.
- Es gibt keinen sachlichen Grund für eine unterschiedliche Anwendung der Fehlzeitenregelung. Analog zur hochschulischen Pflegeausbildung ist auch in der beruflichen Pflegeausbildung auf die starre Fehlzeitenregelung zu verzichten. Die Berufsfähigkeit wird durch das Bestehen der abschließenden Prüfung nachgewiesen. Die Anwesenheit gemessen in Stunden ist dagegen nicht entscheidend.

Immer wieder wird von Problemen berichtet, Jugend- und Auszubildendenvertretungen auch während der theoretischen Ausbildungszeit an Pflegeschulen für ihre Aufgaben freizustellen.

Auf Grund der engen Verzahnung von theoretischem Unterricht und praktischer Ausbildung genügt es zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht, sie allein während der Praxisphasen freizustellen. Gerade bei diesen engagierten Auszubildenden führt die rigide Fehlzeitenregelung dazu, dass sie Gefahr laufen, nicht zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden.

Zu Artikel 10 – Änderung des DRK-Gesetzes

ver.di lehnt ab, dass vereinsrechtlich organisierte Schwesternschaften des Deutschen Roten Kreuz e. V. Träger der praktischen Ausbildung sein können. Die Änderung des DRK-Gesetzes ist ersatzlos zu streichen. Die betriebliche Mitbestimmung muss umfassend, auch bei der Berufsbildung, sichergestellt sein. Unbeschadet der grundsätzlichen Positionierung müsste die Regelung aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im Pflegeberufegesetz erfolgen.

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Ausschussdrucksache 21(13)9e
vom 30. September 2025

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefach-
assistentenausbildung“

BT-Drucksache 21/1493

Kathrina Edenharter

Deutscher Pflegerat e. V. (DPR)

**Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e. V. (DPR) zum
Gesetzesentwurf des Deutschen Bundestages
Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer
bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung
Stand 08.09.2025**

Der Deutsche Pflegerat (DPR) vertritt als Dachverband der bedeutendsten Berufsverbände des deutschen Pflege- und Hebammenwesens und der Pflegewissenschaft die Positionen der Pflegeorganisationen und ist primärer Ansprechpartner für die Politik. Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Gesetzesentwurf (GeE) des Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung Stellung nehmen zu dürfen.

Mit dem Pflegeberufegesetz (PflBG) wurde die Ausbildung zur Pflegefachperson grundlegend neu und bundeseinheitlich geregelt und neben der generalistischen beruflichen Ausbildung erstmals ein primärqualifizierendes, generalistisches Pflegestudium eingeführt. Der DPR begrüßt ausdrücklich die mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf geplante bundeseinheitliche Regelung der Pflegefachassistentenausbildung mit einem klaren und einheitlichen Berufsprofil.

Denn die bislang landesrechtlich und damit unterschiedlich geregelte Assistentenausbildung ermöglicht keine Durchlässigkeit im Pflegebildungssystem und hemmt damit die Entwicklung eines Qualifikationsmixes. Zugleich wirken sich die unterschiedlichen landesrechtlichen Regelungen in der Langzeitpflege erheblich auf die Pflegesatzvereinbarungen nach § 84 Absatz 6 SGB XI (stationäre Pflege), auf Vergütungsvereinbarungen nach § 89 SGB XI (ambulante Pflege) sowie auf Vergütungsvereinbarungen nach § 132a SGB V (ambulante Pflege) aus, was zu Unterschieden bei der Absicherung der Versorgung von Patient:innen sowie ihren An- und Zugehörigen führt.

Um die Attraktivität dieses Pflegeberufs zu steigern, kommt der Entwicklung eines einheitlichen Berufsprofils mit klaren Entwicklungspfaden für die Pflegefachassistenten eine zentrale Bedeutung zu. Um die Qualität und Sicherheit in allen Versorgungsbereichen der beruflichen Pflege zu sichern und eine Durchlässigkeit in der Pflegebildung zu gewährleisten, ist zudem eine Abgrenzung der Kompetenz- und Aufgabenbereiche zwischen Pflegefachpersonen mit und ohne akademische Qualifizierung sowie ausgebildeten Pflegefachassistent:innen erforderlich. Ausbildungsgänge der beruflichen Pflege müssen passgenau aufeinander abgestimmt und in einem gelingenden sowie bedarfsgerechten Qualifikationsmix abbildbar sein.

Eine dem DQR-Niveau 3 zugeordnete zweijährige duale Berufsausbildung für Pflegefachassistent:innen (BBiG § 5, Absatz 1, KMK 2023) entspricht dem erwartbaren Kompetenzniveau und sichert die Durchlässigkeit zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau/zur Pflegefachperson auf DQR-Niveau 4 konsequent ab. Im Gegensatz dazu erfüllt eine auf DQR-Niveau 2 zu beurteilende und um ein Drittel verkürzte Ausbildung, die mit einem reduzierten Kompetenzprofil verbunden ist und zu einer Tätigkeit als „Pflegehelferin“, „Pflegehelfer“ oder „Pflegehilfeperson“ mit erheblich begrenzten Einsatzfeldern befähigt, nicht die Anforderungen einer qualitativ hochwertigen Pflegepraxis, sondern befördert die Absenkung von Kompetenzen im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Personalanhaltszahlen nach § 113c Absatz 1 Nummer 2 SGB XI im Zuge der Umsetzung des Personalbemessungsinstruments (PeBeM) mitzubedenken.

Zusammenfassend bekräftigt der DPR zum wiederholten Male seine Forderung nach einer bundeseinheitlichen, generalistischen, zweijährigen Pflegefachassistenz-ausbildung, um die Versorgungsqualität zu sichern, wie auch das erforderliche vergleichbare Qualifizierungsniveau für die Stellen nach § 113c Absatz 1 Nummer 2 SGB XI zu erreichen. Hier ist darüber hinaus dringend auf die erforderliche Harmonisierung zwischen den DQR-Niveaus und den QN-Stufen der Personalanhaltszahlen und auf das ordnungsrechtliche Anerkennen von Hilfspersonal und deren Weiterqualifizierungsmöglichkeiten hinzuweisen (DPR, 2023a).

Die Möglichkeiten der Ausbildungsverkürzung (§ 11) sind vor dem Hintergrund des Personalmangels nachvollziehbar, lassen aber bezweifeln, dass die in § 4 beschriebenen Kompetenzen auf diese Weise ausgebildet werden können. Dass die Länder für das Kompetenzfeststellungsverfahren zuständig sind, wird wieder zu einer Vielzahl unterschiedlicher Regelungen führen, wodurch das Ziel einer bundeseinheitlichen Ausbildung verfehlt wird.

Zudem stellt der DPR in Frage, ob die Pflegehilfe mit eingeschränkten Aufgaben und Befugnissen als eigenständiger Heilberuf im Sinne des Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 GG anerkannt ist, der bundeseinheitliche Ausbildungsregularien erforderlich macht.

Der DPR betont zudem, dass die Pflegefachassistenz nicht isoliert betrachtet werden darf. Vielmehr sollte sie als Teil einer übergreifenden Bildungsarchitektur konzipiert werden, die individuelle Bildungsbiografien fördert, flexible Übergänge ermöglicht und den Einstieg in die berufliche Pflege stärkt. Unabhängig von der notwendigen Ausbildungsdauer sollte diese neue Ausbildung als Chance verstanden werden, über ein neues Bildungskonzept Menschen für den sinnstiftenden Pflegeberuf zu gewinnen.

Die Ausbildung muss die Versorgungssicherheit unter professioneller Begleitung entsprechend den Vorgaben zur Ausübung der pflegerischen Vorbehaltsaufgaben im Pflegeberufegesetz stärken, nicht nur als Assistenzfunktion, sondern auch impulsgebend für berufliches Wachstum innerhalb der Pflege. In diesem Zusammenhang ist auch das BAPID-Projekt des Deutschen Pflegerates (Bildungsarchitektur der Pflege in Deutschland) von besonderer Relevanz. Es zeigt modellhaft, wie Durchlässigkeit in der Berufsbildung der Pflege ermöglicht wird, Bildungswege eröffnet werden und die Attraktivität des Pflegeberufes nachhaltig steigert.

Im Folgenden positioniert sich der DPR zu den einzelnen Regelungsschwerpunkten im Pflegefachassistenzgesetz.

Artikel 1 Gesetz über den Pflegefachassistentenberuf (Pflegefachassistentengesetz – PflFAssG)

Teil 2 Ausbildung in der Pflegefachassistenz

Abschnitt 1 Ausbildung

§ 4 Ausbildungsziel

Absatz 1 regelt insbesondere die selbständige Durchführung von Pflegemaßnahmen in nicht komplexen Pflegesituationen. Dabei kann der Begriff „selbstständig“ als Element des Tätigwerdens in eigener Verantwortung verstanden werden, was klar von den Aufgaben der Pflegefachpersonen abgegrenzt werden muss. Der Begriff „komplex“ lässt in der Versorgungspraxis einen erheblichen Interpretationsspielraum zu, was die Handhabung in der Versorgungspraxis erschwert. Der DPR empfiehlt daher, den Begriff „stabil“ aufzunehmen, um die Einordnung von Versorgungssituationen zu erleichtern.

Änderungsvorschlag zu § 4 Absatz 1

Die Pflegefachassistentenausbildung vermittelt die unter Beachtung der Pflegeprozessverantwortung von Pflegefachpersonen in akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlichen Kompetenzen zur selbständigen Durchführung von Pflegemaßnahmen in **stabilen**/nicht komplexen Pflegesituationen sowie für die Mitwirkung an Pflegemaßnahmen in **nicht stabilen**/komplexen Pflegesituationen für Menschen aller Altersstufen. Die zu erwerbenden Kompetenzen umfassen fachliche und personale Kompetenzen einschließlich der zugrunde liegenden methodischen, sozialen, diversitätssensiblen, kommunikativen und digitalen Kompetenzen und der zugrunde liegenden Lernkompetenzen sowie der Fähigkeit zum Wissenstransfer und zur Selbstreflexion. Lebenslanges Lernen wird dabei als ein Prozess der eigenen beruflichen Biographie verstanden und die fortlaufende persönliche und fachliche Weiterentwicklung als notwendig anerkannt.

§ 4 Ausbildungsziel, Absatz 2

In Satz 2 des Absatzes 2 des § 4 wird analog zum Pflegeberufegesetz die begriffliche Bedeutung der umfassenden und prozessorientierten Pflege im Sinne des Absatzes 1 dargelegt. Die hier festgelegte Aufgabe einer (systematischen und bedürfnisorientierten Vorbereitung, Durchführung und Evaluation) edukativ-pflegerischen Intervention Beratung setzt pflegefachliche und pflegewissenschaftliche Kompetenzen voraus, die ein pflegeberufliches Qualifikationsniveau auf Niveaustufe DQR 4 und höher erfordern und nicht dem Ausbildungsniveau der Pflegefachassistentenausbildung entsprechen. Daher schlägt der DPR vor, die Beratung zu streichen.

Änderungsvorschlag zu § 4 Absatz 2

Pflege im Sinne des Absatzes 1 umfasst präventive, kurative, rehabilitative, palliative und sozialpflegerische Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung, Wiedererlangung oder Verbesserung der physischen und psychischen Situation der zu pflegenden Menschen, **sowie** ihre ~~Beratung sowie ihre~~ Begleitung in allen Lebensphasen und die Begleitung Sterbender.

§ 4 Ausbildungsziel, Absatz 3

§ 4 Absatz 3 benennt die Durchführung ärztlich angeordneter Maßnahmen als Bestandteil der beruflichen Aufgaben von Pflegefachassistentenpersonen. Diese Formulierung bleibt unspezifisch und bietet Interpretationsspielraum. Aus Sicht des DPR sollte im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine stärkere Verhältnisbestimmung zu den Aufgaben von Pflegefachpersonen erfolgen. Eine fachlich klar begründete Aufgabenabgrenzung zwischen Pflegefach- und Assistenzberufen trägt zur Patient:innensicherheit, zu professioneller Rollenklarheit und zu einer besseren Zusammenarbeit im Team bei.

Ergänzungsvorschlag zu § 4 Absatz 3

Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung muss näher bestimmen, welche ärztlich angeordneten Maßnahmen in Abgrenzung zur Pflegefachperson durch Pflegefachassistentenpersonen durchgeführt werden dürfen.

§ 4 Ausbildungsziel, Absatz 4

Aus professionstheoretischer Sicht kann der Berufsabschluss einer Pflegefachassistentenperson nicht als Profession im engeren Sinne bezeichnet werden. Aufgrund der Abgrenzung zu den Qualifikationsniveaus der beruflich und akademisch ausgebildeten Pflegefachpersonen sollte das Wort „professionell“ als nähere Erläuterung zum Ausbildungsziel gestrichen und durch den Begriff „pflegefachlich“ ersetzt werden.

Änderungsvorschlag zu § 4 Absatz 4

Während der Ausbildung zur Pflegefachassistentin, zum Pflegefachassistenten oder zur Pflegefachassistentenperson werden ein ~~professionelle~~ **pflegefachlich**, ethisch fundiertes Pflegeverständnis und ein berufliches Selbstverständnis ~~entwickelt~~ **angebaut** und gestärkt.

§ 5 Dauer und Struktur der Ausbildung, Absatz 1, Satz 1

Der DPR möchte wiederholt bekräftigen, dass sich für eine bundeseinheitliche, duale Ausbildung zur Pflegefachassistentenperson, bestehend aus theoretischem und praktischem Unterricht sowie einer praktischen Ausbildung, eine Dauer von 24 Monaten in Vollzeitform und von Teilzeitformen notwendig ist. Nur eine Ausbildungsdauer von 24 Monaten gewährleistet die Vermittlung der in § 4 beschriebenen Kompetenzen.

Darüber hinaus verlieren durch eine Ausbildungsdauer von 18 Monaten zugewanderte Personen mit unsicherem Aufenthaltsstatus die Möglichkeit einer Ausbildungsduldung nach § 60c Aufenthaltsgesetz (AufenthG) oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG. Diese Titel erfordern eine mindestens zweijährige qualifizierte Berufsausbildung wie auch die Anerkennung der Ausbildung als Engpassberuf durch die Bundesagentur für Arbeit. Zudem fällt nach § 131a SGB III bei einer Ausbildungsdauer von 18 Monaten die Förderung durch die Bundesagentur weg.

Angesichts des hohen Bedarfs an Pflegefachassistentenpersonen müssen alle Ressourcen genutzt werden, um Pflegequalität und -quantität zu sichern.

Änderungsvorschlag zu § 5 Absatz 1

Die Ausbildung zur Pflegefachassistentin, zum Pflegefachassistenten oder zur Pflegefachassistentenperson dauert unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprüfung in Vollzeitform **24 Monate**, in Teilzeitform höchstens **48 Monate**. (...)

§ 6 Durchführung der praktischen Ausbildung und § 7 Träger der praktischen Ausbildung

Der praktische Teil der Ausbildung umfasst Einsätze in verschiedenen Einrichtungen. Gemäß § 6 ist geregelt, welche Einrichtungen jeweils in Betracht kommen. Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass der Einsatz, der kein Pflichteinsatz ist, unter anderem im Bereich der Rehabilitation absolviert werden kann. Darüber hinaus wäre die Verankerung der Rehabilitationseinrichtungen neben den genannten Einrichtungen als Träger der praktischen Ausbildung im Rahmen des § 6 Absatz 1 sachgerecht.

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen bieten sich aufgrund der Spannbreite an Indikationen und der Komplexität rehabilitativer Maßnahmen für die Durchführung eines Pflichteinsatzes und in diesem Zusammenhang als Ausbildungsträger für eine Pflegefachassistentenausbildung an. Soweit sie die Voraussetzungen für die Pflegefachassistenten-

ausbildung erfüllen, können sie zur Schaffung weiterer Ausbildungskapazitäten in der Pflege beitragen.

Änderungsvorschlag zu § 6 Absatz 1

[...] **4. Zur Versorgung nach § 111 SGB V zugelassene Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen.**

§ 8 Mindestanforderungen an Ausbildungseinrichtungen für Pflegeberufe Pflegeschulen, Absatz 1, Nummer 2

Im vorliegenden Gesetzesentwurf zeigt sich ein Unterschied in den Qualifikationsanforderungen für Lehrende betreffend den theoretischen und praktischen Unterricht. Während Lehrende des theoretischen Unterrichts insbesondere über eine pflegepädagogische, abgeschlossene Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Niveau verfügen müssen, ist für Lehrende des praktischen Unterrichts lediglich eine abgeschlossene Hochschulausbildung erforderlich. Dabei unterscheiden sich die pädagogisch-didaktischen Anforderungen an Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Lehr-Lerneinheiten in Theorie und Praxis nur geringfügig. Sowohl der theoretische als auch der praktische Unterricht müssen eine hohe Ausbildungsqualität sicherstellen, um den steigenden Anforderungen an das Pflegepersonal gerecht zu werden.

Änderungsvorschlag zu § 8 Absatz 1, Nummer 2

Nachweis einer im Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze angemessenen Zahl fachlich und pädagogisch qualifizierter Lehr**kräftepersonen** mit entsprechender, insbesondere pflegepädagogischer, abgeschlossener Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Niveau für die Durchführung des theoretischen Unterrichts sowie mit entsprechender, insbesondere pflegepädagogischer, abgeschlossener Hochschulausbildung **auf Master- oder vergleichbarem Niveau** für die Durchführung des praktischen Unterrichts, (...)

§ 8 Mindestanforderungen an Ausbildungseinrichtungen für Pflegeberufe Pflegeschulen, Absatz 1, Nummer 3

Die Qualität der beruflichen Ausbildung hängt wesentlich von der materiellen Infrastruktur der Ausbildungsstätten und von der materiellen Infrastruktur der Ausbildungsstätten ab. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung der pflegerischen Versorgung. Eine angemessene digitale Ausstattung, etwa mit Lernplattformen, Simulationssystemen oder digitalen Dokumentationsmitteln, muss Bestandteil der Anforderungen an Pflegeschulen sein. Dadurch kann eine realitätsnahe und zukunftsorientierte Ausbildung gewährleistet werden

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Zielgruppe der Pflegefachassistentenausbildung heterogen ist. Viele Auszubildende bringen womöglich ein niedriges schulisches Ausgangsniveau mit. Daraus ergibt sich häufig ein erhöhter Unterstützungsbedarf. Neben der fachlichen Förderung sind auch psychosoziale Unterstützungsangebote erforderlich, um Ausbildungsabbrüchen vorzubeugen und eine nachhaltige berufliche Integration zu ermöglichen. In der Umsetzung des Gesetzes sollte berücksichtigt werden, dass Träger der theoretischen und praktischen Ausbildung entsprechende Strukturen entwickeln und vorhalten können.

Änderungsvorschlag zu § 8 Absatz 1 Nummer 3:

3. Vorhandensein der für die Ausbildung erforderlichen Räume und Einrichtungen sowie ausreichender Lehr- und Lernmittel, die den Auszubildenden kostenlos zur Verfügung zu stellen sind. **Die räumliche und sachliche Ausstattung der Ausbildungseinrichtungen**

muss eine angemessene digitale Infrastruktur zur Unterstützung moderner Lehr- und Lernprozesse einschließen. Zudem müssen geeignete Maßnahmen zur individuellen Lernbegleitung und psychosozialen Unterstützung der Auszubildenden vorgehalten werden. Den Belangen von Menschen mit Behinderungen ist Rechnung zu tragen.

§ 8 Mindestanforderungen an Ausbildungseinrichtungen für Pflegeberufe Pflegeschulen, Absatz 2

Aus Sicht des DPR ist das Verhältnis von mindestens einer Vollzeitstelle auf 20 Ausbildungsplätze für hauptberufliche Lehrkräfte eine unangemessen hohe berufliche Anforderung. Berücksichtigt werden muss das geringe Eingangsniveau in die Berufsausbildung und die zu erwartende Heterogenität der Auszubildenden, die mit einem Hauptschulabschluss die Berufsausbildung beginnen und neben dem Berufsabschluss einen erweiterten Hauptschulabschluss nachholen sollten. Entsprechend ist mit einem hohen didaktischen und personellen Betreuungsaufwand zu rechnen und es sind weitreichende (pädagogisch-diagnostische) Kompetenzen erforderlich, um den Unterricht stärker an individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen der Auszubildenden zu orientieren. Der DPR spricht sich daher für eine deutliche Absenkung der Anzahl der Ausbildungsplätze für hauptberufliche Lehrkräfte aus.

Änderungsvorschlag zu § 8 Absatz 2

Das Verhältnis nach Absatz 1 Nummer 2 soll für die hauptberuflichen Lehrkräftepersonen mindestens einer Vollzeitstelle auf **10** Ausbildungsplätze entsprechen. (...)

§ 8 Mindestanforderungen an Ausbildungseinrichtungen für Pflegeberufe Pflegeschulen, Absatz 3

Kritisch sieht der DPR vor allem die mögliche Herabsetzung der Mindestanforderungen an die Ausbildungseinrichtungen durch die Länder, wie aber auch in Teilen die Festlegung darüberhinausgehender Anforderungen durch diese. Dies steht der bundesweiten Einheitlichkeit der Ausbildung entgegen.

Befristet soll für die Länder bis zum 31. Dezember 2035 gelten, dass hauptberufliche Lehrpersonen geringere Abschlüsse vorweisen können. Begründet wird dies durch eine schwierige Akquise von Lehrpersonen mit einem Master- oder vergleichbarem Niveau. Eine derartige Maßnahme kann die einheitliche Ausbildung auf einem gesicherten hohen Niveau gefährden.

Änderungsvorschlag zu § 8 Absatz 3

Die Länder können durch Landesrecht das Nähere zu den Mindestanforderungen nach den Absätzen 1 und 2 ~~bestimmen und weitere, auch darüber hinausgehende Anforderungen festlegen. Sie können für die Lehrkräfte für die Durchführung des theoretischen Unterrichts nach Absatz 1 Nummer 2 zeitlich befristet bis zum 31. Dezember 2030~~ regeln, inwieweit die erforderliche Hochschulausbildung nicht oder nur für einen Teil der Lehrkräftepersonen auf Master- oder vergleichbarem Niveau vorliegen muss.

§ 10 Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung, Absatz 1 und Absatz 2

Der DPR folgt der im BAPID-Projekt entwickelten Logik einer Bildungsarchitektur für Pflegeberufe (Genz & von Gahlen-Hoops, 2024) und sieht eine Durchlässigkeit in den Pflegebildungsstrukturen über alle Qualifikationsniveaus hinweg als absolut notwendig an. Um diese Durchlässigkeit zu erreichen, ist als Mindestvoraussetzung für den Zugang zur Ausbildung zur Pflegefachassistent:innen unbedingt ein Hauptschulabschluss oder ein anderer gleichwertiger Schulabschluss bzw. Berufsbildungsreife erforderlich.

Änderungsvorschlag zu § 10 Absatz 1 und Absatz 2

(1) Voraussetzung für den Zugang zu der Ausbildung zur Pflegefachassistentin, zum Pflegefachassistenten oder zur Pflegefachassistentenzperson ist **mindestens der Hauptschulabschluss, ein anderer gleichwertiger Schulabschluss/gleichwertige Bildungsreife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung.**

~~(2) Abweichend von Absatz 1 wird der Zugang zur Ausbildung gewährt, wenn eine positive und sachlich begründete Prognose der Pflegeschule dahingehend vorliegt, dass die Ausbildung von der auszubildenden Person erfolgreich absolviert und die staatliche Abschlussprüfung bestanden werden kann.~~

§ 11 Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen und Berufserfahrung, Absatz 2

Um das Ausbildungsziel zu erreichen, das meint die selbstständige Durchführung von Pflegemaßnahmen in stabilen/nicht komplexen Pflegesituationen, ist eine Ausbildungsdauer von 24 Monaten unbedingt erforderlich. Dabei umfasst das Ausbildungsziel den Erwerb fachlicher und personaler Kompetenzen sowie methodischer, sozialer, diversitätssensibler, kommunikativer und digitaler Kompetenzen. Ebenso sind Lernkompetenz, die Fähigkeit zum Wissenstransfer sowie zur Selbstreflexion zentrale Bestandteile.

In Absatz 2 wird geregelt, dass die Dauer der praktischen Pflegefachassistentenausbildung durch Anrechnung um den vollen Umfang und die Dauer des theoretischen und praktischen Unterrichts auf 320 Stunden (im Sinne eines Vorbereitungskurses) verkürzt werden kann, wenn die Ausbildung nach Pflegeberufegesetz abgebrochen wurde oder praktische Erfahrung vorliegt. Zudem soll es ein Kompetenzfeststellungsverfahren geben, das die Länder regeln.

Eine praktische Tätigkeit kann allerdings den theoretischen Unterricht nicht ersetzen. Die erforderlichen Kompetenzen, wie sie in § 1 Absatz 1 beschrieben werden, erfordern auch einen gezielten theoretischen Unterricht. Für eine geplante Verkürzung der Ausbildungszeit sollte die Fachkommission gemäß § 44 einen Rahmenlehrplan erarbeiten, der neben der Prüfungsvorbereitung insbesondere die kritische Reflexion der bisherig gesammelten Praxiserfahrung und der Grenzen der eigenen Handlungsbefugnisse sowie die pflegewissenschaftlichen, medizinische und bezugswissenschaftlichen Grundlagen der pflegepraktischen Arbeit zum Gegenstand hat.

Das Kompetenzfeststellungsverfahren kann einer bundeseinheitlichen Regelung zudem entgegenstehen, da unterschiedliche landesspezifische Ausgestaltungen die Vereinheitlichungsbemühungen, die das PflFAssG zum Ziel hat, erschweren.

Der DPR schlägt daher vor, in Absatz 2 Nummer 2 zu streichen.

Änderungsvorschläge zu § 11 Absatz 2

(2) Die zuständige Behörde kann auf Antrag der auszubildenden Person, bei Vorliegen einer sachlich begründeten positiven Prognose der Ausbildungseinrichtung hinsichtlich des erfolgreichen Abschlusses der Pflegeassistentenausbildung mit Bestehen der staatlichen Abschlussprüfung durch die antragstellende Person, die Dauer der praktischen Pflegefachassistentenausbildung durch Anrechnung um den vollen Umfang und die Dauer des theoretischen und praktischen Unterrichts auf 320 Stunden verkürzen (Vorbereitungskurs), wenn

1. eine Ausbildung nach Pflegeberufegesetz erst nach der Hälfte der Ausbildungsdauer abgebrochen wurde und der Nachweis vorliegt, dass der Abbruch der Ausbildung bei Antragstellung nicht länger als 36 Monate zurückliegt.

~~2. eine mindestens 36 Monate dauernde praktische Vollzeittätigkeit in der Pflege in einer oder mehreren Einrichtungen nach § 6 Absatz 1 oder in insgesamt dem gleichen zeitlichen Umfang eine praktische Teilzeittätigkeit in der Pflege in einer oder mehreren Einrichtungen nach § 6 Absatz 1 und der Nachweis vorliegen, dass das Ende der Vollzeit oder der Teilzeittätigkeit bei Antragstellung nicht länger als 36 Monate zurückliegt.~~

Teil 2 Ausbildung in der Pflegefachassistenz

Abschnitt 2 Ausbildungsverhältnis

§ 16 Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung, Absatz 1, Nummer 3

Der DPR begrüßt ausdrücklich, dass der Träger der praktischen Ausbildung gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 verpflichtet ist, die in § 5 Absatz 3 Satz 3 definierte Praxisanleitung im Umfang von 10 % der Einsätze als wesentlichen Bestandteil einer hochwertigen praktischen Ausbildung zu berücksichtigen.

Die Qualität der praktischen Ausbildung hängt maßgeblich von der Qualifikation und zeitlichen Freistellung der Praxisanleitenden ab. Studien zeigen, dass unzureichende Anleitungskapazitäten zu Überforderung, erhöhtem Abbruchrisiko und geringerer Ausbildungsqualität führen (Köhler et al., 2023). Eine Anleitungsquote von 10 % ist somit als Minimum zu betrachten. Zudem sind die theoretische und praktische Ausbildung stärker miteinander zu verzahnen (BMBF, 2023).

§ 18 Probezeit

Im Rahmen von den vorgeschlagenen vier Monaten ist eine angemessene Einschätzung zur Befähigung zum Beruf nicht möglich.

Änderungsvorschlag zu § 18

Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Die Probezeit beträgt **sechs** Monate. ~~sofern sich aus tarifvertraglichen Regelungen keine andere Dauer ergibt.~~

Teil 2 Ausbildung in der Pflegefachassistenz

Abschnitt 3 Finanzierung der Pflegefachassistentenausbildung

§ 24 Finanzierung

Mit Inkrafttreten des PflFAssG ist geplant, dass die Kosten der Pflegefachassistentenausbildung durch Ausgleichsfonds in entsprechender Anwendung von § 26 Absatz 2 bis 7, § 27 Absatz 1 sowie der §§ 28 bis 36 PflBG finanziert sein werden. Die Finanzierung der Pflegefachassistentenausbildung erfolgt in Rückgriff auf die bewährten sektorenübergreifenden Verfahren entsprechend des Pflegeberufegesetzes über die Einrichtung von Ausbildungsfonds auf Landesebene.

Der DPR weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die hierdurch entstehenden Mehrkosten nach wie vor von den Kostenträgern des Ausbildungsfonds aufgebracht werden und als Ausbildungskostenumlage im Rahmen der Eigenanteile von pflegebedürftigen Personen getragen werden. Für die enorm angestiegenen und weiter steigenden Eigenanteile muss dringend eine Lösung gefunden werden.

Teil 3 Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Abschnitt 1 Außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes erworbene Berufsabschlüsse

§§ 25 bis 27

Neben der Verbesserung von Rahmenbedingungen der pflegerischen Versorgung durch modernisierte Ausbildungsstrukturen, gilt es, die Möglichkeiten der Berufsausübung ausländischer Pflegepersonen zu stärken. Ein Schlüssel dafür ist die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Anerkennungsverfahren von ausländischen Berufsabschlüssen.

Der DPR begrüßt grundsätzlich die Entlastung der antragstellenden Personen durch Verzicht auf eine Gleichwertigkeitsprüfung zugunsten eines Anpassungslehrgangs und die Berücksichtigung non-formaler Kompetenzen durch ein Kompetenzfeststellungsverfahren. Im Verfahren der Prüfung auf Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes soll die zuständige

Behörde vorhandene Informationen über die Berufsqualifikationen der antragstellenden Person insbesondere in Form von Mustergutachten berücksichtigen.

Gemäß § 27 des PflFAssG kann nach Wahl der antragstellenden Person eine Anpassungsmaßnahme in Form einer Kenntnisprüfung oder eines achtzehnmonatigen Anpassungslehrgangs mit abschließender Prüfung durchgeführt werden. Die Kenntnisprüfung erstreckt sich dabei auf die Inhalte der staatlichen Abschlussprüfung. Der DPR kritisiert die hier vorgenommene Einengung der Anerkennungsanforderungen, vor allem das Fehlen einer Prüfung der Sprachkompetenz, die bei der pflegerischen Versorgung die Basis des Handelns darstellen (Abt-Zegelin & Schnell, 2005; GQMG, 2020). Mangelnde Sprachkenntnisse erhöhen nicht nur das gesundheitliche Versorgungsrisiko um ein Vielfaches und erschweren eine angemessene Integration in die jeweiligen Versorgungsteams, sondern sind gleichzeitig auch der Hauptgrund für zugewanderte Menschen, ihre Ausbildung abzubrechen (European Union Agency for Fundamental Rights, 2023).

Daher empfiehlt der DPR im Rahmen der Anerkennungsverfahren die Prüfung der Sprachkompetenz sowie die Präzisierung des Sprachniveaus auf B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Die nachfolgend in Teil 3, Abschnitt 2, § 30 des Gesetzesentwurfes zur Meldung der Dienstleistungserbringung geforderte Erklärung über die Kenntnisse der deutschen Sprache, die zur Ausübung des Berufs erforderlich sind, beurteilt der DPR in diesem Zusammenhang als nicht ausreichend. Offen bleibt hier, in welchem Umfang die Sprachkenntnisse vorzuliegen haben, um zur Ausübung des Berufs in ausreichendem Maße beizutragen.

Zudem befürwortet der DPR den in § 27 des zur Entlastung der antragstellenden Personen vorgesehenen Verzicht auf eine Gleichwertigkeitsprüfung zugunsten eines Kompetenzfeststellungsverfahrens, wodurch eine binnendifferenzierte Gewichtung der Inhalte eines sich anschließenden, mindestens zwölf Monate andauernden, Anpassungslehrgangs unterstützt werden kann. Der Verzicht auf einen Anpassungslehrgang ist vor dem Hintergrund nicht vergleichbarer Anforderungen in einem anderen Mitgliedstaat nicht zielführend, da die Qualität der Gesundheitsversorgung und insbesondere die Patient:innensicherheit sowie eine angemessene Integration der ausländischen Personen unter diesen Bedingungen nicht gewährleistet werden kann. Aus den vorgenannten Gründen weist der DPR auf die Notwendigkeit des folgenden Änderungsvorschlags hin.

Änderungsvorschlag zu § 27 Absatz 1

(1) Wenn die antragstellende Person eine Berufsqualifikation vorlegt, die nicht in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem anderen gleichgestellten Staat erworben worden ist und die nicht bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem anderen gleichgestellten Staat anerkannt worden ist, so hat sie bei Feststellung wesentlicher Unterschiede folgende Maßnahme als Ausgleichsmaßnahme zu absolvieren:

1. eine Sprachprüfung, die dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entspricht

~~1.2.~~ einen **höchstens-mindestens achtzehnmonatigen** Anpassungslehrgang, der mit einer Prüfung über den Inhalt des Anpassungslehrgangs abschließt.

(2) ist zu streichen

(3) ist zu streichen

Teil 6 Anwendungs- und Übergangsvorschriften

§ 52 Übergangsvorschriften für landesrechtliche Ausbildungen, Absatz 2

Eine Übergangsregelung für vor Inkrafttreten des neuen Pflegefachassistenzgesetzes begonnene Ausbildung nach bisherigem Landesrecht ist grundsätzlich nachvollziehbar, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Dennoch dürfen diese Regelungen nicht dazu führen, dass die Umsetzung einer bundeseinheitlichen, generalistischen Pflegefachassistentenausbildung übermäßig verzögert oder gar auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben wird.

Der vorliegende Gesetzesentwurf räumt den Ländern die Möglichkeit ein, die Mindestanforderungen nach § 8, insbesondere im Hinblick auf die personelle und infrastrukturelle Ausstattung, bis zum Jahr 2035 nicht vollumfänglich umzusetzen. Der DPR weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dieser Zeitraum, um mindestens fünf Jahre zu verkürzen ist, um der Zielsetzung des Gesetzes, der Schaffung einer einheitlichen Ausbildungsstruktur, gerecht zu werden.

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des DPR die Anpassung des § 52 Absatz 2 dringend zu prüfen. Die Regelung sieht eine Verlängerung länderspezifischer Ausbildungsgänge bis Ende 2030 vor und widerspricht damit dem Anliegen, die Pflegefachassistentenausbildung zeitnah bundesweit zu harmonisieren.

Der im folgenden vorgeschlagene Absatz 2 stellt sicher, dass die Länder im Bedarfsfall weiterhin handlungsfähig bleiben, zugleich aber dem Ziel einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung nicht dauerhaft entgegengewirkt wird. Durch die zeitliche Befristung und Zweckbindung wird verhindert, dass landesrechtliche Regelungen über das notwendige Maß hinaus fortbestehen.

Änderungsvorschlag zu § 52 Absatz 2

(2) Eine Ausbildung nach landesrechtlichen Vorschriften über eine Helfer- oder Assistenz-ausbildung, die die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ (BANz AT 17.02.2016 B3) erfüllt, kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 auf Grundlage der landesrechtlichen Vorschriften in der am 31. Dezember 2026 jeweils geltenden Fassung Neubegonnen werden und bis zum 31. Dezember 2023 auf Grundlage dieser landesrechtlichen Vorschriften abgeschlossen werden, wenn das Land dies zur Sicherstellung der notwendigen Ausbildungskapazitäten durch landesrechtliche Vorschriften vorsieht. ~~das nähere Regeln die Länder~~

Ein Fortbestehen der Ausbildung nach bisherigem Landesrecht im Rahmen der genannten Übergangsregelung ist nur zulässig, sofern ein Bundesland konkret und nachvollziehbar begründet, dass andernfalls eine erhebliche Unterversorgung mit Ausbildungskapazitäten im Bereich der Pflegefachassistentenausbildung unter Einbezug der Mindestvoraussetzung und der geltenden Übergangsfristen gemäß § 8 Absatz 2 eintreten würde.

§ 54 Evaluierung

Gemäß § 54 des Referentenentwurfs ist eine Evaluierung der Ausbildung zur Pflegefachassistenz vorgesehen. Dies wird grundsätzlich begrüßt. Aus Sicht des DPR sollte im Rahmen der Evaluierung jedoch über formale Kriterien hinaus insbesondere auf qualitative Aspekte eingegangen werden. Dazu zählen die Erfahrungen der Auszubildenden und Lehrenden, die Ausbildungsabbruchsquoten, der Übergang in die Ausbildung zur Pflegefachperson sowie die Wirksamkeit der Kompetenzvermittlung im Hinblick auf die Versorgungsrealität. Die Evaluierung sollte durch eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung erfolgen. Die Einbindung der Fachkommission gemäß § 44 erscheint in diesem Zusammenhang sinnvoll.

Insbesondere ist herauszustellen, dass der vorgesehene Stichtag der Evaluation (31.12.2031) zu früh angesetzt ist, wenn Übergangsregelungen gemäß § 8 Absatz 2 und § 52 Absatz 2

voraussichtlich weit über den Zeitpunkt angesetzt sind, also keine flächendeckende Umsetzung der bundeseinheitlichen Ausbildung vorliegt. Dies kann zu Verzerrungen im Rahmen der Datengüte sowie der Vergleichbarkeit der Daten führen. Darüber hinaus ist unbedingt pflegewissenschaftliche Expertise bei der angestrebten Evaluation einzubeziehen.

Änderungsvorschlag zu § 54:

(1) Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit evaluieren ~~bis zum 31. Dezember 2031 die Wirkungen des § 10 Absatz 2 auf wissenschaftlicher Grundlage. die Umsetzung und Wirkung der Pflegefachassistentenausbildung. Die Evaluierung erfolgt auf wissenschaftlicher Grundlage unter Einbezug pflegewissenschaftlicher Expertise.~~

(2) Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit evaluieren bis zum 31. Dezember ~~2031~~ **2033 entsprechend Absatz 1** die Wirkungen des ~~§ 11 Absatz 2 auf wissenschaftlicher Grundlage~~ **§ 10 Absatz 2 und § 11 Absatz 2. Die Evaluation umfasst neben der Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben qualitative Aspekte der Ausbildung. Dazu zählen Erfahrungen der Auszubildenden und Lehrenden, Ausbildungsabbrüche, Übergänge in weiterführende Ausbildungen sowie die Mitwirkung der Pflegefachassistentinnen, Pflegefachassistenten und Pflegefachassistentenpersonen mit ihren Kompetenzen und deren Wirksamkeit auf die pflegerische Versorgungspraxis.**

(3) Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit evaluieren bis zum 31. Dezember 2029 die Wirkungen des Teils 2 Abschnitt 3 auf wissenschaftlicher Grundlage.

(4) Die Einbindung der Fachkommission gemäß § 44 ist vorzusehen.

(5) Eine vorgezogene Zwischenbewertung mit vorläufigen Erkenntnissen muss bis Ende 2030 abgeschlossen sein.

Artikel 2 Änderung des Pflegeberufgesetzes

Zu Nummer 2

Artikel 2 Nummer 2 sieht eine Änderung des Pflegeberufgesetzes in § 9 vor. Hintergrund ist die äußerst schwierige Akquise von Lehrpersonen mit einem Master- oder vergleichbarem Niveau. Daher ist derzeit gängige Praxis fachlich und pädagogisch qualifizierte Lehrpersonen für die Unterrichtstätigkeit an Ausbildungseinrichtungen auf Bachelor-Niveau als vollwertige Lehrpersonen einzusetzen. Unter der Vermeidung von Engpässen durch die nach wie vor bestehende hohe Nachfrage wird daher die Frist für die Beschäftigung von Lehrpersonal auf Masterniveau nach 2029 nunmehr um sechs Jahre auf 2035 verlängert. Der DPR lehnt diese Verlängerung mit Blick auf die Ausbildungsqualität ab. Ziel muss ein Ausbau der Qualifizierungskapazitäten sein, verbunden mit Förderleistungen für Lehrpersonen.

Quellen

Abt-Zegelin, A. & Schnell, M. W. (2005): Sprache und Pflege als Thema der Pflegewissenschaft. Huber: Bern.

BiBB–Bundesinstitut für Berufsbildung (2021). VIER SIND DIE ZUKUNFT. DIGITALISIERUNG. NACHHALTIGKEIT. RECHT. SICHERHEIT. Die modernisierten Standardberufsbildpositionen anerkannter Ausbildungsberufe.
<https://www.bibb.de/dienst/publikationen/de/17281>, letzter Zugriff am 06.07.2025

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMG). (2023). Pflege stärken: Wege zur Verbesserung der praktischen Ausbildung. <https://www.bmbf.de>, letzter Zugriff am 06.07.2025

- Bundesministerium für Gesundheit (BMG). (2021). Roadmap zur Verbesserung der Personalsituation in der Pflege und zur schrittweisen Einführung eines Personalbemessungsverfahrens für vollstationäre Pflegeeinrichtungen. URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Konzerzierte_Aktion_Pflege/Roadmap_zur_Einfuehrung_eines_Personalbemessungsverfahrens.pdf, letzter Zugriff am 06.07.2025
- Deutscher Pflegerat e.V. (2023a). Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) zur gemeinsamen Empfehlung nach §113c Absatz 4 SGB XI zur Personalmindestausstattung in vollstationären Pflegeeinrichtungen. URL: https://deutscher-pflegerat.de/download/2023-02-03_dpr_gkv_stellungnahme_umsetzung_113c_abs._1_personalanhaltswerte_20230203.pdf, letzter Zugriff am 06.07.2025
- European Union Agency for Fundamental Rights (2023): Fleeing Ukraine- Displaced People's Experiences In The EU. Ukrainian Survey 2022. URL: <https://fra.europa.eu/en/publication/2023/ukraine-survey>, letzter Zugriff am 06.07.2025
- Genz, K & von Gahlen-Hoops, W (2024): Bildungsarchitektur in der Pflege in Deutschland (BAPID). Bestandsaufnahme und Empfehlungen für die Pflegebildung von morgen. Pflege. Bildung. Wissen. transcript Verlag. Bielefeld.
- Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung e. V. (GQMG) (2020): Sprachkompetenz von ausländischen Pflegefachpersonen- eine Schlüsselqualifikation. Positionspapier Version 2.0. URL: https://www.gqmg.de/media/redaktion/Publikationen/Positionspapiere/GQMG_PP._Sprachkompetenz_von_auslaendischen_Pflegefachpersonen._2._Auflage_28.04.20.pdf, letzter Zugriff am 06.07.2025
- KMK-Kultusministerkonferenz (2023). Deutscher Qualifikationsrahmen, Liste der zugeordneten Qualifikationen.
- Köhler, J., Seifert, M., & Muths, M. (2023). Praxisanleitung in der Pflege: Qualität, Rahmenbedingungen und Herausforderungen. Pflegewissenschaft, 3(2), 134-141.

Berlin, 30.09.2025

Deutscher Pflegerat e.V. – DPR
 Alt- Moabit 91
 10559 Berlin
 Tel.: + 49 30 / 398 77 303
 E-Mail: info@deutscher-pflegerat.de
www.deutscher-pflegerat.de



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Ausschussdrucksache 21(13)9f vom 30. September 2025

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefach-
assistenzausbildung“

BT-Drucksache 21/1493

Anna Traub

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. anlässlich der Anhörung im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenten Ausbildung (BT-Drs. 21/1493) am 6. Oktober 2025

Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins (DV 20/25) vom 30. September 2025

Inhalt

1. Vorbemerkung	3
2. Allgemeine Einschätzung	3
3. Zu ausgewählten Regelungen im Einzelnen	4
3.1 §§ 5, 6 und 16 Pfl-FAssG-E – Dauer und Struktur der Ausbildung, Durchführung der praktischen Ausbildung sowie Pflichten der Träger der praktischen Ausbildung	4
3.2 §§ 11, 25 ff. Pfl-FAssG-E – Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen und Berufserfahrung und Gleichwertigkeit und Anerkennung von Ausbildungen	5
3.3 § 17 Pfl-FAssG-E – Ausbildungsvergütung	6
3.4 § 24 Pfl-FAssG-E – Finanzierung	6
3.5 §§ 50, 51, 52 Pfl-FAssG-E – Übergangsvorschriften	7

1. Vorbemerkung

Die Bundesregierung hat am 8. September 2025 einen Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung¹ als Artikelgesetz vorgelegt. Der Deutsche Verein begrüßt die zeitnahe Wiederaufnahme und zügige Implementierung des bereits in der letzten Legislaturperiode weit gediehenen Gesetzgebungsverfahrens und bedankt sich für die Gelegenheit, im Rahmen der Anhörung im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend erneut Stellung zu nehmen. Die nachfolgende Stellungnahme wurde von der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins erarbeitet und bezieht sich auf Artikel 1 des Gesetzesentwurfes (Pflegefachassistentengesetz [Pfl-FAssG]). Eine Beschlussfassung durch das Präsidium des Deutschen Vereins war aufgrund der Frist zur Stellungnahme bis zum 30. September 2025 nicht möglich. Wir behalten uns daher vor, ergänzende bzw. weitere Anmerkungen im laufenden Gesetzgebungsverfahren einzubringen.

2. Allgemeine Einschätzung

Mit einer bundeseinheitlichen Ausbildung zur Pflegefachassistentenz mit generalistischem Profil geht der vorliegende Gesetzesentwurf einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem durchlässigen Aus- und Weiterbildungssystem in der Pflege und trägt damit mittelbar zur Fachkräftesicherung in der Pflege bei. Das Anliegen der Bundesregierung, die – bisher landesrechtlich geregelten – 27 verschiedenen Ausbildungen in der Pflegehilfe und Pflegeassistentenz in eine bundeseinheitliche Ausbildung zu überführen, wird begrüßt. Die damit verbundene Schaffung eines einheitlichen Berufsbildes, einer einheitlichen Finanzierung und Vergütung trägt dem steigenden Pflegebedarf und der notwendigen Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes Rechnung und entspricht in weiten Teilen den Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung der Pflegeausbildungen aus dem Jahr 2009.² Mit der Schaffung eines bundeseinheitlichen Berufsbildes der Pflegefachassistentenz ist eine Angleichung an die generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft verbunden, die die Durchlässigkeit der Ausbildungs- und Berufswege stärkt und den Zugang zu allen Versorgungsbereichen in der Pflege eröffnet. Dies gilt auch für den Bereich der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, die durch die Vereinheitlichung wesentlich erleichtert wird.

Begrüßenswert ist aus Sicht der Geschäftsstelle außerdem die damit einhergehende Unterstützung der Umsetzung und einheitlichen Anwendbarkeit des Personalbemessungsinstruments nach § 113c SGB XI.

Die mit der Neuvorlage getroffene Entscheidung für eine 18-monatige Ausbildungsdauer bis zum Erreichen des Ausbildungsniveaus einer Pflegefachassistentenz

Ihre Ansprechpartnerin
im Deutschen Verein:
Anna Traub.

1 Als Artikelgesetz mit Artikel 1 Gesetz über den Pflegefachassistentenberuf (Pflegefachassistentengesetz – Pfl-FAssG), Artikel 2 Änderung der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung, Artikel 3 Änderung des Pflegeberufegesetzes, Artikel 4 Änderung der Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung, Artikel 5 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, Artikel 6 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch, Artikel 7 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, Artikel 8 Weitere Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, Artikel 9 Änderung des Berufsbildungsgesetzes, Artikel 10 Änderung des DRK-Gesetzes, Artikel 11 Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes, Artikel 12 Inkrafttreten.

2 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung der Pflegeausbildung, NDV 2009, 162–172.

ermöglicht sachgerecht den im Gesetzentwurf vorgesehenen Kompetenzzuwachs und entspricht den Empfehlungen der Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins im Rahmen des in der letzten Legislaturperiode nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsprozesses.³

Die Entscheidung für die Berufsbezeichnung „Pflegefachassistenz“, die sich einheitlich auch im Begriff der Pflegefachassistentenausbildung wiederfindet, verdeutlicht den vorgesehenen Kompetenzzuwachs in geeigneter Weise und entspricht ebenfalls der Position des Deutschen Vereins.⁴

Neben der Ausbildung in Vollzeit sieht der Entwurf eines neuen Pflegefachassistentengesetzes auch die Möglichkeit der Teilzeitausbildung vor. Vor dem Hintergrund der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und auch angesichts eines Frauenanteils von derzeit immer noch 74 % aller Personen, die sich in der generalistischen Pflegeausbildung befinden⁵, wird diese Teilzeitoption von der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins ausdrücklich begrüßt.

Hervorzuheben ist auch die Wichtigkeit der Schutzvorschriften im Rahmen der praktischen Ausbildung zur Gewährleistung der Qualität (siehe § 6 Abs. 3 Pfl-FAssG-E).

Letztendlich ist anzumerken, dass der Entwurf und seine Implikationen erst abschließend beurteilt werden können, sobald die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfverordnungen veröffentlicht sind.

Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins nimmt im Folgenden zu ausgewählten Regelungen des Artikel 1 des Gesetzentwurfes (Pflegefachassistentengesetz (Pfl-FAssG)) Stellung.

3. Zu ausgewählten Regelungen im Einzelnen

3.1 §§ 5, 6 und 16 Pfl-FAssG-E – Dauer und Struktur der Ausbildung, Durchführung der praktischen Ausbildung sowie Pflichten der Träger der praktischen Ausbildung

Die Dauer der Pflegefachassistentenausbildung unter der Maßgabe, einerseits den notwendigen Kompetenzzuwachs bei Pflegefachassistentenkräften angemessen zu ermöglichen und andererseits die Umsetzbarkeit in der Praxis sowie niedrigschwellige Berufszugänge weiterhin zu gewährleisten, war im Zuge der Verbände-beteiligung zum Gesetzgebungsverfahren in der letzten Legislaturperiode eine kontrovers diskutierte Frage. Die Entscheidung für eine 18-monatige Ausbildungsdauer entspricht den Empfehlungen der Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins.⁶ Mit Blick auf die Komplexität des zukünftigen Aufgabenschnitts bei Anwendung des Personalbemessungsinstruments nach § 113c SGB XI

3 Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Bundesministeriums für Gesundheit eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegeassistentenausbildung [alternativ: Pflegehilfesausbildung] (Pflegeassistenteneinführungsgesetz – PflAssEinfG [alternativ: Pflegehilfeeinführungsgesetz – PflHilfeEinfG]) (DV 16/24) vom 31. Juli 2024, S. 4.

4 Ebenda, S. 3.

5 Vgl. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/03/PD25_099_212.html (letzter Abruf: 3. Juli 2025).

6 Siehe Fußn. 3

stellt die 18-monatige Ausbildungsdauer im Spektrum der vertretenen Positionen einen sachgerechten Kompromiss dar.

Die Struktur der Ausbildung sieht theoretischen und praktischen Unterricht sowie eine praktische Ausbildung vor. Laut § 5 Pfl-FAssG überwiegt dabei der Anteil der praktischen Ausbildung. Dies wird seitens der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins begrüßt. Damit werden der Erwerb praktischer Kenntnisse und die Praxisnähe der Ausbildung gesichert und der anschließende Berufseinstieg erleichtert.

§ 6 Abs. 3 Pfl-FAssG-E definiert die Geeignetheit von Einrichtungen zur Durchführung der praktischen Ausbildung und bestimmt, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen Auszubildenden und Fachkräften sicherzustellen ist. Im Übrigen wird hinsichtlich der Geeignetheit auf die jeweiligen landesrechtlichen Regelungen verwiesen. Diese für die Qualität der Ausbildung zentrale Regelung bedarf nach Ansicht der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins allerdings der Spezifizierung, um bundeseinheitliche Mindeststandards zu gewährleisten.

Entscheidend für das Gelingen einer qualitätsgesicherten praktischen Ausbildung ist nach Ansicht der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins weiterhin die Umsetzung der Vorgaben in der Schutzvorschrift des § 16 Pfl-FAssG-E. Die Gewährleistung eines mindestens 10-prozentigen Anteils an Praxisanleitung während der praktischen Ausbildungszeit, das Vorhalten kostenloser Ausbildungsmittel und ein verlässliches Unterstützungssystem, das den Auszubildenden gute Übergänge zwischen dem praktischen und theoretischen Teil der Ausbildung ermöglicht, ist dafür erforderlich.

Um Missverständnisse und Konflikte zwischen auszubildenden Personen und dem Träger der praktischen Ausbildung beizulegen, ist im Gesetzentwurf die Möglichkeit der Einrichtung einer Ombudsstelle durch Landesrecht vorgesehen. Dies wird seitens der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins begrüßt. Die gesetzliche Verankerung einer Vertretung der Auszubildenden oder einer Ombudsperson hatte der Deutsche Verein bereits in seiner Stellungnahme zum Entwurf des Pflegeberufgesetzes gefordert.⁷ Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins empfiehlt, Ombudsstellen in allen Ländern einzurichten.

3.2 §§ 11, 25 ff. Pfl-FAssG-E – Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen und Berufserfahrung und Gleichwertigkeit und Anerkennung von Ausbildungen

Der Entwurf des Pflegefachassistenzgesetzes sieht in § 11 vor, dass Qualifikationen, Kompetenzen und Berufserfahrungen im pflegenahen Bereich auf die Dauer der Ausbildung zur Pflegefachassistenz angerechnet werden und diese bis zu einem Drittel verkürzen können. Die zuständige Behörde soll darüber auf Antrag entscheiden (§ 11 Pfl-FAssG-E). Außerdem erfolgt bei Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Abschlüsse auf Antrag die berufliche Anerkennung (§ 25 Pfl-FAssG-E). Mithilfe dieser Anrechnungs- und Anerkennungsregelungen, die neben gleichwertigen Ausbildungen und Abschlüssen auch praktische berufliche oder

⁷ Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz) [/empfehlungen-stellungnahmen/detail/stellungnahme-des-deutschen-vereins-zum-gesetzentwurf-der-bundesregierung-fuer-ein-gesetz-zur-reform-der-pflegeberufe-pflegeberufsgesetz/](#)

durch lebenslanges Lernen erworbene Erfahrungen berücksichtigen, kann sowohl bundesweit, als auch international eine höhere Durchlässigkeit erreicht werden. Ebenso erleichtert dies den Wechsel von der Pflegefachkraftausbildung in die Pflegefachassistentenausbildung und andersherum, was die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins begrüßt. So bleiben Auszubildende der Pflege erhalten.

Bereits im Jahr 2009 hat sich der Deutsche Verein in seinen Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Pflegeausbildung für sinnvolle Anrechnungs- und Anerkennungsmöglichkeiten eingesetzt, um die Attraktivität der Ausbildung ohne Qualitätsverluste zu steigern und damit zugleich zur Fachkräftesicherung im Pflegebereich beizutragen.⁸ Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins begrüßt insoweit den im Gesetzentwurf gewählten Ansatz.

3.3 § 17 Pfl-FAssG-E – Ausbildungsvergütung

Für die Ausbildung zur Pflegefachassistentin sieht der Entwurf eine angemessene Ausbildungsvergütung durch den Träger der praktischen Ausbildung für die gesamte Ausbildungszeit vor (§ 17 Pfl-FAssG-E) und beinhaltet zugleich einen ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausschluss der Zahlung eines Schulgeldes oder einer Entschädigungszahlung für die praktische Ausbildung. Damit soll verhindert werden, dass der Zweck der finanziellen Unterstützung und die damit beabsichtigte Steigerung der Attraktivität der Ausbildung unterlaufen werden (§ 24 Pfl-FAssG-E). Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins befürwortet diese einheitliche Regelung der Ausbildungsvergütung insbesondere mit Blick auf die Erreichung des gesetzlichen Ziels, ein größeres Interesse an der Pflegefachassistentenausbildung zu wecken sowie zur Sicherstellung der Ausbildungsziele.

3.4 § 24 Pfl-FAssG-E – Finanzierung

Der Entwurf sieht vor, zur Finanzierung der Ausbildung den mit dem Pflegeberufegesetz geschaffenen Ausgleichsfonds zu nutzen, in den Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, die jeweiligen Länder, die soziale Pflegeversicherung sowie die private Pflege-Pflichtversicherung einzahlen. Grundsätzlich begrüßt die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins die Etablierung einer bundeseinheitlichen Regelfinanzierung der Pflegefachassistentenausbildung analog zur generalistischen Pflegeausbildung. Die in § 53 Abs. 3 Pfl-FAssG-E vorgesehene Evaluierung der Wirkung des Teils 2 Abschnitt 3 (Finanzierung) ist in diesem Zusammenhang zu begrüßen. Dabei sollten nach Ansicht der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins die Evaluationsergebnisse gemäß § 68 Abs. 4 PflBG berücksichtigt werden.

Bezüglich der Nutzung des Ausgleichsfonds gibt die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins wie bereits in der Stellungnahme zum Referentenentwurf des Pflegeberufegesetzes zu bedenken, dass es rechtssystematisch fragwürdig ist, die Soziale Pflegeversicherung, als lediglich Teilversicherung, in die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege einzubeziehen und damit die Kosten der Ausbildung insbesondere den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen oder den

⁸ Siehe Fußn. 1

Kommunen aufzuerlegen. So sind die Eigenanteile in der Pflege jüngst abermals gestiegen. Eine weitere Kostensteigerung durch die Finanzierung der Pflegefachassistentenausbildung ist zu erwarten.

Der Deutsche Verein fordert daher entsprechend seiner Empfehlungen zur Weiterentwicklung und nachhaltigen Finanzierung der Pflege⁹ den Gesetzgeber dringend auf, grundlegende Regelungen zu treffen, um die pflegebedingten Eigenanteile effektiv und dauerhaft zu begrenzen. Die Bund-Länder-Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen einer grundsätzlichen Pflegereform sollte daher wie im Koalitionsvertrag vorgesehen¹⁰ bis Ende 2025 Vorschläge zur Verortung versicherungsfremder Leistungen wie der Ausbildungsumlage und zur Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile vorlegen. Diese sollten aus Sicht der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins vom Gesetzgeber zügig umgesetzt werden.

3.5 §§ 50, 51, 52 Pfl-FAssG-E – Übergangsvorschriften

Bereits in der Vergangenheit hat der Deutsche Verein lange Übergangsfristen im Falle der Weiterentwicklung der Pflegeausbildung gefordert, um einen Einbruch der Auszubildendenzahlen und den Verlust schulischer Ausbildungskapazitäten zu vermeiden. Der vorliegende Gesetzentwurf tritt mit dem Ziel an, durch die Schaffung eines einheitlichen beruflichen Profils einer Pflegefachassistenz die Attraktivität des Berufs zu steigern, mehr Interesse an der Ausbildung zu wecken und letztlich ausreichend Personal im Pflegebereich sicherzustellen. Die neue Ausbildung soll am 1. Januar 2027 beginnen. Es ist vorgesehen, dass eine vor Ablauf des 31. Dezember 2026 nach bisherigem Landesrecht begonnene Ausbildung im Rahmen einer dreijährigen Übergangsfrist noch bis 31. Dezember 2029 abgeschlossen werden kann (§ 52 Pfl-FAssG-E). Die grundsätzliche Weitergeltung der staatlichen Anerkennung bestehender Pflegeschulen und deren damit verbundener Bestandsschutz werden begrüßt (§ 51 Pfl-FAssG-E). Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang auch die in § 50 Pfl-FAssG-E normierte Fortgeltung der Berufsbezeichnung, um bereits ausgebildete Pflegekräfte nicht zu verlieren.

⁹ Positionen und Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung und nachhaltigen Finanzierung der Pflege, NDV 2021, 31 ff.

¹⁰ Verantwortung für Deutschland, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 21. Legislaturperiode, S. 109.

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. – seit über 140 Jahren das Forum des Sozialen

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. ist das gemeinsame Forum von Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen sowie ihrer Einrichtungen, der Bundesländer, der privatgewerblichen sozialen Dienste und der Wissenschaft für alle Bereiche der Sozialen Arbeit, der Sozialpolitik und des Sozialrechts. Er begleitet und gestaltet durch seine Expertise und Erfahrung die Entwicklungen u.a. der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik, der Sozial- und Altenhilfe, der Grundversicherungssysteme, der Pflege und Rehabilitation sowie der Migration und Integration.

Impressum

Herausgeber:

Deutscher Verein für öffentliche und private
Fürsorge e.V.

Dr. Verena Staats, Vorständin

Michaelkirchstr. 17/18

10179 Berlin

www.deutscher-verein.de

E-Mail info@deutscher-verein.de

Gefördert vom:



Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Ausschussdrucksache 21(13)9g-neu vom 1. Oktober 2025

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung“

BT-Drucksache 21/1493

Antonia Walch

Bundesverband Deutscher Privatkliniken e. V. (BDPK)

01.10.2025

**Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein
Gesetz über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung
(Pflegefachassistenzgesetz – PflFAssG)**

Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK) unterstützt das Ziel, die Pflegefachassistentenausbildung bundesweit zu vereinheitlichen. Dabei ist aus unserer Sicht ein niederschwelliger Zugang zu den Pflegeberufen, verbunden mit der Möglichkeit einer anschließenden, aufbauenden Qualifizierung essenziell, um die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern und möglichst viele Auszubildende zu gewinnen.

Der Bedarf an Pflegekräften steigt kontinuierlich. Der daraus resultierende Pflegekräftemangel betrifft inzwischen sämtliche Indikationen und Fachbereiche, auch die medizinische Rehabilitation. Gleichzeitig nimmt die Zahl pflegebedürftiger Menschen stetig zu. Um dieser wachsenden Nachfrage an Pflegekräften gerecht zu werden, ist es dringend erforderlich, zusätzliche und niedrighschwellige Ausbildungsangebote zu schaffen und mehr Ausbildungsplätze bereitzustellen, insbesondere auch im ländlichen Raum.

Im Zuge der voranschreitenden Ambulantisierung ist davon auszugehen, dass die Verweildauer der Patient:innen in Akutkliniken weiter verkürzt wird. Künftig werden Patient:innen früher in die medizinische Rehabilitation oder in die ambulante Versorgung entlassen. Längere Beobachtungen von Krankheitsverläufen – etwa im Hinblick auf Wundheilung, funktionelle Genesung oder psychische Reaktionen auf Krankheit – werden dadurch u.a. überwiegend in der medizinischen Rehabilitation erfolgen. Damit werden diese Einrichtungen zu einem wichtigen Lernort für den Erwerb umfassender pflegerischer Kompetenzen.

Medizinische Rehabilitationseinrichtungen verfügen über besondere fachliche Qualifikationen und bieten Auszubildenden einzigartige Lernmöglichkeiten. Sie ermöglichen eine kontinuierliche, patientenzentrierte Betreuung über einen längeren Zeitraum. Hier können Auszubildende essenzielle pflegerische Kompetenzen erwerben, wie die Beobachtung von Krankheitsverläufen, die Begleitung von Rehabilitationsprozessen sowie die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit chronischen und komplexen Erkrankungen.

Aus Sicht des BDPK ist es daher dringend geboten, medizinische Rehabilitationseinrichtungen als Träger der praktischen Ausbildung sowohl für die Pflegefachausbildung als auch für die Pflegefachassistentenausbildung zuzulassen. Durch die Einbindung zusätzlicher Ausbildungsträger kann nicht nur die Zahl der dringend benötigten Pflegekräfte erhöht, sondern auch die Attraktivität des Pflegeberufs insgesamt gesteigert werden. Darüber hinaus wird durch die verstärkte Einbindung von medizinischen Rehabilitationseinrichtungen, die häufig im ländlichen Raum angesiedelt sind, insbesondere Menschen auf dem Land vermehrt die Möglichkeit einer Ausbildung eröffnet. Schlussendlich muss auch durch die Krankenhausreform und die damit verbundene Konzentration von Krankenhäusern mit einem Wegfall von Ausbildungsplätzen in Krankenhäusern gerade in ländlichen Gebieten gerechnet werden. Die medizinischen Rehabilitationseinrichtungen sind bereit und in der Lage, einen substantiellen Beitrag zur Reduzierung des Pflegekräftemangels zu leisten und sich aktiv in der Ausbildung einzubringen – weit über die bislang vorgesehenen 160 Stunden im Rahmen der „weiteren Einsätze“ hinaus.

Stellungnahme zur Einführung einer Pflegefachassistentenausbildung

Die Krankenhäuser, medizinischen Rehabilitationseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen brauchen dringend qualifiziertes Pflegepersonal, sowohl examinierte Pflegefachkräfte als auch unterstützende Pflegefachassistentenkräfte.

Daher ist auch die derzeitige Anrechnungsquote für Pflegehilfskräfte im Rahmen der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) sowie der Pflegepersonalbemessungsverordnung (PPBV) und deren Refinanzierung entsprechend anzupassen. Gleiches gilt für die Personalvorgaben der Deutschen Rentenversicherung als auch der Gesetzlichen Krankenversicherung im Bereich der medizinischen Rehabilitationseinrichtungen.

Darüber hinaus sind die Personalschlüssel in vollstationären Pflegeeinrichtungen, beispielsweise gemäß § 113c SGB XI, entsprechend zu überarbeiten. Bei der Festlegung der Qualifikationsanforderungen im Rahmen der Personalausstattung ist insgesamt eine flexible Ausgestaltung zu gewährleisten.

Stellungnahme zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs

- **Zu Artikel 1 § 4 Absatz 3 Punkt 2 PflFAssG**

Beabsichtigte Regelung:

§ 4 Absatz 3 Punkt 2 regelt die Übertragung bzw. Weiterübertragung von geeigneten Maßnahmen durch die Ärztin oder den Arzt bzw. durch das Pflegefachpersonal.

Stellungnahme:

Gemäß § 28 Abs. 1 SGB V, Arbeitsvertrag sowie nach der Delegations-Vereinbarung kann der Arzt oder die Ärztin gemäß den Grundsätzen der Delegation, delegierte Aufgaben nur an ausreichend qualifizierte Mitarbeitende übertragen. Dabei ist die Ärztin oder der Arzt bei jeder Delegation ärztlicher Maßnahmen verpflichtet, sich von der Qualifikation der delegierten Person selbst zu überzeugen. Hierbei trägt die Ärztin oder der Arzt stets die Delegationsverantwortung und die Durchführungsverantwortung liegt beim ausführenden Mitarbeitenden. Nach unserer Auffassung kann infolgedessen nur eine direkte Delegation erfolgen und keine Weiterübertragung der ärztlichen Delegation über eine Pflegefachperson an eine Pflegefachassistenz.

Vorschlag:

§ 4 Absatz 3 Punkt 2 wird wie folgt geändert:

1. ärztlich angeordnete, zur Übertragung geeignete Maßnahmen nach Übertragung durch die Ärztin oder den Arzt ~~oder nach Weiterübertragung durch die Pflegefachperson eigenständig durchzuführen,~~
- **Zu Artikel 1 § 6 PflFAssG – Durchführung der praktischen Ausbildung**

Beabsichtigte Regelung:

In § 6 wird geregelt, in welchen Einrichtungen die Pflichteinsätze durchgeführt werden dürfen. Rehabilitationseinrichtungen sind nicht benannt, obwohl sie grundsätzlich zur Pflegefachausbildung geeignet sind.

Stellungnahme:

Der Bedarf an Pflegekräften steigt jedes Jahr. Laut dem Statistische Bundesamt (Destatis) könnte sich die Versorgungslücke im Pflegebereich in Deutschland bis zum Jahr 2049 auf 280.000 bzw. 690.000 Fachkräfte belaufen¹. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wird sich bis 2055 auf 6,8 Millionen erhöhen². Der Pflegekräftemangel betrifft auch alle Indikationen/Fachbereiche in der medizinischen Rehabilitation. Durch die Aufnahme der Rehabilitationseinrichtungen als Träger der praktischen Ausbildung können mehr Pflegekräfte ausgebildet werden und die Rehabilitationseinrichtungen erhalten die Möglichkeit, Pflegekräfte zu binden.

¹ [Bis 2049 werden voraussichtlich mindestens 280 000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt - Statistisches Bundesamt](#)

² [Pflegevorausberechnung: 1,8 Millionen mehr Pflegebedürftige bis zum Jahr 2055 zu erwarten - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](#)

Aufgrund des demografischen Wandels spielt die Pflege im Rahmen der Rehabilitationsmaßnahmen eine immer größere Rolle. In den Rehabilitationseinrichtungen arbeiten 21.000 Pflegevollzeitkräfte. Rehabilitationseinrichtungen sind als praktischer Ausbildungsort sehr gut geeignet, da die Pflegeprozesse am Patienten über einen längeren Zeitraum evaluiert werden können und die Reha-Pflege sehr gut planbar ist. Die Einrichtungen sind in der Lage einen Großteil der Ausbildungsinhalte in ihren Einrichtungen zu vermitteln. Für die übrigen Inhalte müssen sie – wie die anderen Ausbildungsträger auch – Kooperationen organisieren. Die Einrichtungen können sicherstellen, dass der überwiegende Teil der Stunden der Ausbildung beim Träger durchgeführt werden können. Die Einrichtungen sind auch bereit, sich an den Ausbildungskosten zu beteiligen.

Vorschlag:

§ 6 Absatz 1 PflAssG wird wie folgt ergänzt:

4. zur Versorgung nach §§ 111, 111a, 111c SGB V, § 15 SGB VI i.V.m. § 38 SGB IX und § 34 SGB VII zugelassene medizinische Rehabilitationseinrichtungen.“

• **Zu Artikel 1 § 10 PflAssG – Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung**

Beabsichtigte Regelung:

Voraussetzung für die Pflegefachassistentenausbildung soll der Hauptschulabschluss oder ein anderer gleichwertiger Schulabschluss sein oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Im Falle der Pflegefachassistentenausbildung soll der Zugang zur Ausbildung auch gewährt werden, wenn eine positive und sachlich begründete Prognose der Pflegeschule vorliegt, dass die Ausbildung erfolgreich absolviert und die staatliche Abschlussprüfung bestanden werden kann.

Stellungnahme:

Aus unserer Sicht sollte der Zugang zur Pflegefachassistentenausbildung so niederschwellig wie möglich sein. Insofern begrüßen wir die abweichende Regelung bei einer positiv und sachlich begründeten Prognose der Pflegeschule, dass die auszubildende Person die Ausbildung erfolgreich absolviert und die staatliche Abschlussprüfung bestanden werden kann, ermöglicht wird. Ergänzen möchten wir hier, dass neben der Pflegeschule auch der Träger der Praktischen Ausbildung eine positive und sachlich begründete Prognose vorlegen können sollte.

Vorschlag:

(2) Abweichend von Absatz 1 wird der Zugang zur Ausbildung gewährt, wenn eine positive und sachlich begründete Prognose der Pflegeschule **oder des Trägers der Praktischen**

Ausbildung vorliegen, dass die Ausbildung von der auszubildenden Person erfolgreich absolviert und die staatliche Abschlussprüfung bestanden werden kann.

- **Zu Artikel 1 § 25 Gleichwertigkeit und Anerkennung von Ausbildungen**

Der BDPK begrüßt die im Gesetzesentwurf vorgesehene Festlegung der grundlegenden Schritte zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Allerdings bedarf es aus unserer Sicht zusätzlich bundesweit einheitlicher Standards bei der Prüfung der Gleichwertigkeit sowie klarer Festlegungen zur maximalen Dauer der Anerkennungsverfahren, um langwierige Verfahren zu vermeiden und die Planbarkeit für Arbeitgeber wie auch Fachkräfte zu verbessern.

- **Zu Artikel 1 § 26 Eignungsprüfung oder Anpassungslehrgang**

Auch im Hinblick auf die vorgesehenen Eignungsprüfungen oder Anpassungslehrgänge sind aus Sicht des BDPK bundesweit einheitliche Prüfungsstandards erforderlich. Dies gilt sowohl für die Inhalte als auch für die Bewertungsmaßstäbe, um sicherzustellen, dass die Chancen auf das Bestehen der Prüfungen in allen Bundesländern gleich sind. Ein solcher Schritt würde nicht nur Transparenz und Verlässlichkeit für die Prüflinge schaffen, sondern gleichermaßen die Qualitätssicherung und den Patientenschutz stärken.

Vorschlag:

- (1) Die antragsstellende Person hat als Ausgleichsmaßnahme eine **bundeseinheitliche standardisierte** Eignungsprüfung, die sich auf die festgestellten und wesentlichen Unterschiede erstreckt, oder einen höchstens achtzehnmonatigen **bundeseinheitlich standardisierten** Anpassungslehrgang zu absolvieren, wenn (...)

- **Zu Artikel 1 § 27 Kenntnisprüfung oder Anpassungslehrgang**

Besonders für Fachkräfte aus Drittstaaten, für die künftig die Kenntnisprüfung den Regelfall darstellen soll, ist eine bundesweit einheitliche Ausgestaltung der Prüfungen zwingend erforderlich. Darüber hinaus sollte in diesem Zusammenhang eine Bundesdatenbank mit bereits geprüften und anerkannten Berufsabschlüssen eingerichtet werden. Eine solche Datenbank würde insbesondere bei Anträgen aus Drittstaaten die Verfahren erheblich beschleunigen, da bereits erfolgte Anerkennungen bundesweit transparent zugänglich wären. Sie würde Doppelprüfungen vermeiden, die Barrieren für ausländische Fachkräfte reduzieren und die Planungssicherheit für inländische Arbeitgeber erhöhen. Damit könnte nicht nur die Integration internationaler Fachkräfte verbessert, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der pflegerischen Versorgung geleistet werden.

- **Zu Artikel 3 - Änderung des Pflegeberufgesetzes**

Wie in der Einleitung erörtert, ist aus unserer Sicht eine Gesetzesänderung schnellstmöglich umzusetzen, denn durch die Aufnahme der Rehabilitationseinrichtungen als Träger der praktischen Ausbildung können mehr Pflegefach- und Pflegefachassistentenpersonen ausgebildet werden und die Rehabilitationseinrichtungen erhalten die Möglichkeit, Pflegekräfte zu binden. Siehe hierzu die Stellungnahme zu Artikel 1 § 6 PflFAssG.

Vorschlag:

§ 7 Absatz 1 Pflegeberufgesetz wird wie folgt ergänzt:

4. zur Versorgung nach §§ 111, 111a, 111c SGB V, § 15 SGB VI i.V.m. § 38 SGB IX und § 34 SGB VII zugelassene medizinische Rehabilitationseinrichtungen.“

§ 3 Abs. 2 PflAPrV wird wie folgt ergänzt:

„(2) Die praktische Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung soll mindestens 1 300 Stunden umfassen. Ein Pflichteinsatz nach § 7 Absatz 1 des Pflegeberufgesetzes und der Orientierungseinsatz sind beim Träger der praktischen Ausbildung durchzuführen. Ist eine medizinische Rehabilitationseinrichtung Träger der praktischen Ausbildung, können die Pflichteinsätze aufgeteilt werden; insgesamt sollen 1300 Stunden beim Träger durchgeführt werden. Der Vertiefungseinsatz soll beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt werden. Er ist in dem für den Vertiefungseinsatz gewählten Versorgungsbereich gemäß dem Ausbildungsvertrag durchzuführen.“

Weitere Folgeanpassungen in der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) durch die entsprechende Ergänzung der Rehabilitationseinrichtung als Träger praktischer Ausbildung notwendig.

Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. (BDPK) vertritt seit über 70 Jahren die Interessen von mehr als 1.300 Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken in privater Trägerschaft. Als deutschlandweit agierender Spitzenverband setzt er sich für eine qualitativ hochwertige, innovative und wirtschaftliche Patientenversorgung in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken ein.

Fakten zur Pflegeausbildung in medizinischen Reha-Einrichtungen

Ausgangslage:

- Der Bedarf an Pflegekräften steigt jedes Jahr weiter an:
Aktuelle Hochrechnungen zeigen, dass in zehn Jahren bereits 90.000 Pflegekräfte fehlen werden, bis zum Jahr 2049 könnte sich diese Zahl auf 280.000 verdreifachen.¹
- Im Jahr 2023 waren 21.000 Pflegevollkräfte in rund 1.000 Reha-Einrichtungen beschäftigt
- Knapp 1,5 Millionen Patient:innen werden pro Jahr in Reha-Einrichtungen versorgt, wodurch Frühverrentungen und Pflegebedürftigkeit vermieden oder hinausgezögert wird
- Reha-Einrichtungen dürfen derzeit keine Pflegekräfte ausbilden
- Pflegeausbildung in Reha-Einrichtungen kann derzeit nur im Rahmen des weiteren Einsatzes mit 80 (demnächst 160) Stunden stattfinden (Wahlstation)
- Reha-Einrichtungen brauchen Pflegekräfte – sie nehmen Patient:innen unmittelbar nach Krankenhausaufenthalt auf und behandeln teils schwerkranke Menschen
- Reha-Einrichtungen möchten zur Reduzierung des Pflegekräftemangels beitragen!
- Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Deutscher Pflegerat, Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe und der Berufsverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe sowie die AOK sprechen sich für Reha-Einrichtungen als zusätzlichen Ausbildungsträger aus

Lösungsvorschlag:

Reha-Einrichtungen werden als Träger der Praktischen Ausbildung sowohl für die Pflegefachausbildung als auch für die Pflegefachassistentenausbildung zugelassen.

Sind Reha-Einrichtungen in der Lage die Inhalte der Pflegeausbildung zu vermitteln?

Ja! Reha-Einrichtungen sind sehr gut für die Pflegeausbildung geeignet, da Pflegeprozesse in der Reha über einen längeren Zeitraum evaluiert werden können und die Reha-Pflege sehr gut planbar ist. Pflegeausbildung in der medizinischen Reha ermöglicht dadurch u. a.:

- das Erlernen der Erhebung umfangreicher ICF-orientierter Pflegeanamnesen
- die Formulierung von Pflegediagnosen
- die Durchführung von Pflegevisiten
- die Anwendung von Assessmentinstrumenten sowohl zur Risikoeinschätzung als auch zur Verlaufsdokumentation

¹ Statistisches Bundesamt: Pressemeldung NR. 033 vom 24. Januar 2024, unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_033_23_12.html (abgerufen am 23.08.2024)

- die Durchführung pflegerischer Maßnahmen primär als lösungsbild- und zielorientierte Anleitung des Patienten und weniger als Kompensation verlorener Funktionen
- die Integration interdisziplinär erhobener Befunde (u. a. Berufsanamnese) in die pflegerische Versorgung
- die Hospitationen bei beteiligten Berufsgruppen (Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Neuropsychologie), die der direkten Vermittlung von Inhalten wie bspw. Hilfsmittelversorgung, Erkennen und Umgang mit Schluck- und Sprachstörungen, Hirnleistungsstörungen dienen
- die tägliche Anwendung theoretisch erworbener Inhalte zur Pflegeberatung durch die enge Einbindung der Angehörigen in den Rehabilitationsprozess.
- das Erlernen des im Pflegeberufegesetz (§ 5) benannten Ausbildungszieles ist nur in Reha-Einrichtungen möglich:
 - Erhaltung, Wiederherstellung, Förderung, Aktivierung und Stabilisierung individueller Fähigkeiten der zu pflegenden Menschen insbesondere im Rahmen von Rehabilitationskonzepten sowie die Pflege und Betreuung bei Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten
- Sofern nicht alle Inhalte vermittelt werden können, sind Kooperationen zur Abdeckung aller zu erlernenden curricularen Kompetenzen möglich; so wie es auch bei anderen Ausbildungsträgern erforderlich ist (insbesondere bei ambulanten Pflegeeinrichtungen).

Der Schwerpunkt der Ausbildung einschließlich einer der drei großen Pflichteinsätze (allg. stat. Akutpflege, allg. stat. Langzeitpflege oder allg. ambul. Akut- und Langzeitpflege) muss beim Träger der praktischen Ausbildung erfolgen.

Wie können Rehabilitationseinrichtungen in die vorgesehene praktische Ausbildung integriert werden und diese Maßgabe erfüllen?

- Die Rehabilitationseinrichtungen können fast alle Kompetenzen der Ausbildung vermitteln, so dass auch in diesem Bereich der Schwerpunkt der Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung erfolgt.
- Die wenigen Bereiche, in welchen Rehaeinrichtungen die Möglichkeit der Kompetenzvermittlung fehlt, können über Kooperationspartner vermittelt werden, so wie es auch bei den anderen Ausbildungsträgern erfolgt.
- Für die rehabilitative Pflege soll es keine eigene Pflichtstation geben
- Da die Rehabilitation nicht eindeutig einem der drei festgelegten allgemeinen Versorgungsbereiche zugeordnet werden kann, könnten die vorgeschriebenen Stunden der Pflichteinsätze bei einer stationären Rehabilitationseinrichtung anteilig auf die stationäre Akutpflege (200 Stunden) und die stationäre Langzeitpflege (200 Stunden) entfallen. Die übrigen 200 Stunden der stationären Akutpflege könnten in einem kooperierenden

Krankenhaus, die übrigen 200 Stunden der stationäre Langzeitpflege in einem kooperierenden Pflegeheim abgeleistet werden.

- Somit entfallen im ersten und zweiten Ausbildungsdrittel mindestens 800 Stunden auf die Rehabilitationseinrichtung (s. Vorschlag am Ende).
- Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung müsste für die Reha-Einrichtungen entsprechend angepasst werden; s.u.: Vorschlag zu § 3 Abs. 2 PflAPrV

Welche Vorteile ergeben sich, wenn Reha-Einrichtungen Pflegeausbildungen durchführen?

- Es werden mehr Pflegefachkräfte ausgebildet als bisher, da zusätzliche Träger Auszubildende rekrutieren
- Reha-Einrichtungen hätten weniger Bedarf, Pflegefachkräfte am Arbeitsmarkt zu akquirieren und bringen zusätzliche Pflegekräfte in den Arbeitsmarkt
- Durch die Krankenhausreform und die damit verbundene Konzentration von Krankenhäusern ist auch ein Wegfall von Ausbildungsplätzen in Krankenhäusern gerade in ländlichen Gebieten verbunden. Da Rehabilitationseinrichtungen häufig im ländlichen Raum angesiedelt sind, eröffnen sie insbesondere Menschen auf dem Land vermehrt die Möglichkeit einer Ausbildung.
- Sektorenübergreifende Versorgung muss sichergestellt werden – fällt die Reha weg, weil nicht genug Pflegekräfte eingestellt werden können, besteht die Gefahr, dass mehr Menschen pflegebedürftig bzw. erwerbsunfähig werden
- Reha-Einrichtungen erhalten die Chance, dringend benötigte Pflegefachkräfte zu binden

Gesetzlicher Lösungsvorschlag

§ 7 Absatz 1 Pflegeberufegesetz wird wie folgt ergänzt:

4. zur Versorgung nach §§ 111, 111a, 111c SGB V, § 15 SGB VI i.V.m. § 38 SGB IX und § 34 SGB VII zugelassene medizinische Rehabilitationseinrichtungen.“

§ 6 Absatz 1 PflAssG wird wie folgt ergänzt:

4. zur Versorgung nach §§ 111, 111a, 111c SGB V, § 15 SGB VI i.V.m. § 38 SGB IX und § 34 SGB VII zugelassene medizinische Rehabilitationseinrichtungen.“

§ 3 Abs. 2 PflAPrV wird wie folgt ergänzt:

„(2) Die praktische Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung soll mindestens 1 300 Stunden umfassen. Ein Pflichteinsatz nach § 7 Absatz 1 des Pflegeberufgesetzes und der Orientierungseinsatz sind beim Träger der praktischen Ausbildung durchzuführen. **Ist eine medizinische Rehabilitationseinrichtung Träger der praktischen Ausbildung, können die Pflichteinsätze aufgeteilt werden; insgesamt sollen 1300 Stunden beim Träger durchgeführt**

werden. Der Vertiefungseinsatz soll beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt werden. Er ist in dem für den Vertiefungseinsatz gewählten Versorgungsbereich gemäß dem Ausbildungsvertrag durchzuführen.“

Weitere Folgeanpassungen in der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) durch die entsprechende Ergänzung der Rehabilitationseinrichtung als Träger praktischer Ausbildung notwendig.

Anlage: Kompetenzvermittlung in Einrichtungen der Rehabilitation

Vorschlag für die Aufteilung des Pflichteinsatzes in Rehabilitationseinrichtungen:

Erstes und zweites Ausbildungsdrittel in Rehabilitationseinrichtungen				
I. Orientierungseinsatz				
	Flexibel gestaltbarer Einsatz zu Beginn der Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung			400 h
II. Pflichteinsatz in den drei allgemeinen Versorgungsbereichen				
neu	1a.	Stationäre Akutpflege	200 h	} 400 h
	1b.	Stationäre Akutpflege in Reha-Einrichtung	200 h	
neu	2a.	Stationäre Langzeitpflege in Reha-Einrichtung	200 h	} 400 h
	2b.	Stationäre Langzeitpflege	200 h	
	3.	Ambulante Akut-/Langzeitpflege	400 h	
III. Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung				
	Pädiatrische Versorgung			120 h²
Summe erstes und zweites Ausbildungsdrittel			1.720 h	
Letztes Ausbildungsdrittel				
IV. Pflichteinsatz in der psychiatrischen Versorgung				
	1.	Allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung	120 h³	
	2.	Bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Abs. 2 PflBG: nur kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung		
	3.	Bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Abs. 3 PflBG: nur gerontopsychiatrische Versorgung		
V. Vertiefungseinsatz im Bereich eines Pflichteinsatzes				
	1.	Im Bereich eines Pflichteinsatzes nach II. bis IV.1. Im Bereich des Pflichteinsatzes nach II.3. auch mit Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege	500 Std.	

² In Einrichtungen der Kinder- und Jugendrehabilitation möglich

³ In Einrichtungen der Psychiatrischen und kinder- und jugendpsychiatrischen Rehabilitation möglich



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Ausschussdrucksache 21(13)9h vom 1. Oktober 2025

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung“

BT-Drucksache 21/1493

Katharina Owczarek

Diakonie Deutschland

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.

Gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung vom 08. September 2025 (BT-Drs. 21/1493)

**Diakonie Deutschland
Evangelisches Werk für Diakonie
und Entwicklung e. V.**

Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin

Berlin, den 01. Oktober 2025

Gemeinsam nehmen die Diakonie Deutschland sowie der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) und der Deutsche Evangelische Krankenhausverband (DEKV) zum Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung Stellung (BT-Drs. 21/1493).

A. Einleitung und Zusammenfassung

Die Diakonie, der DEVAP und der DEKV begrüßen die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung und danken für das Engagement der Bundesregierung das Gesetzesvorhaben so zügig voranzutreiben. Damit werden die landesunterschiedlichen Ausgestaltungen der Ausbildung und der Berufsausbildung der Pflegefachassistenz mit einem Bundesgesetz vereinheitlicht und eine unserer langjährigen Forderungen zur Schaffung eines eigenständigen und klaren Berufsprofils für die Pflegefachassistenz als Heilberuf i. S. d. Art 74 Abs. 1 Nr. 19 GG mit der Finanzierung über den Ausbildungsfond der Länder nach dem Pflegeberufegesetz umgesetzt.

Die mit dem Gesetzesentwurf vorgelegte Ausbildung zur Pflegefachassistenz schafft durch den Kompetenzzuwachs und die Durchlässigkeit zur Fachkraftausbildung eine erstrebenswerte Erleichterung für die Praxis. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Assistenzkräfte mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sind, um die Pflegefachkräfte zu entlasten und im vorgesehenen kompetenzorientierten Personaleinsatz die vorgegebenen Aufgaben adäquat erbringen zu können. Gerade im ambulanten Bereich sind Pflegefachassistentenkräfte bei den Patient:innen allein vor Ort und müssen daher die Aufgaben autonom bewerkstelligen. Um die Patient:innen sicher und qualifiziert versorgen zu können, müssen die Kompetenzen verlässlich erlernt worden sein. Neben dem Pflegestudiumstärkungsgesetz stellt die bundeseinheitliche Pflegefachassistenzausbildung einen weiteren wichtigen Schritt dar, den Qualifikationsmix in der Pflege zu stärken. Das gelingt jedoch nur, wenn die Pflegefachassistenzausbildung für Träger der praktischen Ausbildung als auch für Pflegeschulen auskömmlich refinanziert ist. Wir befürworten daher grundsätzlich die Überführung der Finanzierung der Pflegefachassistenzausbildung in den Ausbildungsfonds des Pflegeberufgesetzes. So wird die Finanzierung bundeseinheitlich in einen stabilen und mittlerweile bewährten Finanzierungsrahmen übertragen. Gleichzeitig hat dies aber zur Folge, dass die Pflegebedürftigen durch die Mitfinanzierung der Ausbildung mit weiteren Kostensteigerungen belastet werden. Die Kostenbeteiligung der Pflegebedürftigen an den

Ausbildungskosten muss daher umgehend abgeschafft und über Steuermittel finanziert werden. Die Erfahrungen aus der Pflegefachkraftausbildung zeigen auch, dass das Verfahren der Ausbildungsfinanzierung über den Ausbildungsfonds zu bürokratisch und langwierig ist und entsprechend vereinfacht werden muss. Die Antragsbearbeitung und auch die Auszahlung von Geldern durch die zuständigen Stellen müssen deutlich beschleunigt werden.

Der Bürokratieabbau muss zügig vorangetrieben werden, so dass wir anregen, bereits in diesem Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie das Ausbildungsfinanzierungssystem aber auch die Datenerfassung, z.B. durch eine zentrale digitale Plattform entschlackt werden kann. Auch hat sich gezeigt, dass Pflegeschulen aufgrund der monatlichen „Pro-Kopf-Finanzierung“ erhebliche Finanzierungslücken zu kompensieren haben, insbesondere wenn Auszubildende ihre Ausbildung abbrechen. Sinnvoll wäre hier eine Kursfinanzierung über achtzehn Monate mit einer gleichbleibenden Finanzierung und Sicherung einer stabilen pädagogischen Strukturqualität. Bei der Pflegefachassistentenausbildung muss zugleich bedacht werden, dass die 18monatige Ausbildungsdauer von den bisher etablierten 1- oder 2jährig dauernden Ausbildungszyklen abweicht und sich die Übergänge schwierig gestalten können. Insbesondere für kleine Pflegeschulen kann dies zu nichtrefinanzierten Vorhaltekosten führen.

Die Abbruchquoten in den Pflegeausbildungen sind weiterhin zu hoch. Um interessierte Auszubildende auch nachhaltig in der Ausbildung begleiten zu können, braucht es dringend einer refinanzierten Schulsozialarbeit. Mit der Pflegefachassistentenausbildung sollen insbesondere auch bildungsschwächere Menschen angesprochen werden. Dies gelingt nur, wenn Schulsozialarbeit als integraler Bestandteil der Ausbildung auskömmlich refinanziert wird. In den Bundesländern lässt sich eine Refinanzierung einvernehmlich nicht vereinbaren, deshalb ist eine Regelung auf Bundesebene zwingend notwendig.

Positiv bewerten wir, dass die Regelungen zur Anerkennung der ausländischen Berufsabschlüsse nun bundesweit vereinheitlicht und vereinfacht werden. Insbesondere die konkreten Verfahrensregelungen, wie z.B. die Vorgaben zu einzureichenden Unterlagen, sind ein wichtiger Schritt zur Vereinheitlichung und Standardisierung des Verfahrens und vereinheitlichen die regional sehr unterschiedlichen und teilweise überbordenden Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen der Ausländerbehörden.

Wie der Bundesrat bereits seit Langem für die landesrechtlich geregelten Pflegehelfer-/assistentenausbildungen (BR-Drs. 367-22 vom 16.9.2022 Seite 1 f) und nun auch für die Pflegefachassistentenausbildung fordert (BR-Drs 364/25), muss das Aufenthaltsgesetz zwingend angepasst werden, damit mehr ausländische Arbeitskräfte für die Pflegefachassistentenausbildung gewonnen können und insbesondere Zugewanderten mit ungesichertem Aufenthaltsstatus der Zugang zur Pflegefachassistentenausbildung erleichtert wird. Aufgrund der 18monatigen Dauer der Pflegefachassistentenausbildung erfüllt diese nicht die Anforderung an eine qualifizierte Berufsausbildung im Sinne des § 2 Abs.12a AufenthG. Die Ausbildungsduldung nach § 60 c Abs.1 Nr.1c AufenthG für die Pflegefachassistentenausbildung erfolgt nur, wenn von vornherein eine Pflegefachkraftausbildung angestrebt wird. Nach dem neuen Personalbemessungsverfahren in der Pflege braucht es zukünftig vor allem mehr ausgebildete Pflegefachassistentenkräfte, die angesichts des demografischen Wandels nicht allein durch in Deutschland lebende Arbeitskräfte gedeckt werden können. Die Pflegefachassistentenausbildung muss daher einer qualifizierten Berufsausbildung im Sinne von § 2 Abs. 12a AufenthG gleichgestellt werden. Hilfsweise sollte im Rahmen der Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG oder der Ausbildungsaufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG das Erfordernis gestrichen werden, dass bereits eine Ausbildungsplatzzusage für die qualifizierte Berufsausbildung, hier also die Pflegefachkraftausbildung vorliegt.

B. Artikel 1 Gesetz über den Pflegefachassistentenberuf* (Pflegefachassistentengesetz – PflFAssG)

Teil 2: Ausbildung in der Pflegefachassistenten

§ 4 Ausbildungsziel

(1) Die Pflegefachassistentenausbildung vermittelt die unter Beachtung der Pflegeprozessverantwortung von Pflegefachpersonen in akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlichen Kompetenzen zur selbständigen Durchführung von Pflegemaßnahmen in nicht komplexen Pflegesituationen sowie für die Mitwirkung an Pflegemaßnahmen in komplexen Pflegesituationen für Menschen aller Altersstufen. Die zu erwerbenden Kompetenzen umfassen fachliche und personale Kompetenzen einschließlich der zugrunde liegenden methodischen, sozialen, diversitätssensiblen, kommunikativen und digitalen Kompetenzen und der zugrunde liegenden Lernkompetenzen sowie der Fähigkeit zum Wissenstransfer und zur Selbstreflexion. Lebenslanges Lernen wird dabei als ein Prozess der eigenen beruflichen Biographie verstanden und die fortlaufende persönliche und fachliche Weiterentwicklung als notwendig anerkannt.

(2) Pflege im Sinne des Absatzes 1 umfasst präventive, kurative, rehabilitative, palliative und sozialpflegerische Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung, Wiedererlangung oder Verbesserung der physischen und psychischen Situation der zu pflegenden Menschen, ihre Beratung sowie ihre Begleitung in allen Lebensphasen und die Begleitung Sterbender. Sie erfolgt entsprechend dem allgemein anerkannten Stand pflege- wissenschaftlicher, medizinischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse auf Grundlage einer professionellen Ethik. Sie berücksichtigt die konkrete Lebenssituation, den sozialen, kulturellen und religiösen Hintergrund, die sexuelle Orientierung sowie die Lebensphase der zu pflegenden Menschen. Sie unterstützt die Selbständigkeit der zu pflegenden Menschen und achtet deren Recht auf Selbstbestimmung.

(3) Die Ausbildung soll insbesondere dazu befähigen,

1. die folgenden Aufgaben unter Beachtung der Pflegeprozessverantwortung einer Pflegefachperson nach dem Pflegeberufegesetz in nicht komplexen Pflegesituationen selbständig durchzuführen und in komplexen Pflegesituationen an ihrer Durchführung mitzuwirken:

a) Unterstützung bei der Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs und der Planung der Pflege,

b) Durchführung von körpernahen Pflegemaßnahmen,

c) Dokumentation und gezielte mündliche Informationsweitergabe durchgeführter Pflegemaßnahmen und selbst erhobener pflegebezogener Informationen,

d) Beteiligung an der Evaluation des Pflegeprozesses durch eine aussagekräftige Dokumentation und weitere praxisorientierte Instrumente,

e) Berücksichtigung qualitätssichernder Durchführungsstandards im eigenen Handlungsbereich (Verantwortungs- und Aufgabenbereich),

f) Durchführung präventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen, wie zum Beispiel von Maßnahmen der Prophylaxe,

g) Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Alltagskompetenz mit den zu pflegenden Menschen,

h) Durchführung rehabilitativer Pflegemaßnahmen,

i) Unterstützung von zu pflegenden Menschen bei der Lebensgestaltung und Ermöglichung von Teilhabe sowie Selbständigkeit,

j) Begleitung von Menschen in palliativen Pflegesituationen und in der letzten Lebensphase,

k) Einleitung lebenserhaltender Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des Arztes und Durchführung von Maßnahmen in Krisen- und Katastrophensituationen,

2. ärztlich angeordnete, zur Übertragung geeignete Maßnahmen nach Übertragung durch die Ärztin oder den Arzt oder nach Weiterübertragung durch die Pflegefachperson eigenständig durchzuführen,

3. intra- und interprofessionell zu kommunizieren und effektiv im Pflorgeteam und mit anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten.

(4) Während der Ausbildung zur Pflegefachassistentin, zum Pflegefachassistenten oder zur Pflegefachassistentenzperson werden ein professionelles, ethisch fundiertes Pflegeverständnis und ein berufliches Selbstverständnis entwickelt und gestärkt.

Bewertung:

1. Absatz 3: Ausbildungsziele für die Pflegeassistentenausbildung

Wir begrüßen es sehr, dass der Gesetzentwurf mit den genannten Ausbildungszielen die Kompetenzen der Pflegefachassistentenkräfte stärkt. Denn um zukünftig die pflegerische Versorgung sicherzustellen, bedarf es ein Mehr an gut ausgebildetem Personal. Der zunehmende Mangel an Pflegefachkräften erfordert eine Umverteilung der Aufgaben auf unterschiedliche Berufsqualifikationen in der Pflege. Eine ineinandergreifende Kompetenzverteilung, die zur gegenseitigen Entlastung führt und gleichzeitig die Kompetenzprofile klar voneinander trennt, ist ein wichtiger Faktor für eine gelungene Umverteilung der Aufgaben. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, sind aus unserer Sicht die für die Pflegefachassistentenausbildung festgelegten Ausbildungsziele zwingend erforderlich.

2. Absatz 3 Satz 1, Nummer 1 a) und d)

Die im § 4 Absatz 3 aufgeführten Ausbildungsziele für Pflegefachassistent:innen erfassen insgesamt die notwendigen Kompetenzen, die Pflegefachassistent:innen benötigen, um pflegerische Maßnahmen durchführen und unterstützend am Pflegeprozess mitwirken zu können. Kritisch sehen wir allerdings die unter a) und d) aufgeführten Kompetenzen. Hier werden die vorbehaltenen Tätigkeiten nach § 4 PflBG aufgeweicht. Diese müssen aber zwingend von Pflegefachkräften durchgeführt werden. Es darf nicht die Gefahr bestehen, dass eine durch Personalmangel motivierte Übertragung auf die Pflegefachassistent:in erfolgt.

Pflegefachassistentenkräfte unterstützen bei den Vorbehaltsaufgaben im Rahmen der ihnen übertragenen pflegerischen Maßnahmen und Kompetenzen zur Dokumentation und Informationsweitergabe. Es ist daher nicht erkennbar, welche weitergehenden Kompetenzen durch diese Ausbildungsziele vermittelt werden sollen und wie sie klar und eindeutig von den Vorbehaltsaufgaben abzugrenzen sind.

Änderungsvorschläge:

- a. Die Kompetenzen in § 4 Absatz 3 Nummer 1 a) und d) sind zu streichen.
- b. Absatz 3 Nummer 1c) ist wie folgt zu ergänzen: Dokumentation und gezielte mündliche Informationsweitergabe durchgeführter Pflegemaßnahmen und selbst erhobener pflegebezogener Daten, auch mit dem Ziel, die Pflegefachkraft bei Erhebung des individuellen Pflegebedarfs, der Pflegeplanung und der Evaluation des Pflegeprozess zu unterstützen.
- c. Am Ende des Absatzes 3 Nummer 1 ist einzufügen: Die Durchführung der vorbehaltenen Tätigkeiten nach § 4 PflBG kann auch in nicht-komplexen Pflegesituationen nur durch eine Pflegefachkraft nach § 1 PflBG erfolgen. Eine Übertragung, auch in Teilen, auf die Pflegefachassistentenkräfte darf nicht erfolgen.

3. Absatz 3 Satz 1, Nummer 1 I, Weitergehende Kompetenzen

Zugleich halten wir es für wichtig, dass Pflegefachassistentenkräfte Veränderungen der Pflegesituation erkennen und darauf adäquat reagieren können. Sie führen die alltäglichen pflegerischen

Maßnahmen durch und sind damit im engen Kontakt mit den Patienten. Deshalb müssen sie die Fähigkeiten besitzen, Veränderungen der Pflegesituation zu erkennen und sie entsprechend aufbereitet weitergeben.

Ergänzungsvorschlag:

Absatz 3 Nummer 1 I) ist einzufügen: „*Notfallsituationen und Veränderungen der Pflegesituation durch gezielte Beobachtung rechtzeitig erkennen und angemessen handeln.*“

4. Absatz 3 Nummer 2:

Eine spürbare Entlastung der Pflegefachkräfte und eine effektive Zusammenarbeit der Pflegekräfte im Qualifikationsmix gelingt nur, wenn Pflegefachassistenzkräfte, mit Kompetenzen in der medizinischen Behandlungspflege ausgestattet sind. In den bisherigen Landesausbildungen sind Kompetenzen zur eigenständigen Durchführung von behandlungspflegerischen Maßnahmen nur marginal vorgesehen. Der Pflegefachkraftmangel führt jedoch dazu, dass länderspezifische Vereinbarungen der Pflegedienste und Kassen die Durchführung oder Mitwirkung an einzelnen behandlungspflegerischen Maßnahmen bei entsprechend qualifizierten Pflegefachassistenzkräften zulassen. Dies führt zu einer Vielfalt an unterschiedlichen landesbezogenen Vorgaben. Mit einer einheitlichen Pflegefachassistenzausbildung kann der unterschiedlichen Handhabung entgegengewirkt werden und sichergestellt werden, dass Pflegehilfskräfte bundesweit die gleichen Kompetenzen haben.

Angesichts des bestehenden Pflegefachkräftemangels ist wünschenswert, dass Pflegefachassistenzkräfte möglichst viele behandlungspflegerische Maßnahmen übernehmen können. Wir befürworten daher, wenn die in der Gesetzesbegründung genannten Maßnahmen (subkutane Injektionen, Medikamentengabe, Kompressionsstrümpfe oder -verbände anlegen und Sauerstoffgabe) zwingend zu den Ausbildungsinhalten gehören. Mit Blick auf die Dauer der Ausbildung muss aber eine qualitätsgesicherte Vermittlung im Vordergrund stehen, um die Patientensicherheit nicht zu gefährden. Gleichzeitig müssen die bestehenden anerkannten Kompetenzen in den Ländern, wie z.B. in NRW, Berlin, Baden-Württemberg beachtet werden, damit dort der Einsatz von Pflegefachassistenzkräften weiterhin wie bisher möglich bleibt.

Die Konkretisierung der Ausbildungsinhalte, insbesondere die Kompetenzen zu Abs. 3 Nummer 3 muss in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vorgenommen werden. Eine abschließende Bewertung des Referentenentwurfs ist daher nur gleichzeitig mit der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sinnvoll möglich. Wir bitten daher, diese bereits im Gesetzgebungsverfahren vorzulegen.

Eine Nachschärfung ist in Bezug auf die Delegationsmöglichkeiten notwendig, die dem Grunde nach befürwortet werden. Da die Gesamtverantwortung für den pflegerischen Prozess, insbesondere für die vorbehaltenen Tätigkeiten nach § 4 PflBG, bei der Pflegefachkraft liegt, kann eine direkte Delegation zwischen Ärztin bzw. Arzt und Pflegefachassistenzkraft nicht erfolgen. Darüber hinaus besteht bei der medizinischen Behandlungspflege Rechtsunsicherheit bezüglich der Subdelegation (Ärztin/Arzt delegiert an Pflegefachkraft, Pflegefachkraft delegiert weiter an Pflegefachassistenzkraft). In der Gesetzesbegründung ist daher konkret auszuführen, in welchen Situationen eine Direktdelegation oder Subdelegation erfolgen soll bzw. kann. Die Möglichkeiten und Grenzen zur Delegation von Pflegefachkraft zur Pflegefachassistenz müssen auch mit dem derzeit laufenden Gesetzgebungsprozess des Pflegekompetenzgesetz harmonisiert werden.

§ 5 Dauer und Struktur der Ausbildung

(1) Die Ausbildung zur Pflegefachassistentin, zum Pflegefachassistenten oder zur Pflegefachassistenzperson dauert unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprüfung in Vollzeitform 18 Monate, in Teilzeitform höchstens 36 Monate. Sie besteht aus theoretischem und praktischem Unterricht und einer praktischen Ausbildung; der Anteil der praktischen Ausbildung überwiegt.

(2) Der theoretische und praktische Unterricht wird an staatlichen, staatlich genehmigten oder staatlich anerkannten Pflegeschulen nach § 8 auf der Grundlage eines von der Pflegeschule zu erstellenden schulinternen Curriculums erteilt. Das schulinterne Curriculum wird auf der Grundlage der Empfehlungen des Rahmenlehrplans nach § 44 und der Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 47 Absatz 1 und 2 erstellt. Die Länder können unter Beachtung der Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung einen verbindlichen Lehrplan als Grundlage für die Erstellung der schulinternen Curricula der Pflegeschulen erlassen.

(3) Die praktische Ausbildung wird in den Einrichtungen nach § 6 auf der Grundlage eines vom Träger der praktischen Ausbildung zu erstellenden Ausbildungsplans durchgeführt. Sie gliedert sich in drei Pflichteinsätze und Stunden zur freien Verfügung. Wesentlicher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist die von den Einrichtungen zu gewährleistende Praxisanleitung im Umfang von mindestens zehn Prozent der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit. Die Pflegeschule unterstützt die praktische Ausbildung durch die von ihr in angemessenem Umfang zu gewährleistende Praxisbegleitung. Auf der Grundlage einer Genehmigung der zuständigen Behörde kann ein geringer Anteil der praktischen Ausbildung durch praktische Lerneinheiten an der Pflegeschule oder beim Träger der praktischen Ausbildung ersetzt werden.

(4) Die Pflegeschule, der Träger der praktischen Ausbildung und die weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen wirken bei der Ausbildung auf der Grundlage entsprechender Kooperationsverträge zusammen.

Bewertung:

1. Absatz 1:

Wie bereits zu § 4 ausgeführt, halten wir einen Kompetenzzuwachs, wie er für die Pflegefachassistentenausbildung vorgesehen ist, für zwingend notwendig, um für eine Entlastung der Pflegefachkräfte und eine effektive Zusammenarbeit in dem vorgesehenen Qualifikationsmix nach § 113 c SGB XI und § 137k SGB V zu sorgen. Der ansteigende Personalmangel erhöht den Druck möglichst schnell ausgebildetes Personal zur Verfügung zu haben. Dennoch halten wir eine bessere Ausbildung der Pflegefachassistentenpersonen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für alle Pflegekräfte und zur Steigerung der Attraktivität der Pflegefachassistentenausbildung für essenziell. Gleichzeitig müssen in der Pflegefachassistentenausbildung Rahmenbedingungen geschaffen werden, die dazu befähigen, die Pflegefachkräfte zu entlasten. Im Rahmen einer 18-monatigen Ausbildung wird die Möglichkeit gegeben fachliche Inhalte zu entzerren, Inhalte zu wiederholen und zu festigen, sowie durch viele praktische Übungen zu vertiefen, um so einer Überforderung der Auszubildenden entgegenzuwirken und zudem die Pflegequalität zu steigern. Die Inhalte gewährleisten durch eine strukturelle Anlehnung an die dreijährige Ausbildung die Anschlussfähigkeit.

Zugleich benötigen Pflegeauszubildende, die oftmals auch mit vielfältigen Bildungs- oder Sozialdefiziten zu kämpfen haben, ausreichend Zeit. Dies ist vor dem Hintergrund der Abbruchquoten und der vorhandenen Defizite der Auszubildenden zu berücksichtigen.

Wir befürworten, dass grundsätzlich auch Menschen ohne allgemeinbildenden Schulabschluss zur Pflegefachassistentenausbildung zugelassen werden sollen. Dadurch werden zugewanderten Menschen und Menschen mit schwieriger Lebensbiografie Bildungschancen eröffnet. Um Bildungslücken zu schließen, die Sprachkenntnisse zu stärken und die Anschlussfähigkeit an die Pflegefachkraftausbildung zu gewährleisten, müssen die Länder ergänzende allgemeinbildende Angebote schaffen. Diese Möglichkeit wird in der Gesetzesbegründung zwar benannt. Eine dahingehende ausdrückliche Ermächtigung der Länder, wie sie vom Bundesrat im Beschluss vom 26.09.2025 (BT-Drs. 364/25) vorgeschlagen wird, führt aus unserer Sicht zu mehr Rechtsklarheit.

Ergänzungsvorschlag:

Absatz 1 wird nach Satz 1 wie folgt ergänzt (entsprechend dem Vorschlag des Bundesrates vom 26.09.2025): *Die Länder können Regelungen zur zusätzlichen Erlangung eines allgemeinbildenden Abschlusses treffen; für den dafür erforderlichen allgemeinbildenden Unterricht gilt § 24 nicht.*

Zu Absatz 2:

Das Erstellen eines schulinternen Curriculums stellt die Pflegeschulen vor große Herausforderungen. Erfahrungswerte von Pflegeschulen, die ihre Schulcurricula zur generalistischen Pflegefachkraftausbildung selbst entwickeln mussten, zeigen, dass damit ein hoher Zeit- und damit finanzieller Aufwand verbunden war. Gerade kleinere Pflegeschulen können diese Ressourcen nicht bereitstellen. Bei der Einführung der generalistischen Pflegefachkraftausbildung hat sich gezeigt, dass nicht alle Länder die Pflegeschulen mit Mustern unterstützten. Daher würde ein Muster-Curriculum auf Bundesebene durch die Fachkommission oder das BiBB die Umsetzung erleichtern.

Ergänzungsvorschlag:

Absatz 2 wird nach Satz 2 wie folgt ergänzt: Das BiBB erstellt auf Grundlage der Empfehlungen des Rahmenlehrplans ein Muster für ein schulinternes Curriculum.

2. Absatz 3 und § 6 Absatz 2:

Die Ausgestaltung der praktischen Ausbildung mit drei Pflichteinsätzen und einer zusätzlichen Zeit zur freien Verfügung ist angesichts einer 18monatigen Ausbildungszeit nicht zielführend. Die Einsatzzeiten sind sehr knapp bemessen, was eine ausreichende Wissensvermittlung gefährdet. Ein schneller Wechsel der Einsatzorte führt zum Frust und Unsicherheiten bei den Auszubildenden. Deshalb muss die Ausbildungszeit in erster Linie den Pflichteinsätzen zur Verfügung stehen. Die Zeit zur freien Verfügung muss gestrichen werden. Einsätze in besonderen Bereichen sind durch Hospitationen oder Praktika zu ermöglichen, soweit dies das Ausbildungsziel nicht gefährdet und organisatorisch umgesetzt werden kann. Die Pflichteinsätze sind zeitlich flexibel einzuplanen und sollten eine angemessene Zeit in allen Bereichen vorsehen.

§ 6 Durchführung der praktischen Ausbildung

(1) Die Pflichteinsätze in der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtungen, der allgemeinen Langzeitpflege in stationären Einrichtungen und der allgemeinen ambulanten Akut- und Langzeitpflege werden in folgenden Einrichtungen durchgeführt:

- 1. zur Versorgung nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen Krankenhäusern,*
- 2. zur Versorgung nach § 71 Absatz 2 und § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen stationären Pflegeeinrichtungen,*
- 3. zur Versorgung nach § 71 Absatz 1 und § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und § 37 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen ambulanten Pflegeeinrichtungen.*

(2) Ein Einsatz, der kein Pflichteinsatz ist, kann auch in anderen, zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. Insgesamt soll der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung stattfinden. Das Nähere regelt die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 47 Absatz 1.

(3) Die Geeignetheit von Einrichtungen nach den Absätzen 1 und 2 zur Durchführung von Teilen der praktischen Ausbildung bestimmt sich nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen, wobei ein angemessenes Verhältnis von Auszubildenden zu Pflegefachkräften und Pflegefachassistenzkräften gewährleistet sein muss. Die zuständige Landesbehörde kann im Falle von Rechtsverstößen einer Einrichtung die Durchführung der Ausbildung untersagen.

(4) Die Länder können durch Landesrecht bestimmen, dass eine Ombudsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen der auszubildenden Person und dem Träger der praktischen Ausbildung eingerichtet wird. Die Ombudsstelle kann bei der zuständigen Stelle entsprechend § 26 Absatz 4 des Pflegeberufgesetzes eingerichtet werden.

Bewertung:

1. Absatz 2

Die Regelung zum Einsatz zur freien Verfügung ist zu streichen, da die Stunden zur freien Verfügung abgelehnt werden.

2. Absatz 3

Einrichtungen sollen als Träger der praktischen Ausbildung geeignet sein, wenn sie u.a. ein angemessenes Verhältnis von Auszubildenden zu Pflegefachkräften und Pflegefach-assistenzkräften gewährleisten. Entscheidend für eine qualitätsgesicherte Ausbildung ist ausreichend Zeit für die Praxisanleitung, die parallel zum Pflegeberufegesetz auf 10 % festgelegt wurde.

§ 7 Träger der praktischen Ausbildung

(1) Der Träger der praktischen Ausbildung trägt die Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung einschließlich ihrer Organisation. Er schließt mit der auszubildenden Person einen Ausbildungsvertrag.

(2) Träger der praktischen Ausbildung können ausschließlich Einrichtungen nach § 6 Absatz 1 sein,
1. die eine Pflegeschule selbst betreiben oder
2. die mit mindestens einer Pflegeschule einen Vertrag über die Durchführung des theoretischen und praktischen Unterrichts geschlossen haben.

(3) Der Träger der praktischen Ausbildung hat über Vereinbarungen mit den weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen zu gewährleisten, dass
1. die vorgeschriebenen Einsätze der praktischen Ausbildung in den weiteren an der praktischen Ausbildungsbeteiligten Einrichtungen durchgeführt werden können und
2. die Ausbildung auf der Grundlage eines Ausbildungsplans zeitlich und sachlich gegliedert so durchgeführt werden kann, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann.

(4) Die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung nach Absatz 3 können von einer Pflegeschule wahrgenommen werden, wenn Trägeridentität besteht oder soweit der Träger der praktischen Ausbildung die Wahrnehmung der Aufgaben durch Vereinbarung auf die Pflegeschule übertragen hat. Die Pflegeschule kann in diesem Rahmen auch zum Abschluss des Ausbildungsvertrages für den Träger der praktischen Ausbildung bevollmächtigt werden.

(5) Auszubildende sind für die gesamte Dauer der Ausbildung Arbeitnehmer im Sinne von § 5 des Betriebsverfassungsgesetzes oder von § 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes des Trägers der praktischen Ausbildung. Träger der praktischen Ausbildung bleibt auch in den Fällen des Absatzes 4 die Einrichtung nach den Absätzen 1 und 2.

§ 8 Mindestanforderungen an Pflegeschulen

(1) Pflegeschulen müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen:
1. hauptberufliche Leitung der Schule durch eine pädagogisch qualifizierte Person mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Niveau,
2. Nachweis einer im Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze angemessenen Zahl fachlich und pädagogisch qualifizierter Lehrkräfte mit entsprechender, insbesondere pflegepädagogischer, abgeschlossener Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Niveau für die Durchführung des theoretischen Unterrichts sowie mit entsprechender, insbesondere pflegepädagogischer, abgeschlossener Hochschulausbildung für die Durchführung des praktischen Unterrichts,
3. Vorhandensein der für die Ausbildung erforderlichen Räume und Einrichtungen sowie ausreichender Lehr- und Lernmittel, die den Auszubildenden kostenlos zur Verfügung zu stellen sind. Den Belangen von Menschen mit Behinderungen ist Rechnung zu tragen.

(2) Das Verhältnis nach Absatz 1 Nummer 2 soll für die hauptberuflichen Lehrkräfte mindestens einer

Vollzeitstelle auf 20 Ausbildungsplätze entsprechen. Eine geringere Anzahl von hauptberuflichen Lehrkräften ist nur vorübergehend zulässig.

(3) Die Länder können durch Landesrecht das Nähere zu den Mindestanforderungen nach den Absätzen 1 und 2 bestimmen und weitere, auch darüberhinausgehende Anforderungen festlegen. Sie können für die Lehrkräfte für die Durchführung des theoretischen Unterrichts nach Absatz 1 Nummer 2 befristet bis zum 31. Dezember 2035 regeln, inwieweit die erforderliche Hochschulausbildung nicht oder nur für einen Teil der Lehrkräfte auf Master- oder vergleichbarem Niveau vorliegen muss.

Bewertung:

Ein festes Verhältnis ist wichtig für die Planung der Schule und Festlegung der Finanzierung. Kritisch sehen wir, dass die Refinanzierung der Lehrkräfte bei einer reduzierten Auszubildendenzahl aufgrund von Abbruch oder Wechsel der Ausbildung nicht gesichert ist. Angesichts der schwankenden Auszubildendenzahl in den Schuljahrgängen kann dies die Pflegeschulen vor Liquiditätsengpässen stellen. Daher sprechen wir uns dafür aus, dass die Refinanzierung über die vollen 18 Monate garantiert ist. Es besteht sonst die Gefahr, dass Pflegeschulen keine Pflegefachassistentenausbildung durchführen. Berücksichtigt werden muss gleichzeitig, dass sich die Finanzierung der Pflegeschulen an der tatsächlichen Anzahl der Auszubildenden orientiert. Ein Personalschlüssel kann daher nur eingeführt werden, wenn gleichzeitig die Finanzierung die Vorhaltekosten mit abdeckt, also nicht wie bisher pro Auszubildenden im Monat erfolgt.

§§ 7 und 9, §§ 14 ff sowie Regelungen zur Ausgestaltung des Ausbildungsverhältnisses

Die Vorgaben zu Kooperationsverträgen und der Verteilung der Verantwortung zwischen Schule und Träger der Praktischen Ausbildung als auch zur Ausgestaltung des Ausbildungsverhältnisses haben sich im Pflegeberufegesetz bewährt und sollten wie dargelegt weitergeführt werden.

§ 10 Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung

(1) Voraussetzung für den Zugang zu der Ausbildung zur Pflegefachassistentin, zum Pflegefachassistenten oder zur Pflegefachassistentenperson ist der Hauptschulabschluss, ein anderer gleichwertiger Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird der Zugang zur Ausbildung gewährt, wenn eine positive und sachlich begründete Prognose der Pflegeschule dahingehend vorliegt, dass die Ausbildung von der auszubildenden Person erfolgreich absolviert und die staatliche Abschlussprüfung bestanden werden kann.

(3) § 2 Nummer 2 bis 4 findet entsprechende Anwendung.

Bewertung:

Die Diakonie Deutschland, der DEVAP sowie der DEKV befürworten die Möglichkeit, Menschen ohne Schulabschluss für die Pflegefachassistentenausbildung zuzulassen. Insbesondere geeigneten Bewerber:innen mit Migrations- und Fluchthintergrund kann somit ein Zugang zur Pflegeausbildung ermöglicht werden. Die Zulassung durch eine positive Prognoseentscheidung der Pflegeschule halten wir für einen geeigneten Weg, da die Pflegeschulen die individuellen Bewerber:innen am besten einschätzen können.

Um eine gewisse Einheitlichkeit und Kontrolle der Prognoseentscheidungen sicherzustellen, ist dem Bundesinstitut für Berufsbildung als weitere Aufgabe die Entwicklung von Empfehlungen für die Prognoseentscheidung der Pflegeschule zu übertragen. Ergänzend könnten die Länder zu verbindlichen Vorgaben für die Prognoseentscheidung ermächtigt werden. Es wird begrüßt, dass die Regelung bis zum 31. Dezember 2031 evaluiert werden soll.

Ergänzungsvorschlag:

Absatz 2 ist wie folgt zu ergänzen: *Die Prognoseentscheidung der Pflegeschule erfolgt entsprechend der Empfehlung des Bundesinstitut für Berufsbildung. Das Nähere regeln die Länder.*

§ 11 Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen und Berufserfahrung

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag der auszubildenden Person auf bis zu ein Drittel der Dauer einer Ausbildung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 anrechnen:

- 1. eine andere erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder erfolgreich abgeschlossene Teile einer Ausbildung, jeweils im Umfang ihrer Gleichwertigkeit,*
- 2. eine mindestens 18 Monate dauernde praktische Vollzeittätigkeit in der Pflege in einer oder mehreren Einrichtungen nach § 6 Absatz 1 oder in insgesamt dem gleichen zeitlichen Umfang eine praktische Teilzeittätigkeit in der Pflege in einer oder mehreren Einrichtungen nach § 6 Absatz 1, wenn der Nachweis vorliegt, dass das Ende der Vollzeit- oder der Teilzeittätigkeit bei Antragstellung nicht länger als 36 Monate zurückliegt, oder*
- 3. anderweitig erworbene Kompetenzen in entsprechendem Umfang, die in einem Kompetenzfeststellungsverfahren festgestellt worden sind; das Nähere zum Kompetenzfeststellungsverfahren regeln die Länder. Das Erreichen des Ausbildungsziels nach § 4 darf durch die Anrechnung nicht gefährdet werden.*

(2) Die zuständige Behörde kann auf Antrag der auszubildenden Person, bei Vorliegen einer sachlich begründeten positiven Prognose der Pflegeschule hinsichtlich des erfolgreichen Abschlusses der Pflegefachassistentenausbildung mit Bestehen der staatlichen Abschlussprüfung durch die antragstellende Person, die Dauer der praktischen Pflegefachassistentenausbildung durch Anrechnung um den vollen Umfang und die Dauer des theoretischen und praktischen Unterrichts auf 320 Stunden verkürzen (Vorbereitungskurs), wenn

- 1. eine Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz erst nach der Hälfte der Ausbildungsdauer abgebrochen wurde und der Nachweis vorliegt, dass der Abbruch der Ausbildung bei Antragstellung nicht länger als 36 Monate zurückliegt, oder*
- 2. eine mindestens 36 Monate dauernde praktische Vollzeittätigkeit in der Pflege in einer oder mehreren Einrichtungen nach § 6 Absatz 1 oder in insgesamt dem gleichen zeitlichen Umfang eine praktische Teilzeittätigkeit in der Pflege in einer oder mehreren Einrichtungen nach § 6 Absatz 1 und der Nachweis vorliegen, dass das Ende der Vollzeit- oder der Teilzeittätigkeit bei Antragstellung nicht länger als 36 Monate zurückliegt. Auf den Vorbereitungskurs nach Satz 1 finden die den Träger der praktischen Ausbildung, den Ausbildungsvertrag und die Ausbildungsvergütung betreffenden Vorschriften keine Anwendung.*

(3) Wurde eine Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz ohne Abschluss beendet, kann die zuständige Behörde auf Antrag, wenn nach dem Ergebnis der Zwischenprüfung nach § 6 Absatz 5 des Pflegeberufegesetzes für die antragstellende Person das Erreichen des dort in Bezug genommenen Ausbildungsziels nicht gefährdet war und diese Prüfung bei Antragstellung nicht länger als 36 Monate zurückliegt, die Dauer der praktischen Pflegefachassistentenausbildung und die Dauer des theoretischen und praktischen Unterrichts durch Anrechnung um den vollen Umfang verkürzen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Bewertung:

Die Diakonie, der DEKV und DEVAP begrüßen die weitgehenden Anrechnungsmodalitäten und die Einführung eines Kompetenzfeststellungsverfahrens zur Feststellung durch Praxiserfahrung erworbener Kompetenzen. Dies führt zu einer sachgerechteren Berücksichtigung der Praxiserfahrungen zahlreicher Pflegehilfskräfte beim Erwerb des Berufsabschlusses und stellt sicher, dass diese tatsächlich vorliegen.

Aus Berlin und Brandenburg, wo die 18monatige Pflegefachassistentenausbildung bereits seit einigen Jahren umgesetzt wird, wird bemängelt, dass die Anträge auf Zulassung zur verkürzten Pflegefachassistentenausbildung sehr aufwendig sind und die Verbescheidung nicht auf den

Ausbildungsstart abgestimmt sind. Oftmals entstehen unnötige Lücken, die vor allem erwachsene Auszubildende die ihren Lebensunterhalt absichern müssen.

§ 13 Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegefachassistentenberufs

(1) Zur zeitlich befristeten Erprobung von Konzepten zur Durchführung der schulischen und praktischen

Ausbildung können die Länder im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium für Gesundheit Abweichungen von den §§ 5, 6 und 9 und den Vorschriften der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 47 Absatz 1, die sich nicht auf Inhalte oder Prüfungsvorgaben beziehen, zulassen, sofern das Erreichen des Ausbildungsziels nach § 4 nicht gefährdet wird. Dabei können Teile des theoretischen Unterrichts nach § 5 Absatz 2 als Fernunterricht erteilt werden.

(2) Die Zulassung als Modellvorhaben setzt voraus, dass

1. das Erprobungsziel beschrieben wird und erkennen lässt, welche qualitativen Verbesserungen für die Pflegefachassistentenausbildung unter Beachtung der berufsfeldspezifischen Anforderungen erwartet werden,

2. eine sachgerecht begleitende und abschließende wissenschaftliche Evaluierung des Modellvorhabens gewährleistet ist und

3. die Laufzeit des Modellvorhabens fünf Jahre nicht überschreitet und eine Verlängerung um höchstens zwei Jahre anhand der Evaluierungsergebnisse zu begründen ist.

Bewertung:

Die Möglichkeit von Modellvorhaben zur Weiterentwicklung auf Landesebene ist grundsätzlich zu begrüßen. Unklar ist allerdings wie die Ergebnisse der Modellvorhaben aufgrund der Bundesgesetzgebungskompetenz umgesetzt werden sollen. Die Bundesministerien müssen verpflichtet sein, die Modellvorhaben alle 5 Jahre auszuwerten und einen Anpassungsbedarf zu prüfen. Über das Ergebnis der Auswertung und das Prüfergebnis müssen die Ministerien einen Bericht veröffentlichen. Gleichzeitig muss es möglich sein in den Modellvorhaben Pflegefachassistentenausbildungen für Menschen mit besonderen Bedarfslagen, wie z.B. ausländische Pflegefachassistentenkräfte, Teilzeitbeschäftigte oder Ausbildungen in strukturschwachen Regionen zu erproben. Deshalb unterstützen wir den Vorschlag des Bundesrates Modellprojekte zur besseren Berücksichtigung gruppenspezifischer bzw. individueller Ausbildungshindernisse zu fördern.

Ergänzungsvorschläge:

1. Absatz 1 Satz 1 ist entsprechend dem Vorschlag des Bundesrates (Stellungnahme vom 18.10.2024, BR- Drs. 427/24) wie folgt zu ergänzen: *Zur zeitlich befristeten Erprobung von Konzepten zur Durchführung der schulischen und praktischen Ausbildung sowie zur Beseitigung individueller Ausbildungshindernisse können die Länder im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium für Gesundheit von den §§ 5, 6 und 9 und § 10 Abs.3 in Verbindung mit § 2 Nummer 4 abweichen.*

2. Absatz 2 Satz 1 ist wie folgt zu ergänzen: *„Die Zulassung als Modellvorhaben setzt voraus, dass das Erprobungsziel beschrieben wird und erkennen lässt, welche qualitativen Verbesserungen für die Pflegefachassistentenausbildung unter Beachtung der berufsfeld- spezifischen, regionalspezifischen Anforderungen als auch der besonderen Bedarfe der Auszubildenden erwartet werden.“*

3. Absatz 3 ist neu einzufügen: *„Das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Bildung, Familie, Soziales, Frauen und Jugend werten die Modellvorhaben in regelmäßigen Abschnitten aus und Prüfen den Weiterentwicklungsbedarf der Pflegefachassistentenausbildung. Hierüber ist ein Bericht zu veröffentlichen.“*

§ 24 Finanzierung

Mit dem Ziel,

1. bundesweit eine wohnortnahe qualitätsgesicherte Ausbildung sicherzustellen,
2. eine ausreichende Zahl qualifizierter Pflegefachassistentinnen, Pflegefachassistenten und Pflegefachassistentenpersonen auszubilden,
3. Nachteile im Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen zu vermeiden,
4. die Ausbildung in kleineren und mittleren Einrichtungen zu stärken und
5. wirtschaftliche Ausbildungsstrukturen zu gewährleisten, werden die Kosten der Pflegefachassistentenausbildung durch Ausgleichsfonds in entsprechender Anwendung von § 26 Absatz 2 bis 7, § 27 Absatz 1 sowie der §§ 28 bis 36 des Pflegeberufgesetzes finanziert. An die Stelle der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung treten die Kosten der Ausbildungsvergütung.

Bewertung:

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Finanzierung der Pflegefachassistentenausbildung über den Ausbildungsfond der Länder erfolgt. Gleichzeitig weisen wir daraufhin, dass die Pflegebedürftigen von der Kostenbeteiligung vollständig zu entlasten sind und diese durch Steuermittel abzusichern ist. Die Eigenanteile der Pflegebedürftigen sind in der letzten Zeit stark gestiegen, 2024 belaufen sich diese im stationären Bereich auf nunmehr bundesdurchschnittlich bei etwa 2400 € pro Monat (laut der Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) vom Januar 2025). Jede Form von Entlastung ist daher essenziell, damit Pflegebedürftige nicht zunehmend auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sind.

Zudem ist das Umlageverfahren für alle Beteiligten mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand verbunden, dem in den Bundesländern sehr unterschiedlich begegnet wird. Die Datenplattformen sind teilweise sehr starr und benutzerunfreundlich. In Hessen z.B. gibt es keine Trägerzugänge, so dass ein Träger mit bspw. 10 Einrichtungen gleiche Daten 10-mal eingeben muss. Die Verfahren ziehen sich angesichts des komplexen Verfahrens, so dass die Ausbildungsträger die Ausgleichzuweisungen erst 2-3 Jahre später erhalten. Dies belastet die Liquidität der Ausbildungsträger und – was noch viel gravierender ist – es reduziert die Ausbildungsbereitschaft.

Wir fordern daher unbedingt die Umsetzung eines bürokratieärmeren Verfahrens. Lösungen für eine Vereinfachung des Finanzierungsverfahrens der Pflegeausbildungen sowie die Entlastung der Pflegebedürftigen von den Ausbildungskosten sollten im Rahmen der Bund-Länder Gruppe zur Reform der Pflegeversicherung erarbeitet und umgesetzt werden.

1. Absatz 1 Nummer 1

Die sprachlichen und sozialen Defizite der Auszubildenden nehmen stetig zu, so dass Pflegeschulen zusätzliche Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache sowie einer dauerhaften, verlässlichen sozialpädagogischen Begleitung schaffen müssen, um Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Das hierfür qualifizierte Personal wird über den Ausbildungsfonds oft nicht anerkannt. Für eine berufliche Eingliederung spielt ein stabiles soziales Umfeld eine wichtige Rolle. Ein wesentlicher Anteil der Auszubildenden kommt aus dem Ausland oder hat einen Migrationshintergrund. Diese Auszubildenden, aber auch Menschen mit einem geringeren Bildungsstatus, benötigen aufgrund ihres persönlichen oder/und familiären Hintergrunds zunehmend weitergehender Unterstützung, als dies Schulpädagogen leisten können. Eine zusätzliche soziale Begleitung ist notwendig, die sowohl eine seelsorgerische als auch eine sozialpsychologische Betreuung umfassen kann. Das Modell der Schulsozialarbeit, das in einigen Bundesländern in den allgemeinbildenden Schulen existiert, muss auf die Pflegeschulen ausgeweitet und sachgerecht finanziert werden. Die Schulsozialarbeiter:innen unterstützen Auszubildende nicht nur in schwierigen Lebenssituationen während der Ausbildung, sondern sie vermitteln die Kompetenz, sich auch später im Beruf in herausfordernden Lebenssituationen unterstützende Ressourcen zu erschließen.

Ergänzungsvorschlag:

In den Zielen des § 24 Satz 1 Nummer 1 ist daher zu konkretisieren, dass eine qualitätsgesicherte Ausbildung auch die Finanzierung des Sprachunterrichts sowie der Schulsozialarbeit beinhaltet.

Absatz 1, letzter Absatz (Verweis auf die Vorschriften des Pflegeberufgesetzes)

Es wird begrüßt, dass bei der Option einer Pflegefachassistentenausbildung oder Pflegehelfer-ausbildung auf die Berücksichtigung einer „Wertschöpfung“, wie in § 27 Abs. 2 Pflegeberufgesetz geregelt ist, verzichtet wird. Auch beim kürzlich in Kraft getretenen Pflegestudiumstärkungsgesetz wurde auf die Wertschöpfung nach § 27 Abs. 2 Pflegeberufgesetz verzichtet. Umso mehr bleibt unverständlich, dass für die dreijährige Berufsausbildung nach PflBG an der Regelung des § 27 Abs. 2 PflBG und somit an der verminderten Refinanzierung ab dem zweiten Ausbildungsdrittel festgehalten wird. Zwingend notwendig ist somit, dass dies entsprechend dem hier vorliegenden Entwurf und entsprechend dem Pflegestudiumstärkungsgesetz auch für die berufliche Ausbildung geregelt wird. Die Anrechnung auf voll ausgebildete Pflegefachpersonen muss generell entfallen. Es gibt keinen sachlichen Grund für eine differenzierte Regelung zwischen Ausbildung in der Pflegefachassistentenausbildung, beruflicher und hochschulischer Ausbildung. Grundsätzlich muss die Ausbildung im Vordergrund stehen. Die geforderte Wertschöpfung führt zu einer verminderten Ausbildungsbereitschaft. Wichtig ist, dass die Pflegefachassistentenausbildung und die hochschulische Ausbildung nicht zu der dreijährigen Ausbildung nach PflBG in Konkurrenz gebracht wird. Angesichts des großen Fachkräftebedarfs muss es in erster Linie darum gehen, alle Träger zu motivieren in allen drei Ausbildungsformen mehr Auszubildende zu gewinnen.

Daher fordern wir, dass mit dem PflAssEinfG der § 27 Abs. 2 PflBG ganz gestrichen wird.

Zur Absicherung der Finanzierung der Pflegeschulen fordern wir darüber hinaus klarzustellen, dass die Investitionskosten für die Pflegeschulen auch die Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung umfassen müssen. Des Weiteren ist eine Klarstellung bei den Mietkosten der Pflegeschulen nötig: Stellen sie Gebäudekosten dar und sind somit den in Länderhoheit fallenden Investitionskosten zuzurechnen oder aber stellen sie Betriebskosten dar, die dann von der Umlage umfasst werden müssten. In jedem Fall ist die Finanzierung der Investitionskosten der Pflegeschulen einschließlich der Mietkosten vollumfänglich sicherzustellen. Dies gilt für die Pflegefachkraft- wie die Pflegefachassistentenausbildung gleichermaßen.

§ 51 Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestandsschutz

(1) Schulen, die am 31. Dezember 2026 nach landesrechtlichen Vorschriften über eine Helfer- oder Assistentenausbildung, die die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ (BAnz AT 17.02.2016 B3) erfüllt, in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung staatlich anerkannt sind, gelten weiterhin als staatlich anerkannt nach § 8, wenn die Anerkennung nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 widerrufen wird.

(2) Staatliche Anerkennungen von Schulen nach Absatz 1 sind zu widerrufen, falls das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 8 Absatz 1 und 2 nicht bis zum 31. Dezember 2036 nachgewiesen wird. Am 31. Dezember 2026 bestehende staatliche Schulen nach landesrechtlichen Vorschriften über eine Helfer- oder Assistentenausbildung, die die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ (BAnz AT 17.02.2016 B3) erfüllt, in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung setzen die Voraussetzungen nach § 8 Absatz 1 und 2 bis zum 31. Dezember 2036 um. § 8 Absatz 3 bleibt unberührt.

(3) Die Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Nummer 1 und 2 gelten als erfüllt, wenn als Schulleitung oder Lehrkräfte Personen eingesetzt werden, die am 31. Dezember 2026

- 1. eine staatliche oder staatlich anerkannte Pflegeschule nach Absatz 1 rechtmäßig leiten,*
- 2. als Lehrkräfte an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Pflegeschule nach Absatz 1 rechtmäßig unterrichten,*

3. über die Qualifikation zur Leitung oder zur Tätigkeit als Lehrkraft an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Pflegeschule nach Absatz 1 verfügen oder an einer Weiterbildung zur Leitung einer staatlichen oder staatlich anerkannten Pflegeschule nach Absatz 1 oder zur Lehrkraft teilnehmen und diese bis zum 31. Dezember 2026 erfolgreich abschließen.

Bewertung:

Zu Absatz 1

Die Anerkennungsanforderungen sind angemessen und der Bestandsschutz für die Pflegeschulen von 10 Jahren ist aus unserer Sicht ausreichend. Zugleich sollten zur Ausbildung von Pflegefachkräften (nach Pflegeberufegesetz) zugelassene Pflegeschulen automatisch die Anerkennung als Pflegeschulen für die Ausbildung zur Pflegefachassistentenausbildung erhalten können. Diese erfüllen bereits die Qualifikationsanforderungen an die Leitung und Lehrkräfte und sind demnach per se geeignet, die Pflegefachassistentenausbildung anzubieten. Eine automatische Anerkennung führt dazu, dass Synergieeffekte und mehr Ausbildungsplätze für die Pflegefachassistenten erreicht werden können. Auch die durch die 18-monatige Ausbildungsdauer bedingte „Leerlaufzeit“ der Lehrenden könnte durch Kombination mit der Pflegefachausbildung abgemildert werden. Dies würde darüber hinaus auf Seite der Schulen und der Behörden eine Reduktion von bürokratischen Anforderungen bewirken.

Ergänzungsvorschlag:

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: „Schulen, die am 31. Dezember 2026 die Zulassung zu Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz besitzen, gelten ebenso als staatlich anerkannt nach § 8 Absatz 2, wenn die Anerkennung nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 widerrufen wird.“

C. Artikel 2 Nummer 1: Verordnung über die Finanzierung der Ausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz und nach dem Pflegefachassistentengesetz sowie zur Durchführung statistischer Erhebungen (Pflegeberufesbildungsfinanzierungsverordnung - PflAFinV)

§ 4 Abs. 2 der Ausbildungsfinanzierungsverordnung wird wie folgt angepasst:

(2) Eine Differenzierung der Pauschalen für einen Kostentatbestand ist nach Art der Ausbildung zulässig. Im Übrigen ist sie nur bis zum Festsetzungsjahr 2028 zulässig und nur dann, wenn die Differenzierung nach sachgerechten, allgemeinen, objektiven und für alle Träger der praktischen Ausbildung oder für alle Pflegeschulen gleichen Kriterien erfolgt. Unzulässig ist insbesondere eine Differenzierung nach Versorgungsbereichen oder Trägerstrukturen ohne einen sachlichen Grund.“

Bewertung:

In der Praxis haben sich die Vereinbarungspartner in den Ländern auf differenzierte Pauschalen auch innerhalb der bisher berücksichtigten Arten der Ausbildung geeinigt, die sich mittlerweile sehr gut bewährt haben. So z.B. in Berlin und Niedersachsen, wo sich die Vereinbarungspartner bei der Vereinbarung der Finanzierung für den Träger der praktischen Ausbildung nach bisheriger Ausbildung nach Pflegeberufegesetz auf mehrere Pauschalen in Abhängigkeit der Arbeitgeberpersonalkosten für die praktische Ausbildung geeinigt haben. Es besteht daher ein hoher Bedarf die Befristung bis zum Festsetzungsjahr 2028 zu streichen. Sollte dies nicht möglich sein, dann sollte aufgrund der Einführung des neuen Pflegefachassistentenberufes die Befristung für alle Arten der Ausbildung verlängert werden.

Änderungsvorschlag:

§ 4 Absatz 2, Satz 2 ist wie folgt zu ändern: „Im Übrigen ist sie nur bis zum Festsetzungsjahr 2028 zulässig und nur dann zulässig, wenn die Differenzierung nach sachgerechten, allgemeinen,

objektiven und für alle Träger der praktischen Ausbildung oder für alle Pflegeschulen gleichen Kriterien erfolgt.“

§ 12 Ausbildungsfinanzierungsverordnung: bundeseinheitliche Regelung zum Finanzierungsbedarf in der Tagespflege

Aufgrund der Regelung im Pflegestudiumstärkungsgesetz, die auf eine Einheitlichkeit des Umlagebeitrags in stationären Pflegeeinrichtungen abzielt (Seite 158 der BT-Drs. 20/8901), wird in einigen Bundesländern die bisher sachgerechte Differenzierung zwischen einem Berechnungstag in der Tagespflege und einem Berechnungstag in einer vollstationären Einrichtung abgelehnt. Begründet wird dies mit "wettbewerbsneutralen Ausbildungszuschlägen für die stationäre Pflege". Dabei wird übersehen, dass die Tagespflege als teilstationäres Angebot nicht mit vollstationären Pflegeeinrichtungen einheitlich zu behandeln ist. Denn ein vollstationärer Belegungstag unterscheidet sich deutlich von einem Belegungstag in der Tagespflege: Er umfasst eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung (24/7), während ein teilstationärer Belegungstag zeitlich auf 8 Stunden begrenzt ist. Der längere Betreuungszeitraum erfordert einen höheren Einsatz an Pflegefachkräften und rechtfertigt somit eine höhere Kostenstruktur. Wir halten daher eine Gewichtung der Berechnungstage in teilstationären Pflegeeinrichtungen mit einem Faktor von 0,5, wie sie bereits in Rheinland-Pfalz umgesetzt wird, für sachgerecht. Zwar ist der Bedarf an Pflegefachkräften in der vollstationären Pflege zeitlich gesehen dreimal so umfangreich wie in der Tagespflege, was für einen Faktor von 0,33 spräche. Da in der vollstationären Pflege 9 bis 10 Stunden Nachtwachenzeit mit deutlich geringerer Personalisierung und Fachkräfteeinsatz anfallen, ist ein Gewichtungsfaktor von 0,5 angemessen. Eine bundeseinheitlich geregelte Differenzierung bei der Gewichtung der Berechnungstage ist notwendig, um die tatsächlichen Unterschiede im Personalbedarf und Betreuungsaufwand abzubilden.

D Artikel 5 Änderung Dritten Buches Sozialgesetzbuch

§§ 54a, 57 Einstiegsqualifizierung, Förderungsfähige Berufsausbildung

Die Leistungen der Ausbildungsförderung auch für die Pflegefachassistentenausbildung zu öffnen, wird ausdrücklich begrüßt. Dadurch können insbesondere Menschen, die sich grundsätzlich für die Pflegefachassistentenausbildung eignen durch gezielte Fördermaßnahmen, die Sprach- und Bildungsmaßnahmen im Vorfeld der Ausbildung unterstützt werden, was zur Entlastung der Ausbildungsträger führt. Ein besserer Einstieg in die Berufsausbildung minimiert auch die Gefahr von Ausbildungsabbrüchen.



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Ausschussdrucksache 21(13)9i vom 2. Oktober 2025

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung“

BT-Drucksache 21/1493

Christian Hener

Deutsches Rotes Kreuz e. V.

Berlin, 02. Oktober 2025

Stellungnahme des Deutschen Roten Kreuzes zum Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenten Ausbildung (PflFAssEinfG) – BT-Drs. 21/1493

A. Allgemeiner Teil

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Vorlage des Gesetzesentwurfs für ein Gesetz über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenten Ausbildung (PflFAssEinfG) außerordentlich. Wir bedanken uns für die Einladung zur öffentlichen Anhörung in den Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages und reichen hierzu begleitend die vorliegende Stellungnahme ein.

Zusammenfassung

Mit dem PflFAssEinfG beabsichtigt der Gesetzgeber die bundesweite Einführung einer einheitlich gestalteten Ausbildung zur Pflegefachassistenten mit 18-monatiger Dauer, was wir sehr begrüßen. Trotz eines hohen Bedarfs an qualifiziertem Personal unterhalb der Pflegefachausbildung sprechen wir uns als Deutsches Rotes Kreuz für die Beibehaltung der 18-monatigen Variante aus, gerade auch mit Blick auf das Berufsprofil, das deutlich über die reine Pflegehilfe hinausgeht. Gleichzeitig halten wir eine Ausbildungsdauer von 24 Monaten für zu lange, um den dringend benötigten Personalkörper in der Pflegefachassistenten effektiv, aber auch effizient aufbauen zu können. Besonders bedanken möchten wir uns für die Berücksichtigung der vereinsrechtlich organisierten Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz als Träger der praktischen Ausbildung.

Pflegefachassistenten – ein neues Berufsbild

Die Rolle der Pflegefachassistenten könnte den Skill- und Grade-Mix in der professionellen Pflege effektiv bereichern und gleichzeitig für neue Zielgruppen Zugänge in das Pflegebildungssystem eröffnen. Insofern trägt die Pflegefachassistenten Ausbildung nicht nur zu

mehr Versorgungssicherheit bei, sie führt auch zu mehr Bildungschancen, Sinnstiftung und Aufstiegsmöglichkeiten, was wir als DRK außerordentlich begrüßen.

Obendrein werden berufliche Kenntnisse und Vorerfahrungen anerkannt, was die Motivation, eine dementsprechende Ausbildung zu beginnen, gerade für berufserfahrene Pflegehelfende mit geringer oder fehlender Formalqualifikation, steigert. Aber auch für Arbeitgeber, die ihre Mitarbeitenden in ihrer Weiterentwicklung fördern und unterstützen wollen, ist dies attraktiv. Ebenso könnte die Pflegefachassistentenausbildung Pflegefachpersonen effektiv entlasten, um Räume für originäre Fachpersonenaufgaben im Kontext der Pflegeprozessverantwortung zu schaffen. Dies wäre auch ein Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Pflegefachpersonen.

Auf der anderen Seite besteht die Befürchtung, dass das neue Rollenbild der Pflegefachassistenz mit Aufgaben und Erwartungen überfrachtet wird, die am Ende nicht eingelöst werden können. Es ist daher sicherzustellen, dass weder die Auszubildenden noch die Absolventen der Pflegefachassistentenausbildung in ihrem Berufsalltag überfordert werden. Gerade weil in dem Entwurf die Aufgaben der Pflegefachassistenten mit denen der Pflegefachpersonen an manchen Stellen verschwimmen. Es erscheint daher geboten, eine größtmögliche Trennschärfe der jeweiligen Aufgabenprofile herbeizuführen, ohne jedoch in kleinteilige Tätigkeitskataloge zu verfallen.

Einordnung in einen umfassenden Skill- und Grade-Mix

Konzeptionell lässt sich die Pflegefachassistentenausbildung nahtlos in die bestehenden und in Entwicklung befindlichen Personalbemessungssysteme einfügen, was die Umsetzung in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern unterstützen dürfte. Aufgrund der Erfahrungen mit der bundeseinheitlichen Umsetzung des PeBeM in der stationären Langzeitpflege, die von den Bundesländern höchst unterschiedlich ausgestaltet wird, ist die durchgängige Anerkennung der Pflegefachassistentenausbildung nach dem PflFAssEinfG für das Level QN 3 auf der Landesebene sicherzustellen.

Gleichzeitig sind bundeseinheitlich harmonisierte Curricula eine Voraussetzung für die Zuordnung der verschiedenen Berufsabschlüsse in der Pflege zu spezifischen Qualifikationsniveaus, die zu definierten Kompetenzen und Befugnissen in der Leistungserbringung befähigen – von der Pflegefachassistenz bis hin zur Advanced Practice Nurse. Vor dem Hintergrund der jetzigen Heterogenität in der Frage „Wer darf was mit welcher Qualifikation?“ gilt es dafür Sorge zu tragen, dass die berufsrechtlichen Kompetenzen und Befugnisse der bundeseinheitlich ausgebildeten Pflegefachassistentenpersonen auch

tatsächlich konvergent im Leistungs- und Leistungserbringerrecht auf der Landesebene wirksam werden können.

Finanzielle Entlastung für pflegebedürftige Menschen

Generell zu begrüßen ist der Anschluss an die Finanzierungsmechanismen nach dem PflBG, wodurch erstmalig eine Ausbildungsvergütung sowie weitere Kosten der praktischen Ausbildung finanziert werden können. Dies macht die Pflegefachassistentenausbildung sowohl für die Auszubildenden als auch für die Pflegeeinrichtungen deutlich attraktiver.

Gleichzeitig ist zu befürchten, dass die finanziellen Belastungen für die pflegebedürftigen Menschen noch weiter zunehmen werden, gerade auch im Zusammenspiel mit der (notwendigen) Anbindung der hochschulischen Pflegeausbildung an die Ausbildungsfonds auf Landesebene. Hier gilt es entsprechende Entlastungsmechanismen zu finden. Als DRK wiesen wir bereits wiederholt auf die Einführung des sogenannten Sockel-Spitze-Tauschs für das SGB XI hin.

In einem ersten Schritt könnten zwischenzeitlich die mit den Ausbildungen in den Pflegeberufen verbundenen Kosten, die den Pflegebedürftigen in Rechnung gestellt werden, vollständig aus Mitteln des Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung finanziert werden.

Flexibilisierung der Praxisanleitung

Dasselbe gilt für die Einführung einer regelhaften Praxisanleitung von 10 % der praktischen Ausbildungszeit analog zur Pflegefachausbildung. Auch dies ist ein Fortschritt, der die Pflegefachassistentenausbildung attraktiver macht und die Ausbildungsqualität steigern wird.

Auf der anderen Seite werden aus unseren Gliederungen schon heute große Probleme in der Bereitstellung der geforderten Praxisanleitenden für die Pflegefachausbildung berichtet. Dies betrifft gerade kleine ambulante Pflegedienste im ländlichen Raum, die das entsprechende berufspädagogische Personal nicht vorhalten bzw. entsprechend häufig einsetzen können. Insofern wäre zu prüfen, inwiefern hier eine Flexibilisierung möglich ist, ohne Qualitätseinbußen befürchten zu müssen.

Mindestanforderungen für die Pflegeschulen dynamisieren

Aber auch die analog zur Pflegefachausbildung gehaltenen Mindestanforderungen an die Qualifikation des Lehrpersonals stellt die Pflegeschulen vor große Herausforderungen.

Während der Einsatz von Lehrenden auf Masterniveau für den theoretischen Unterricht bei der Ausbildung zur Pflegefachperson unbedingt nachvollzogen werden kann, teilen wir diese Auffassung gegenüber der Ausbildung zur Pflegefachassistenz nur bedingt.

Auch ein kompetenzorientierter Personaleinsatz kann nur begrenzt dabei helfen, die entsprechenden Qualifikationsvoraussetzungen für den theoretischen Unterricht zu erfüllen, denn eine zusätzliche, wenn auch kürzere Ausbildung, erfordert mehr Personal und kann nicht allein durch das bereits vorhandene Stammpersonal der Pflegefachausbildung kompensiert werden. Ebenso wird es nicht möglich sein, dass Pflegeschulen, die bereits eine Helferausbildung nach Landesrecht anbieten, ihr bestehendes Personal „so einfach“ weiterqualifizieren können. Denn die Studienplätze in den einschlägigen Masterstudiengängen sind stark begrenzt und müssen zudem bereits den Qualifikationszuwachs für die Pflegefachausbildung bewältigen.

Insofern wäre es wünschenswert, wenn die Länder hier abweichende Regelungen unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten zulassen und zusätzlich die Anzahl der Studienplätze im Bereich der Medizin- und Pflegepädagogik deutlich erhöhen. Ziel sollte ein empirisch begründeter und damit nachhaltiger Qualifikationszuwachs sein, der sich an den tatsächlichen Möglichkeiten des regionalen Arbeitsmarktes orientiert.

Quereintriege in die Berufspädagogik ermöglichen

Ein weiterer Baustein zum Personalaufbau in der Lehre der Pflegeausbildungen könnte in Kompetenzanerkennungsverfahren auf der Landesebene liegen, die berufserfahrenen und berufspädagogisch weiterqualifizierten Fachpersonen (z.B. mit einer Weiterbildung zur „Praxisanleitung“) den Quereinstieg in die Berufspädagogik ermöglichen.

Aktuell gibt es z. B. in Rheinland-Pfalz an den öffentlichen berufsbildenden Schulen die Möglichkeit für Quereinsteigende, eine sogenannte fachpraktische Lehrkraft zu werden. Der Zugang ist allerdings nur für Quereinsteigende möglich, die an einer öffentlichen Schule tätig werden. Hier würden wir uns eine Gleichstellung der trägergebundenen Schulen in den jeweiligen Schul- bzw. Berufsbildungsgesetzen auf Landesebene wünschen.

Ausbildungsverlauf mit der Pflegefachausbildung harmonisieren

Eine große Herausforderung ist sicher die Harmonisierung der Start- und Endzeitpunkte sowie der Ausbildungsinhalte der 18-monatigen Pflegefachassistentenausbildung mit denen der 36-monatigen Pflegefachausbildung.

Damit das Ende der Ausbildung zur Pflegefachassistenz mit dem Beginn der Ausbildung zur Pflegefachperson „matchen“ und auch inhaltlich aufeinander aufbauen kann, sind entsprechende Gestaltungsfreiheiten der Pflegeschulen notwendig, um keine unnötigen Lücken und Wartezeiten entstehen zu lassen. Die Bundesländer sollten hier die entsprechenden Voraussetzungen schaffen und die Pflegeschulen dazu befähigen, die Start- und Endpunkte der Ausbildungen im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung für den Ausbildungsverlauf (in definierten Korridoren) selbst zu bestimmen.

Das Gleiche gilt im umgekehrten Sinn für den Start der verkürzten Pflegefachassistenz-ausbildung durch Anrechnung von Vorerfahrung. Auch hier sind Gestaltungsspielräume der Pflegeschulen notwendig, um Wartezeiten und Lücken zu vermeiden.

Ferner gilt es sicherzustellen, dass die Verhandlungsrhythmen für die Vereinbarung der Pauschalbudgets miteinander korrelieren, um Mehraufwände und Doppelstrukturen zu vermeiden.

Schulsozialarbeit an den Pflegeschulen finanzieren

Die Partner der Ausbildungsinitiative Pflege haben gemeinsam vereinbart, dass die Pflegeschulen „Unterstützungsangebote zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen“ bereitstellen. Mit Ausnahme von Berlin fehlen allerdings bis heute die entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten für die Schulsozialarbeit auf der Landesebene.

Angesichts der Einführung der Pflegefachassistentenausbildung, die an den gleichen Pflegeschulen angeboten werden wird und deren Zielgruppen unserer Erfahrung nach hochkomplexe psychosoziale Unterstützungsbedarfe haben können, gilt es dies schnellstmöglich nachzuholen.

Darüber hinaus kommt der systematischen und regelhaften Finanzierung der Miet- und Investitionskosten (inklusive der Raumkosten) der Pflegeschulen eine hohe Bedeutung zu.

B. Besonderer Teil

Artikel 1: „Gesetz über die bundeseinheitliche Pflegefachassistenten-ausbildung“ (Pflegefachassistentengesetz – PflFAssG)

Als Deutsches Rotes Kreuz begrüßen wir die Entscheidung der Bundesregierung, eine bundeseinheitliche Pflegefachassistentenausbildung mit 18-monatiger Dauer einführen zu wollen.

Gleichwohl im Rahmen des Gesetzesverfahrens bereits einige wichtige Anpassungen zur Umsetzung erfolgten, möchten wir auf folgende, aus unserer Sicht weiterhin bestehende bzw. sich neu ergebende Änderungserfordernisse hinweisen.

Zu § 1: „Führen der Berufsbezeichnung“ in Verbindung mit § 50: „Fortgeltung der Berufsbezeichnung“

Mit dem Pflegefachassistenzgesetz soll ein bundeseinheitliches Berufsprofil für die Rolle der Pflegefachassistenz geschaffen werden, dass nach dem Willen des Gesetzgebers als eigenständiger Heilberuf im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG geregelt werden soll.

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt den Schritt hin zu einer bundesweit einheitlichen Pflegefachassistenzausbildung außerordentlich. Aus professionswissenschaftlicher Sicht kann hinterfragt werden, ob eine 18-monatige Ausbildung in einem Assistenzberuf tatsächlich dem Status eines Heilberufs nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG entspricht.

Wir befürworten es allerdings, dass dieser Status herbeigeführt werden soll, um dem Bund die Regelungskompetenz zu übertragen. Insofern erachten wir diesen Schritt als notwendig, damit die Pflegefachassistenzausbildung tatsächlich bundeseinheitlich geregelt werden kann. Für eine 12-monatige Pflegehilfeausbildung sehen wir den Status eines Heilberufs dagegen nicht gegeben.

Weiterhin wird befürchtet, dass die Rolle der Pflegefachperson durch die Schaffung eines weiteren Heilberufs in der beruflichen Pflege entwertet bzw. untergraben werden könnte. Die wenig trennscharfe Formulierung für die Aufgabenfelder der Pflegefachassistenz kann diese Besorgnis (noch) nicht zufriedenstellend auflösen. Letztlich muss der Abstand zwischen den Kompetenzniveaus der Pflegefach- und der Pflegefachassistenzausbildung ausreichend erkennbar und begründet sein, um sowohl der Professionalisierung als auch der intraprofessionellen Akzeptanz Rechnung zu tragen.

Dies gilt es gerade vor dem Hintergrund zu berücksichtigen, dass der Deutsche Qualifikationsrahmen nach wie vor die Pflegefachausbildung mit der Pflegefachassistenzausbildung gleichsetzt und unisono in das DQR-Niveau 4 einordnet. Unserer Ansicht nach wäre die Pflegefachassistenzausbildung maximal in das DQR-Niveau 3 einzuordnen, wie es auch aus der Qualifikationszuordnung nach § 113c SGB XI hervorgeht. Es ist zudem Sorge dafür zu tragen, dass die Namensgebung „Pflege-fach-assistenz“ zu keinen Trugschlüssen gegenüber der assistierenden Funktion dieses Berufsbildes führt.

Positiv zu bewerten sind dagegen die Bestandschutzregelungen nach § 50. Das DRK begrüßt außerordentlich, dass sich diese nunmehr nicht mehr ausschließlich auf Ausbildungen beziehen, die unter die „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu

Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ fallen, sondern auch solche umschließt, die auf einer mindestens einjährigen, landesrechtlich geregelten Assistenz- oder Helferausbildung beruhen. Als DRK haben wir dies in unserer Stellungnahme aus 2024 empfohlen. Die entsprechende Klarstellung trägt unserer Ansicht nach dazu bei, einen durchgängigen Bestandschutz für bisher nach dem Level QN 3 anerkannte Assistenz- und Helferausbildungen auf der Landesebene sicherzustellen.

Zu § 2: „Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis“ in Verbindung mit § 3: „Rücknahme, Widerruf und Ruhen der Erlaubnis“

Die Regelungen zur gesundheitlichen Eignung für eine Berufstätigkeit im Gesundheits- und Pflegewesen finden sich in den Berufsgesetzen von so gut wie allen Gesundheitsfachberufen wieder, so auch in dieser Vorschrift. Sie sind allgemein akzeptiert, und selbstverständlich ist es evident, dass der Gesundheitsschutz der anvertrauten pflegebedürftigen Menschen höchste Priorität genießen muss.

Beeinträchtigungen des Gesundheitsstatus werden in der Gesetzesbegründung primär mit dem Merkmal der Behinderung in Verbindung gebracht, um den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention zu entsprechen. Darüber hinausgehende Angaben werden nicht gemacht. Letztlich ist es daher an Ärztinnen und Ärzten, die gesundheitliche Eignung mittels einer Bescheinigung festzustellen. Unklar bleibt auch, wie damit umzugehen ist, wenn die gesundheitliche Eignung im Laufe des Lebens aberkannt wurde, wie in § 3 Absatz 2 beschrieben. Es fehlen Hinweise, wie die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung wiedererlangt werden kann, beispielsweise nach erfolgreicher (Dauer-)Therapie oder Rehabilitation.

Häufig geht mit der Beurteilung der gesundheitlichen Eignung eine Testung auf das HI-Virus einher. Umgekehrt gilt eine bestätigte HIV-Infektion bis heute noch vielerorts als ein Kriterium dafür, um von einer Berufstätigkeit im Gesundheits- und Pflegewesen ausgeschlossen zu werden. Als Deutsches Rotes Kreuz sind wir Erstunterzeichner der Aktion #positivarbeiten der Deutschen Aidshilfe, die über die Möglichkeiten einer beruflichen Tätigkeit trotz HIV-Infektion aufklärt¹. Demnach könnten Menschen mit HIV grundsätzlich jede Arbeit wahrnehmen, auch im Gesundheits- und Pflegebereich, da für eine Übertragung im beruflichen Alltag kein Risiko bestehe. Unter Therapie, die heutzutage der Regelfall ist, wäre eine Übertragung sogar bei intensiver Exposition und Kontakt mit infektiösem Material ausgeschlossen.

Vor dem Hintergrund, dass der HIV-Status der Deutschen Aidshilfe zufolge keine Relevanz für eine berufliche Tätigkeit habe, setzen wir uns dafür ein, dass weder freiwillige noch verpflichtende HIV-Testungen für die Bestimmung der gesundheitlichen Eignung nach §§ 2

und 3 herangezogen bzw. verlangt werden dürfen. Darin eingeschlossen sind Einstellungsuntersuchungen oder arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen. Eine Ausweitung dieses Vorschlags auf korrespondierende Vorschriften der Berufsgesetze weiterer Gesundheitsfachberufe wäre wünschenswert.

Zu § 4: „Ausbildungsziel“

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Aufnahme der sogenannten Behandlungspflege in das Aufgabenportfolio der Pflegefachassistentenpersonen außerordentlich. Durch die Möglichkeit der Weiterdelegation von ärztlich initiierten medizinisch-pflegerischen Maßnahmen der Behandlungspflege können Pflegefachpersonen effektiv entlastet und die Versorgungssicherheit in strukturschwachen oder weitläufigen Räumen verbessert werden.

Durch die freiwerdenden Ressourcen könnten Pflegefachpersonen wieder mehr Zeit für ihre originären Aufgaben verwenden, wie z. B. die Verantwortung des Pflegeprozesses, die Anleitung, Schulung und Beratung, oder die Durchführung von komplexen medizinisch-pflegerischen Interventionen der ärztlichen Therapie und Diagnostik. Gleichzeitig gilt es sicherzustellen, dass die Auszubildenden und Absolvierenden der Pflegefachassistentenausbildung vor Überforderung und Missbrauch geschützt werden, indem klare Aufgabenbeschreibungen und Delegationskriterien vorgelegt werden und delegierte Aufgaben auch in nachvollziehbar begründeten Fällen abgelehnt und zurückgewiesen werden können.

Die konkrete Auflistung der einzelnen Aufgaben in Absatz 3 erscheint angesichts der vorgesehenen Ausbildungsdauer in der Gesamtschau etwas überambitioniert. Hier wird es auf die konkrete Ausdifferenzierung und Definition durch die Fachkommission nach § 53 PflBG ankommen. Auffällig ist die Verwendung vieler unbestimmter Begrifflichkeiten, die einen hohen Interpretationsspielraum hinterlassen und unbedingt konkretisiert werden sollten. Dies betrifft insbesondere die Verwendung der Begriffe „nicht komplex“ und „komplex“, die als Unterscheidungsmerkmale für die Zuordnung der Aufgaben zu den jeweiligen Berufsbildern dienen sollen (nicht komplex = Pflegefachassistent; komplex = Pflegefachperson). Diese Syntax hat jedoch schon bei der Abgrenzung zwischen den Berufsbildern der beruflich und der hochschulisch ausgebildeten Pflegefachpersonen zu Problemen geführt² und sich damit bereits als ungeeignet erwiesen. Gleichzeitig ist die Weiterführung dieser Systematik irgendwo auch nachvollziehbar. Wir empfehlen trotzdem eine Nachschärfung der Begrifflichkeiten, um die Handlungssicherheit für die Praxis zu stärken.

Dasselbe gilt für die Formulierung der Aufgabe: „ärztlich angeordnete, zur Übertragung geeignete Maßnahmen nach Übertragung durch die Ärztin oder den Arzt oder nach Weiterübertragung durch die Pflegefachpersonen eigenständig durchzuführen“. Mutmaßlich

versteckt sich hierunter die eigenständige Durchführung von (weiter-)delegierter Behandlungspflege. Auch hier möchten wir unbedingt zur Nachschärfung raten, da aus dem GesE bislang nicht hervorgeht, welche medizinisch-pflegerischen Interventionen der Behandlungspflege tatsächlich gegenüber der Pflegefachassistenz delegationsfähig sein können, und dies im Grunde auch nicht durch die Fachkommission bestimmt werden kann. Ebenso sollte antizipiert werden, wie sich die mit dem BEEP geplanten Befugniserweiterungen der Pflegefachpersonen auf die intraprofessionelle Zusammenarbeit auswirken, insbesondere im Hinblick auf die eigenverantwortliche Ausübung von ehemals Ärztinnen und Ärzten vorbehaltenen Tätigkeiten und deren Delegationsfähigkeit an die Pflegefachassistenz.

Verantwortlich für die Pflegeprozesssteuerung, und damit auch für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinisch-pflegerischen Versorgung, worunter insbesondere auch die Delegation einzelner Maßnahmen an nachgeordnete Qualifikationslevel gehört, sind gemäß § 4 PflBG alleinig nach dem PflBG ausgebildete oder gleichgestellte Pflegefachpersonen. Das Recht auf die Ausübung der Vorbehaltsaufgaben in der professionellen Pflege gilt es auf allen Ebenen des Gesundheits- und Pflegesystems zu ermöglichen und zu schützen.

Insofern führt die Frage nach der Delegationsfähigkeit der sogenannten Behandlungspflege auf die Pflegefachassistenz im Kontext der vorbehaltenen Aufgaben der professionellen Pflege zu einer weiteren Problematik. Denn gerade die HKP-Richtlinie widerspricht dem Grundsatz der Vorbehaltsaufgaben nach § 4 PflBG, wonach ärztliche Anordnungen oder Verordnungen die Verantwortung der Pflegefachpersonen für die Organisation, Steuerung und Gestaltung des Pflegeprozesses nicht einschränken dürfen. Dies ist jedoch durch die ärztliche Festlegung von Dauer und Häufigkeit von Leistungen der häuslichen Krankenpflege definitiv der Fall³.

Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass die umfangreich gestalteten Aufgaben der Pflegefachassistenzpersonen zu einer weiteren Fragmentierung der pflegerischen Versorgung führen könnten, insbesondere im Bereich der ambulanten Pflege. Dem gilt es durch die Förderung der Kompetenzen zur Verantwortung des Pflegeprozesses für Pflegefachpersonen entgegenzuwirken, beispielsweise im Rahmen staatlich geförderter Programme zur Umsetzung und Implementierung in die Praxis, wie es das BEEP bereits vorsieht.

Änderungsbedarfe

Artikel 1 § 4 Absatz 2 Satz 1 PflFAssEinfG ist wie folgt zu ändern:

*(2) Pflege im Sinne des Absatzes 1 umfasst präventive, **gesundheitsfördernde**, kurative, rehabilitative, palliative und sozialpflegerische Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung,*

Wiedererlangung oder Verbesserung der physischen, *kognitiven* und psychischen Situation der zu pflegenden Menschen, ihre Beratung sowie ihre Begleitung in allen Lebensphasen und die Begleitung Sterbender.

Artikel 1 § 4 Absatz 3 Nummer 1 PflFAssEinfG ist wie folgt zu ändern:

(3) Die Ausbildung soll insbesondere dazu befähigen:

1. die folgenden Aufgaben unter *Beachtung Berücksichtigung und Anerkennung* der Pflegeprozessverantwortung einer Pflegefachperson nach dem Pflegeberufgesetz in nicht komplexen Pflegesituationen selbstständig durchzuführen und in komplexen Pflegesituationen an ihrer Durchführung *unter Anleitung und Aufsicht einer Pflegefachperson nach dem PflBG* mitzuwirken:

Artikel 1 § 4 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b) PflFAssEinfG ist wie folgt zu ändern:

b) Durchführung von ~~körpernahen~~ körperbezogenen Pflegemaßnahmen,

Zu § 5: „Dauer und Struktur der Ausbildung“ in Verbindung mit *Artikel 2: „Änderung des Pflegeberufgesetzes“*

Die Struktur der Pflegefachassistentenausbildung, die die generalistische Ausrichtung der Ausbildung zur Pflegefachperson nach dem PflBG aufgreift und konsequent weiterführt, ist unbedingt zu begrüßen. Diesen Weg gilt es folgerichtig bei der Ausgestaltung der Rahmenlehrpläne wie auch den entsprechenden Regelungen zur Zulassung der Ausbildungsstätten fortzusetzen und weiterzuverfolgen.

Im Hinblick auf die in § 62 PflBG vorgesehene „Überprüfung der Vorschriften über die Berufsabschlüsse in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie in der Altenpflege“ im Jahr 2025 gilt es daher, ungeachtet der Einwände der sich schon jetzt formierenden Interessensgruppen, an der generalistischen Ausrichtung der Pflegefachausbildung nach dem PflBG festzuhalten.

Es macht keinen Sinn, das sich langsam harmonisierende Qualifikationsgefüge in der beruflichen Pflege an diesem neuralgischen Punkt wieder durcheinander zu werfen. Die generalistische Pflegeausbildung hat sich längst bewährt und in der Praxis etabliert, wie auch die Daten von Destatis nahelegen⁴: Demnach haben sich 99 % der Auszubildenden bislang gegen einen spezialisierten Abschluss und für die Fortführung der generalistischen Pflegeausbildung entschieden.

Gleichzeitig sollte darauf geachtet werden, dass die Auszubildenden der Pflegefachassistenz unbedingt den größten Teil ihrer Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung verbringen. Dem kommt die begrüßenswerte Ergänzung in Absatz 3 nach, die regelt, dass (geringe) Anteile der praktischen Ausbildung nicht mehr länger nur an den Pflegeschulen durch praktische Lerneinheiten ersetzt werden können, sondern auch durch solche bei dem Ausbildungsträger. Die äquivalente Anpassung in § 6 Absatz 3 PflBG begrüßen wir sehr.

Zu § 7: „Träger der praktischen Ausbildung“ in Verbindung mit **Artikel 10: **„Änderung des DRK-Gesetzes“****

Die vereinsrechtlich organisierten Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz gehören zum ältesten Teil der Rotkreuzbewegung und beteiligen sich seit jeher an der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegefachpersonen und nachgeordneten Pflegerollen in Haupt- und Ehrenamt.

Insofern ist es außerordentlich zu begrüßen, dass die DRK-Schwesternschaften durch eine Änderung des DRK-Gesetzes zur Trägerschaft der praktischen Ausbildung für die Pflegefachassistentenausbildung mandatiert werden.

Die vorgesehene Änderung orientiert sich im Wortlaut an § 2 Absatz 5 DRKG, der den vereinsrechtlich organisierten Schwesternschaften vom DRK die Trägerschaft der praktischen Ausbildung für die Pflegefachausbildung nach dem PflBG erlaubt. Es besteht daher kein Änderungsbedarf.

Zu § 8: „Mindestanforderungen an Pflegeschulen“ in Verbindung mit § 51: „Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestandschutz“

Das Deutsche Rote Kreuz bewertet die umfassenden Übergangs- und Bestandschutzregelungen für das Lehrpersonal an den Pflegeschulen äußerst positiv. Einbrüche in den Ausbildungskapazitäten sind damit zunächst nicht zu vermuten. Allerdings gilt es, die Intention der Regelungen zu den Übergängen und zum Bestandschutz dann auch konsequent auf der Landesebene einzuhalten, wobei es unerheblich sein muss, ob es sich um eine staatliche oder staatlich anerkannte Pflegeschule handelt.

Gleichzeitig stellen die analog zur Pflegefachausbildung gehaltenen Mindestanforderungen an die Qualifikation des Lehrpersonals die Pflegeschulen vor große Herausforderungen. Selbst ein kompetenzorientierter Personaleinsatz innerhalb einer Pflegeschule, die sowohl eine Ausbildung nach dem PflBG als auch nach dem PflFAssG anbietet, kann nur begrenzt dabei helfen, die entsprechenden Qualifikationsvoraussetzungen für den theoretischen Unterricht zu

erfüllen. Denn eine zusätzliche, wenn auch kürzere Ausbildung erfordert mehr Personal und kann nicht vollständig durch eine Personalunion des bereits vorhandenen Stammpersonals der Pflegefachausbildung kompensiert werden.

Während der Einsatz von Lehrenden auf Masterniveau für den theoretischen Unterricht bei der Pflegefachausbildung nach dem PflBG unbedingt nachvollzogen werden kann, ist dies vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs an Pflegefachassistenzpersonen in der Versorgung, der weit über das bestehende Angebot der landesrechtlich geregelten Helferausbildungen hinausgeht, für die Ausbildung zur Pflegefachassistenz kritisch zu hinterfragen.

Denn dies würde gerade der Neugründung von Ausbildungsgängen nach dem PflFAssG im Weg stehen und den dringend benötigten Personalaufwuchs im Bereich der Pflegefachassistenz (Stichwort: Umsetzung PeBeM) ausbremsen. Ebenso wird es nicht möglich sein, dass Pflegeschulen, die bereits eine Helferausbildung nach Landesrecht anbieten, ihr bestehendes Personal „so einfach“ weiterqualifizieren können, denn die Studienplätze in den einschlägigen Masterstudiengängen sind stark begrenzt und müssen zudem bereits den Qualifikationszuwachs für die Pflegefachausbildung bewältigen. Insofern wäre es wünschenswert, wenn die Länder hier abweichende Regelungen unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten zulassen und zusätzlich die Anzahl der Studienplätze im Bereich der Medizin- und Pflegepädagogik sowie weiterer zulässiger Studiengänge deutlich erhöhen.

Dies betrifft insbesondere das Masterniveau, das ein Nadelöhr in allen gesundheits-, therapie- und pflegewissenschaftlichen Studiengängen darstellt. Ziel sollte ein empirisch begründeter und damit nachhaltiger Qualifikationszuwachs sein, der sich an den tatsächlichen Möglichkeiten vor Ort orientiert und auch von Sonderregeln im Hinblick auf die Versorgungssicherheit Gebrauch macht. Grundsätzlich sollte bei der Ressourcenallokation des Lehrpersonals auf Masterniveau die Pflegefachausbildung begünstigt und die Pflegefachassistentenausbildung nachgestellt werden. Ein Abschluss des geforderten Qualifikationsaufwuchses in der Pflegefachassistentenausbildung bis zum 31. Dezember 2035 erscheint vor dem Hintergrund des Parallelprozesses in der Pflegefachausbildung, der ebenso vor erheblichen Schwierigkeiten in Bezug auf die Zielerreichung steht, nicht realistisch und ist daher mittelfristig anzupassen.

Ein weiteres Instrument zur Steigerung des Lehrpersonals für die Pflegefach- und Pflegefachassistentenausbildung könnte die Schaffung von Wegen und Zugängen für Quereinsteigende durch Kompetenzanerkennungsverfahren auf der Landesebene sein. In Rheinland-Pfalz besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass Quereinsteigende eine Berufstätigkeit an einer Pflegeschule als sogenannte fachpraktische Lehrkraft aufnehmen können. Dies gilt aktuell jedoch leider nur für die berufsbildenden Schulen in öffentlicher

Trägerschaft. Es wäre daher wünschenswert, wenn solche und ähnliche Möglichkeiten des Personalaufbaus für die Lehre in den Pflegeausbildungen bundesweit genutzt werden könnten und eine Gleichstellung für Pflegeschulen in freigemeinnütziger oder privater Trägerschaft erfolgt.

Begrüßenswert ist dagegen die Ergänzung in Absatz 1 Nummer 3, wonach „den Belangen von Menschen mit Behinderungen [...] Rechnung zu tragen [ist]“. Hier wäre lediglich eine Erweiterung des Personenkreises, auf Menschen, deren Förderbedarf unterhalb eines Grades der Behinderung liegt, wünschenswert. Gleichzeitig muss die Finanzierung der entsprechenden Kostenarten gesichert sein, insbesondere, wenn den Belangen der Menschen mit Behinderungen und Förderbedarfen durch Schulsozialarbeitende Rechnung getragen wird.

Änderungsbedarfe

Artikel § 8 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 PflFAssEinfG wird wie folgt geändert:

*(1) 3. [...] Den Belangen von Menschen mit Behinderungen **und Förderbedarfen** ist Rechnung zu tragen.*

Artikel 1 § 8 Absatz 3 Satz 2 PflFAssEinfG wird wie folgt geändert:

*(3) [...] Sie können für die Lehrkräfte für die Durchführung des theoretischen **und praktischen** Unterrichts nach Absatz 1 Nummer 2, **zunächst** befristet bis zum 31. Dezember 2035 regeln, inwieweit die erforderliche Hochschulausbildung nicht oder nur für einen Teil der Lehrkräfte auf Master- **bzw. Bachelor-** oder vergleichbarem Niveau vorliegen muss.*

Zu § 9: „Gesamtverantwortung der Pflegeschule“

Die Regelungen zur Gesamtverantwortung der Pflegeschule entsprechen weitgehend den korrespondierenden Vorschriften nach § 10 PflBG und erscheinen daher sachgemäß.

Im Gegensatz zu einer jährlich beginnenden und endenden Ausbildung besteht bei der 18-monatigen Ausbildung zur Pflegefachassistenz allerdings das Problem, den Start, das Ende und die Ausbildungsinhalte so mit der 36-monatigen Pflegefachausbildung zu verzahnen, dass weder unnötige Wartezeiten entstehen noch die Durchlässigkeit zur Pflegefachausbildung (und wieder zurück) gefährdet ist.

Dazu kommt dann noch die Herausforderung, die bestehenden Möglichkeiten zur Anerkennung vorhandener Kenntnisse und Erfahrungen in vollem Umfang nutzen zu können,

sowohl im Hinblick auf eine Verkürzung der Pflegefachassistentenausbildung bei vorzeitig beendeter Pflegefachausbildung als auch umgekehrt für den reibungslosen Eintritt in eine verkürzte Pflegefachausbildung nach erfolgreich beendeter Ausbildung zur Pflegefachassistenz.

Damit dieses Konglomerat an unterschiedlichen Chancen und Möglichkeiten in der Praxis zielführend zur Anwendung kommen kann, sind hier funktionale Gestaltungsfreiheiten für die Pflegeschulen notwendig. Wünschenswert wäre die Schaffung entsprechender Voraussetzungen auf der Landesebene, die die Pflegeschulen dazu befähigen, die für eine sinnvolle Harmonisierung erforderlichen Parameter, wie Start- und Endpunkte, sowie die curricularen Inhalte im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung für den Ausbildungsverlauf (in definierten Korridoren) selbst zu bestimmen.

Unterstützt werden könnte dies durch eine entsprechend kompatible Ausgestaltung der Rahmenlehrpläne durch die Fachkommission nach § 53 PflBG. Überaus hilfreich wäre in diesem Zusammenhang eine Musterhandreichung, in der unterschiedliche Möglichkeiten für ein durchlässiges Über- bzw. Zurückgleiten von der einen in die andere Ausbildung beschrieben wird (Stichwort: Bildungsweg).

Änderungsbedarfe

In Artikel 1 PflFAssEinfG wird in § 9 unter Absatz 2 ein neuer Absatz 3 eingefügt:

(3) Im Rahmen der Gesamtverantwortung für die Koordination des Ausbildungsverlaufs hat die Pflegeschule das Recht, die Start- und Endpunkte sowie die curricularen Inhalte der Ausbildung nach dem PflFAssG an die Ausbildung nach dem PflBG anzulehnen, sofern dies einem barrierearmen Übergang von der einen in die andere Ausbildung dient. Dies gilt im Besonderen in Verbindung mit den Regelungen nach § 10 und § 11 dieses Gesetzes.

Zu § 10: „Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung“ in Verbindung mit § 11: „Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen und Berufserfahrung“ und § 44 „Erarbeitung von Rahmenlehrplänen; Vorbereitungskurs“ sowie § 45: „Beratung; Aufbau unterstützender Angebote und Forschung“ und § 53: „Evaluierung“

Als Deutsches Rotes Kreuz begrüßen wir die Öffnung der Pflegefachassistentenausbildung auch für Zielgruppen, denen bislang kein (flächendeckender) Zugang zu einer Ausbildung in der beruflichen Pflege möglich war. Insofern trägt die Pflegefachassistentenausbildung nicht nur zu

einer Stärkung der Versorgung und Entlastung von Pflegefachpersonen bei, sie bringt obendrein höhere Bildungschancen und Aufstiegsmöglichkeiten mit sich, was wiederum die gesellschaftliche Partizipation und letztlich auch Solidarität stärken kann.

Kritisch angemerkt werden muss jedoch, dass nicht jede motivierte Person, ob mit oder ohne allgemeinbildenden Schulabschluss, für eine berufliche Ausbildung und Tätigkeit in der Pflegefachassistenz geeignet ist. Die entsprechenden Mechanismen zum Schutz der zu pflegenden Menschen, bestehend aus Bewerbungsverfahren und Prognose durch die Pflegeschule, halten wir an dieser Stelle jedoch für ausreichend.

Wünschenswert wäre, wenn im Rahmen der Pflegefachassistentenausbildung ein allgemeinbildender Schulabschluss erworben werden könnte, wie dies zurzeit bei einigen Helfer- und Assistentenausbildungen nach Landesrecht der Fall ist. Sehr begrüßt wird hingegen die Ergänzung in § 11 PflBG, wonach eine abgeschlossene Ausbildung nach dem Pflegefachassistentengesetz den Zugang in die Pflegefachausbildung ermöglicht. Hier wäre lediglich noch klarzustellen, dass dies auch diejenigen umfasst, die die Ausbildung zur Pflegefachassistenz ohne Schulabschluss und mit positiver Eignungsprognose durch die Pflegeschule absolviert haben.

Ebenso gehen mit jeder Ausbildungsverkürzung wichtige didaktisch aufbereitete Lernerfahrungen verloren, was aus berufspädagogischer Sicht nachvollziehbar kritisiert wird. Vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs an Pflegefachassistentenpersonen, die ungeachtet berechtigter fachlicher Einwände benötigt werden, um die medizinisch-pflegerische Versorgung heute und auch in Zukunft sicherzustellen, sehen wir aber in der Gesamtschau keine echte Alternative, als alles dafür zu tun, dass motivierte Menschen Zugänge zu einer Ausbildung in der Pflege erhalten. Insofern bewerten wir die Anrechnungszeiten zur Verkürzung der Pflegefachassistentenausbildung nach §§ 10 und 11 als sachgerecht, auch wenn wir uns in einer idealen Welt mehr Zeit für das Lernen und die Kompetenzentwicklung wünschen würden.

Besonders zu würdigen ist in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, auf Antrag bei der zuständigen Behörde die vollständige Anrechnung einer vorzeitig beendeten Pflegefachausbildung auf die Ausbildungsdauer der Pflegefachassistenz erwirken zu können, sofern die Zwischenprüfung nach dem PflBG bestanden wurde und das Erreichen des Ausbildungsziels nicht gefährdet war. Dies war eine langjährige Forderung des DRK und der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege.

Positiv zu bewerten ist weiterhin, dass das BIBB Empfehlungen für die Prognoseentscheidung der Pflegeschulen nach § 10 Absatz 2 und zusätzlich für das Kompetenzfeststellungsverfahren nach § 11 Absatz 1 Nummer 3 erarbeiten soll, hier gemeinsam mit der Fachkommission nach § 53 PflBG. Die Fachkommission soll darüber hinaus, neben den Rahmenlehrplänen für die

Pflegefachassistentenausbildung, einen gesonderten Rahmenlehrplan für die auf 320 Stunden verkürzte Ausbildung nach § 11 Absatz 2 (sogenannter Vorbereitungskurs) erstellen, was der Qualitätssicherung im Fall der Anrechnung von Berufserfahrung nach § 11 Abs. 2 Nummer 2 sicher entgegenkommen wird.

Gleichzeitig sollen die den Träger der praktischen Ausbildung, den Ausbildungsvertrag und die Ausbildungsvergütung betreffenden Vorschriften im Falle des Vorbereitungskurses keine Anwendung finden, sodass hier eine mögliche Finanzierungslücke für die Einrichtungen (Personalausfallskosten), aber auch die Auszubildenden (Einkommenseinbußen) zu befürchten ist, gerade wenn diese arbeitssuchend sind, oder sich beruflich neu orientieren. Eine entsprechende Kostentragung des Vorbereitungskurses durch die Förderinstrumente der beruflichen Weiterbildung wäre daher wünschenswert.

Es ist zudem zu begrüßen, dass die Regelungen nach §§ 10 Absatz 2 und 11 Absatz 2 zum 31. Dezember 2031 evaluiert werden sollen, sodass hier, bei Bedarf, nachgesteuert werden kann. Allerdings hat es für die Pflegeschulen eine hohe Bedeutung, dass die entsprechenden Rahmenlehrpläne rechtzeitig vorliegen, um ausreichend Zeit für die curriculare Arbeit zu haben. Die baldige Vorlage der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Pflegefachassistentenausbildung ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Pflegefachassistentenausbildung bereits 2027 von möglichst vielen Pflegeschulen angeboten werden kann.

Gleichzeitig sollte zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Familie die Ausbildung zur Pflegefachassistentenz flächendeckend in Teilzeit angeboten werden. Anders als bei der Ausbildung zur Pflegefachperson vermuten wir hier eine höhere Nachfrage, insbesondere seitens der Einrichtungen, die berufserfahrene Mitarbeitende aus der Gruppe der gering oder unqualifizierten Pflegehelfenden weiterqualifizieren wollen.

Die Gleichstellung bei den Anrechnungszeiten der beruflichen Vorerfahrung nach §§ 10 und 11 von den in Teilzeit arbeitenden Personen mit den in Vollzeit Tätigen gilt es wiederum sehr zu begrüßen. Dies hatten wir als DRK in unserer Stellungnahme aus 2024 empfohlen, da hierdurch Ausbildungswege für Menschen geschaffen werden können, die aufgrund von familiären Verpflichtungen bislang nur in Teilzeit in der Pflege arbeiten konnten.

Zu § 12: „Anrechnung von Fehlzeiten“

In den jetzigen landesrechtlichen Ausbildungen zur Pflegehilfe/Pflegeassistentenz besteht die Erfahrung, dass die Schülerinnen und Schüler im Mittel höhere Krankheitstage haben als diejenigen, die sich in der Ausbildung zur Pflegefachperson befinden.

Die Auszubildenden in der zukünftigen Pflegefachassistentenausbildung werden sich zu einem Großteil aus einem anderen sozialen Milieu rekrutieren als jene, die sich in der Pflegefachausbildung befinden. In der Gesundheitswissenschaft ist der Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Status und Gesundheitszustand evident, auch bereits bei Jugendlichen⁵.

Das DRK setzt sich daher für die Erhöhung der Fehlzeiten auf jeweils 20 % ein.

Änderungsbedarfe

Artikel 1 § 12 Absatz 1 Nummer 2 PflFAssEinfG wird wie folgt geändert:

2. *Fehlzeiten wegen Krankheit oder aus anderen, von der auszubildenden Person nicht zu vertretenden Gründen*
 - a) *bis zu ~~10-20~~ Prozent der Stunden des theoretischen und praktischen Unterrichts sowie*
 - b) *bis zu ~~10-20~~ Prozent der Stunden der praktischen Ausbildung nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung,*

Zu § 47: „Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Finanzierung; Verordnungsermächtigung“

Auch diese Regelungsinhalte entsprechen überwiegend den korrespondierenden Vorschriften nach § 56 PflBG. Einzig in Absatz 1 Nummer 1 fehlt eine Ergänzung der Aufzählung, die in der Variante nach dem PflBG jedoch enthalten ist. Dies bitten wir entsprechend anzupassen.

Änderungsbedarfe

Artikel 1 § 47 Absatz 2 Nummer 2 PflFAssEinfG wird wie folgt geändert:

1. *die Mindestanforderungen an die Ausbildung nach diesem Gesetz, **die Berücksichtigung digitaler Lehrformate sowie genderspezifische Kompetenzvermittlung,***

Artikel 2: „Änderung des Pflegeberufgesetzes“

Zu § 9: „Mindestanforderungen an Pflegeschulen“

Das DRK begrüßt die Verlängerung der Übergangsregelungen für die Qualifikation des Lehrpersonals an den Pflegeschulen bis 2035, die somit an die Regelungen nach dem PflFAssG angeglichen werden.

Dies trägt einerseits der Situation auf dem Arbeitsmarkt in der Medizin- und Pflegepädagogik Rechnung und eröffnet andererseits die Möglichkeit, das Bestandspersonal berufsbegleitend weiter zu qualifizieren.

Gleichzeitig verhindert die Angleichung der Frist unnötige Bürokratie und Administration für die Pflegeschulen, zumal es sich in vielen Fällen um die gleichen Personen handeln wird, die sowohl in der einen als auch der anderen Ausbildung tätig sind.

Artikel 5: „Änderung der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung“

Zu § 4: „Unterschiedliche Pauschalen bei Pauschalbudgets“

Die Differenzierung der Pauschalen nach § 4 Abs. 2 der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung hat sich in der Praxis bewährt, um z. B. auf strukturelle Herausforderungen eines „Flächenlandes“ angemessen reagieren zu können.

Eine Differenzierung der Pauschalen ist aktuell möglich, wenn die Differenzierung nach sachgerechten, allgemeinen, objektiven und für alle Träger der praktischen Ausbildung oder für alle Pflegeschulen nach gleichen Kriterien erfolgt. So haben ambulante Pflegedienste zumeist weniger Praxisanleitende als Krankenhäuser und benötigen deshalb kürzere Abschreibungszeiten beim Weiterbildungsaufwand zur Qualifizierung der Praxisanleitenden. Bei Pflegeschulen kann dagegen die Berücksichtigung der Schulgröße den Erhalt von kleineren Pflegeschulen in ländlichen Räumen erleichtern.

Die ursprüngliche, mit der Befristung der sogenannten differenzierten Pauschalen verbundene Befürchtung, dass sich hierdurch eine strukturelle Benachteiligung der Langzeitpflege ergeben könnte, hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Als Deutsches Rotes Kreuz sprechen wir uns daher für eine Entfristung der Regelung nach § 4 Abs. 2 PflAFinV aus.

Die in dem GesE vorgesehene Fristverlängerung bis zum Jahr 2030 halten wir hingegen für unzureichend, da die Grundproblematik hierdurch lediglich verschoben wird.

Änderungsbedarfe

Artikel 5 § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

(2) Eine Differenzierung der Pauschalen für einen Kostentatbestand nach Art der Ausbildung ist zulässig. Im Übrigen ist sie ~~nur bis zum Festsetzungsjahr 2030 zulässig und nur dann~~ zulässig, wenn die Differenzierung nach sachgerechten, allgemeinen, objektiven und für alle Träger der praktischen Ausbildung oder für alle Pflegeschulen gleichen Kriterien erfolgt. Unzulässig ist insbesondere eine Differenzierung nach ~~Versorgungsbereichen oder~~ Trägerstrukturen ohne einen sachlichen Grund.

Zu Anlage 1: Kosten der Träger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschulen ohne Berücksichtigung der Ausbildungsvergütung

Die Pflegeschulen aus den DRK-Gliederungen berichten über intensivierte psychosoziale Problemlagen vieler Auszubildender, denen das Lehrpersonal allein nicht mehr gewachsen ist. Sie sehen einen hohen Bedarf für Schulsozialarbeit, um den Ausbildungserfolg für Schülerinnen und Schüler in herausfordernden Lebenslagen zu gewährleisten.

Allerdings fehlt dafür bis heute eine systematische Finanzierungsmöglichkeit. Angesichts der Einführung der Pflegefachassistentenausbildung, die an den gleichen Pflegeschulen angeboten werden wird, ist dies jedoch dringend erforderlich. Beispielsweise legen unsere Erfahrungen mit dem Programm „Assistierte Ausbildung in der Pflegehilfe“⁶ aus Sachsen-Anhalt nahe, dass die Auszubildenden in der Pflegehilfeausbildung hochkomplexe psychosoziale Unterstützungsbedarfe haben (bis hin zur drohenden Wohnungslosigkeit), die die Möglichkeiten der Ausbildungsinstitute wie auch der Ausbildungsträger weit überschreiten.

Das Land Berlin schreibt als erstes Bundesland die Vorhaltung von Schulsozialarbeitenden an den Pflegeschulen vor, weshalb es gelungen ist, diese Kosten der Pflegeschulen durch den Ausbildungsfonds auf Landesebene geltend zu machen. In anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern wurde die Finanzierungsfähigkeit der Schulsozialarbeit durch die Ausbildungsfonds allerdings abgestritten.

Dazu kommt, dass die Pflegeschulen in vielen Bundesländern nicht unter das Schulrecht fallen und damit formal aus den Landesschulgesetzen ausgeschlossen sind. Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft haben dagegen die Möglichkeit, die schulpсихologischen Dienste der Länder zu nutzen, die außerhalb der Pauschalbudgets nach dem PflBG finanziert werden. Hier sollte eine Gleichstellung der trägerbezogenen Pflegeschulen erfolgen, gerade weil eine Ergänzung in § 8 vorsieht, dass „den Belangen von Menschen mit Behinderungen [...] Rechnung zu tragen [ist]“.

In der Ausbildungsinitiative Pflege haben sich die unterzeichnenden Akteure, zu denen auch die Selbstverwaltungspartner gehören, die die Budgetverhandlungen auf der Landesebene durchführen, dazu verpflichtet, „Unterstützungsangebote zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen“ bereitzustellen, und dass „die jeweiligen Kosten [...] bei der Vereinbarung der Ausbildungsbudgets berücksichtigt“ werden⁷. In der Praxis wird dem allerdings keine Rechnung getragen, obwohl der Arbeitskräftesicherung in den Pflegeberufen ein hohes öffentliches Interesse zukommen sollte und die gesellschaftlichen Folgekosten um einiges höher ausfallen dürften.

Ein weiterer Finanzierungsbedarf der Pflegeschulen, der bis heute nicht systematisch geregelt ist, sind die Miet- und Investitionskosten der freien, also nicht an ein Krankenhaus gebundenen Pflegeschulen, bei denen es sich größtenteils um die ehemaligen Fachseminare für Altenpflege handelt.

Als DRK haben wir hierauf bereits bei der Einführung der Ausbildung zur Pflegefachperson hingewiesen⁸. Die ursprünglich angedachte Lösung, dass sich Bund und Länder die Miet- und Investitionskosten der Pflegeschulen teilen, konnte nicht realisiert werden. Stattdessen wurden allein die Bundesländer in die Verantwortung gesetzt, die allerdings bereits mit der Finanzierung der Investitionskosten für die Leistungserbringung in den Krankenhäusern, Einrichtungen und Diensten überfordert sind.

Die Folgen sind bis heute spürbar, denn die Finanzierung der Miet- und Investitionskosten der Pflegeschulen wird bundesweit höchst unterschiedlich gehandhabt und hängt unmittelbar vom politischen Willen und den damit verbundenen Prioritäten im jeweiligen Bundesland zusammen. Dem gilt es dringend entgegenzuwirken, denn für die Einführung der Pflegefachassistentenausbildung und die damit verbundenen (nicht zuletzt durch die höheren Qualitätsanforderungen ausgelöst) Umgestaltungs- und Entwicklungsprozesse vor Ort ist eine betriebswirtschaftlich kostendeckende Finanzstruktur unumgänglich.

Auch wenn in einzelnen Bundesländern Lösungen zur Finanzierung der Schulsozialarbeit sowie der Miet- und Investitionskosten der Pflegeschulen gefunden wurden, sieht das DRK eine systematische und regelhafte Finanzierungsmöglichkeit auf der Landesebene nur durch eine Aufnahme dieser Kostenarten in die Anlage 1 zur PflAFinV in expressis verbis gegeben.

Darüber hinaus müssen auch die Kosten für die Ausstattung, Instandhaltung sowie die Abschreibungen der Räumlichkeiten Berücksichtigung finden (sogenannte Raumkosten). Die Erfahrung zeigt, dass diese in manchen Bundesländern weder den Miet- noch den Investitionskosten zugerechnet werden, oder nur für Neugründungen gelten. Gleichzeitig sind die Pflegeschulen nach § 8 verpflichtet, die „für die Ausbildung erforderlichen Räume und Einrichtungen“ zur Verfügung zu stellen.

Änderungsbedarfe

Ergänzung der Anlage 1 zur PflAFinV um die Kosten der Pflegeschulen für Schulsozialarbeit sowie deren Miet- und Investitionskosten (inklusive Raumkosten)

Artikel 6: „Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch“

Zu § 54a: „Einstiegsqualifizierung“ in Verbindung mit § 57: „Förderungsfähige Berufsausbildung“

Die Aufnahme der Pflegefachassistentenausbildung in die Tatbestände der betrieblichen Einstiegsqualifizierung nach § 54a SGB III und die förderungsfähigen Berufsausbildungen nach § 57 SGB III wird sehr begrüßt.

Gerade die Öffnung für die Förderinstrumente nach dem SGB III, wie die Assistierte Berufsausbildung, die Berufsausbildungsbeihilfe, den Mobilitätzuschuss oder die begleitete betriebliche Ausbildung, kann zur Sicherung des Ausbildungserfolgs von Auszubildenden mit geringer Schulbildung und/oder mit (Lern-)Behinderung beitragen. Ebenso wird eine Förderung nach dem BAföG ermöglicht.

C. Kontakt

Christian Hener

C.Hener@drk.de

Referent für Pflegeberufe und Kompetenzentwicklung in der Pflege

Team Gesundheit, Seniorenarbeit und Pflege

Deutsches Rotes Kreuz e.V., Generalsekretariat

Benjamin Fehrecke-Harpke

B.Fehrecke@drk.de

Koordination Altenhilfe/ Stv. Leitung

Team Gesundheit, Seniorenarbeit und Pflege

Deutsches Rotes Kreuz e.V., Generalsekretariat

Quellenangaben

¹ **Deutsche Aidshilfe** (Hg.) (2009). Factsheet. HIV und Arbeit. Online im Internet:

https://www.aidshilfe.de/sites/default/files/documents/positivarbeiten_-_factsheet_hiv_und_arbeit_0.pdf [02.10.2025]

² **Diakonie Deutschland** (Hg.) (2023). Aufgabenprofile akademisch qualifizierter Pflegefachpersonen. Empfehlungen der Arbeitsgruppe der Ausbildungsoffensive Pflege (2019 – 2023). Online im Internet:

https://www.pflegeausbildung.net/fileadmin/de.altenpflegeausbildung/content.de/user_upload/231010_Empfehlungen_AQP_final.pdf [02.10.2025]

³ **Think Tank Vorbehaltsaufgaben** (TT VA) & **Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V.** (DGP) (Hg.) (2024) Vorbehaltsaufgaben der Pflege – Pflegewissenschaftliche und pflegerechtliche Grundlegung und Einordnung. Online im Internet: <https://dg-pflegewissenschaft.de/wp-content/uploads/2024/03/Vorbehaltsaufgaben-Broschuere-DGP-1.pdf> [02.10.2025]

⁴ **Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts** vom 24.07.2024. Online im Internet:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/07/PD24_284_212.html [02.10.2025]

⁵ **Quon, E. C., & McGrath, J. J.** (2014). Subjective socioeconomic status and adolescent health: a meta-analysis. *Health Psychology*, 33(5), 433. Online im Internet:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5756083/pdf/nihms6738.pdf> [02.10.2025]

⁶ **Netzwerkstelle Pflegehilfe** im DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt (Hg.) (2025). Das Projekt „Assistierte Ausbildung für die Pflegehilfe“. Online im Internet:

<https://www.pflegeberufe-sachsen-anhalt.de/de/ausbildung/daten-des-projektes-kontaktdaten> [02.10.2025]

⁷ **Abschlussbericht der Ausbildungsoffensive Pflege** (2019 - 2023). Online im Internet:

<https://www.bmfsfj.de/resource/blob/246064/f0b267c1e82c553f73c21fe7993be593/ausbildungsoffensive-pflege-2019-2023-abschlussbericht-data.pdf> [02.10.2025]

⁸ **Deutsches Ärzteblatt** (Hg.) (2019). DRK bemängelt fehlende Finanzierung der

Pflegesschulen. Online im Internet: <https://www.aerzteblatt.de/news/drk-bemaengelt-fehlende-finanzierung-der-pflegesschulen-4f043dd8-8181-430e-ae22-a94adedc877f> [02.10.2025]